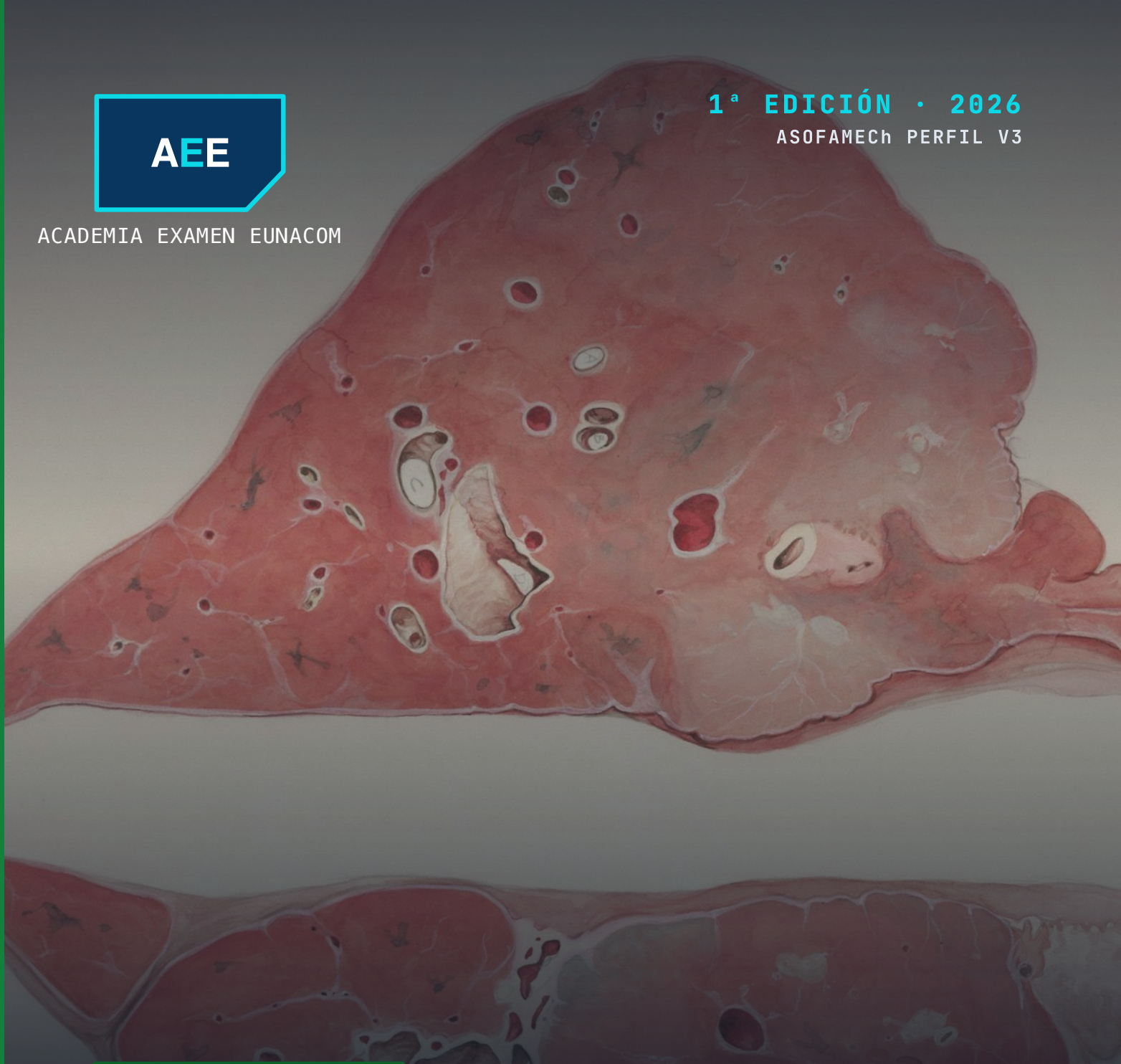
AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 03 · GH · ATLAS

ATLAS DE IMÁGENES EUNACOM ·

GASTROENTEROLOGÍA

Lo que tienes que ver en cada foto, y qué hacer después

102	25	7
IMÁGENES COMENTADAS CON MARCADORES	TEMAS, EN EL ORDEN DEL TOMO	PARES «PARECIDAS PERO DISTINTAS»

Módulo 1 · Medicina Interna · complemento visual del Tomo 03

Índice por tema

Cómo usarlo. Mira primero la foto y busca tú los hallazgos; después compara con los marcadores numerados y con «Qué tienes que ver». Cierra con la conducta y la pregunta real del pie. Al final, pruébate sin respuestas en la Autoevaluación.

Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento. «Tomo p.» = página del Tomo 03 donde se trata esa imagen o su tema.

Parecidas pero distintas 55

Índice por tipo de imagen 61

Soluciones de la autoevaluación 68

Signos con nombre propio 59

Autoevaluación 62

01 Esófago y Estómago

1.1 Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett

01 Esofagitis erosiva por reflujo 4
02 Esofagitis erosiva 4
03 Esófago de Barrett 5

1.2 Úlcera Péptica, Dispepsia Funcional y Helicobacter pylori

04 Úlcera duodenal con mancha pigmentada 5
05 Úlcera gástrica (Forrest IIc) 6

1.3 Disfagia y Trastornos Motores del Esófago

06 Cáncer de esófago distal 6
07 Megaesófago chagásico 7
08 Manometría de alta resolución: acalasia 7
09 Divertículo de Zenker 8
10 Divertículo de Zenker en el esofagograma 8

1.4 Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáustico

11 Neumoperitoneo 9
12 Síndrome de Mallory-Weiss 9
13 Esofagitis cáustica 10
14 Síndrome de Boerhaave 10
15 Neumoperitoneo bajo el diafragma 11

1.5 Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico

16 Cáncer gástrico avanzado: Borrmann I a IV 11
17 Esquema de Borrmann 12
18 Tumor de músculo liso gástrico (estudio baritado) 12
19 Cáncer gástrico incipiente 13

1.6 Hernia Hiatal, Hernia Diafragmática y Tumores del Mediastino

20 Hernia hiatal paraesofágica 13
21 Compartimentos del mediastino 14
22 Masa del mediastino anterior 14
23 Hernia diafragmática traumática 15
24 Masa mediastínica anterior en la TAC 15
25 Masa mediastínica en el PET-CT 16

02 Intestino y Colon

2.2 Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación

26 Colitis pseudomembranosa (C. difficile) 16
27 Trofozoítos de Giardia 17
28 Huevo de Ascaris 17
29 Huevo de tricocéfalo 18

2.3 Síndrome de Malabsorción, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa

30 Dermatitis herpetiforme 18
31 Atrofia vellositaria (enfermedad celíaca) 19

2.4 Enfermedad Inflamatoria Intestinal

32 Colitis ulcerosa 19
33 Enfermedad de Crohn 20
34 Crohn: íleon terminal engrosado 20
35 Eritema nodoso 21
36 Pioderma gangrenoso 21
37 Eritema nodoso en la EII 22
38 Pioderma gangrenoso 22

2.5 Pólipos y Cáncer Colorrectal · Tamizaje

39 Pólipo pediculado 23
40 Pólipo sésil 23
41 Pólipo pediculado en la colonoscopía 24
42 Cáncer colorrectal en la colonoscopía 24
43 Poliposis adenomatosa familiar (pieza) 25

Índice por tema · continuación

2.6 Patología Perianal

44 Fisura anal 25
45 Prolapso hemorroidal grado IV 26
46 Hemorroide externo trombosado 26
47 Hemorroide externo trombosado 27
48 Absceso perianal 27
49 Absceso perianal 28

03 Hígado

3.1 Ictericia y Colestasia

50 Ictericia escleral 28
51 Colédoco dilatado por coledocolitiasis 29
52 Coledocolitiasis en colangiorresonancia 29
53 Ictericia escleral 30
54 Cáncer de la cabeza del páncreas 30

3.2 Hepatitis Aguda y Crónica

55 Hepatitis B aguda: marcadores en el tiempo 31
56 Esteatosis hepática 31

3.3 Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal

57 Cirrosis en la ecografía 32
58 Portografía: colaterales 32
59 Cabeza de medusa 33
60 Várice esofágica con ligadura 33

3.4 Lesiones Hepáticas Focales y Pólipos Vesiculares

61 Quiste hidatídico hepático 34
62 Hemangioma hepático 34
63 Hepatocarcinoma en TAC trifásico 35
64 Absceso hepático 35
65 Hiperplasia nodular focal 36
66 Metástasis hepáticas 36
67 Pólipo vesicular 37
68 Colangiocarcinoma hiliar (Klatskin) 37

04 Vía Biliar y Páncreas

4.1 Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis

69 Colelitiasis 38
70 Vesícula con cálculos 38
71 Colecistitis aguda 39
72 Vesícula en porcelana 39

4.2 Pancreatitis Aguda

73 Pancreatitis edematosa en la TAC 40
74 Pancreatitis aguda edematosa 40
75 Signo de Grey Turner 41

05 Abdomen Agudo y Urgencias Digestivas

5.1 Abdomen Agudo

76 Apendicitis: puntos y signos del examen 41
77 Apendicitis aguda en TAC 42
78 Apendicitis flemonosa (pieza) 42

5.2 Isquemia Mesentérica y Abdomen Agudo de Origen Vascular

79 Trombosis venosa mesentérica 43
80 Colitis isquémica: «huellas digitales» 43
81 Embolia de la arteria mesentérica superior 44

5.3 Hemorragia Digestiva Alta y Baja

82 Úlcera con vaso visible (Forrest IIa) 44
83 Úlcera con sangrado activo (Forrest Ia) 45

5.4 Cuerpo Extraño Digestivo

84 Moneda en el esófago 45
85 Pila de botón ingerida 46
86 Bolo de carne impactado 46

06 Gastroenterología y Cirugía Pediátrica

6.1 Diarrea Aguda y Crónica en el Niño

87 Signo del pliegue 47
88 Signo del pliegue persistente 47
89 Huevos de oxiuros 48

6.2 Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño

90 Estenosis hipertrófica del píloro 48
91 Ecografía: oliva pilórica 49
92 Fecaloma en un niño 49

6.3 Cirugía Pediátrica Digestiva

93 Neumatosis intestinal (enterocolitis necrotizante) 50
94 Invaginación intestinal: signo de la dona 50
95 Invaginación: el intestino como un telescopio 51
96 Atresia esofágica 51
97 Enfermedad de Hirschsprung: zona de transición 52

6.4 Trauma Abdominal y Torácico

98 Eco FAST positiva 52
99 Rotura esplénica 53
100 Contusión pulmonar en la TAC de tórax 53
101 Taponamiento cardíaco en trauma 54
102 Derrame pericárdico en la ecografía 54

01 TEMA 1.1 · ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO Y ESÓFAGO DE BARRETT

ENDOSCOPÍA

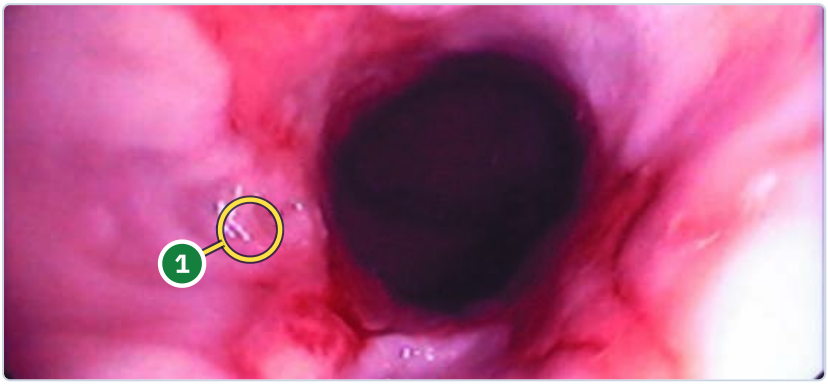


Imagen: Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 26

QUÉ TIENES QUE VER

1 Erosiones lineales en el esófago distal

DIAGNÓSTICO

Esofagitis erosiva por reflujo

Erosiones lineales rojas justo sobre la unión con el estómago: daño directo del ácido.

CONDUCTA INICIAL

Sin alarma y < 50 años: IBP en ayunas, 30-60 min antes de comer; con signos de alarma, endoscopía.

1.06.1.027 Reflujo gastroesofágico — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

1.06.4.007 Endoscopía digestiva alta y baja — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Esófago de Barrett: lengüetas color salmón, no erosiones.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2019 · P84 «Un hombre de 30 años presenta pirosis frecuente, por lo que se solicita una endoscopía digestiva alta, que muestra una esofagitis por reflujo,...» → **Indicar inhibidores de la bomba de protones**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 7** Tema 1.1

Clase 1.1 en video

02 TEMA 1.1 · ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO Y ESÓFAGO DE BARRETT

ENDOSCOPÍA

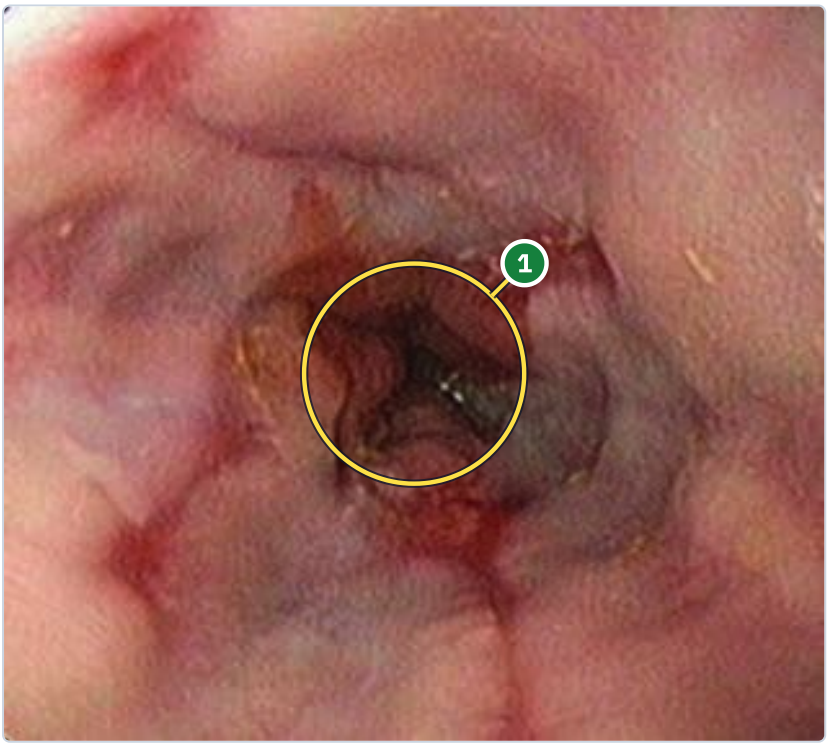


Imagen: Harrison's Principles of Internal Medicine, 21.ª ed., p. 2471

QUÉ TIENES QUE VER

1 Erosiones en la unión escamocolumnar

DIAGNÓSTICO

Esofagitis erosiva

Erosiones rojas lineales sobre la unión esófago-gástrica.

CONDUCTA INICIAL

IBP 8 semanas; endoscopía si hay síntomas de alarma.

1.06.1.027 Reflujo gastroesofágico — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

1.06.4.007 Endoscopía digestiva alta y baja — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Esófago de Barrett: mucosa asalmonada que sube, sin erosión.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 7** Tema 1.1

Clase 1.1 en video

03 TEMA 1.1 · ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO Y ESÓFAGO DE BARRETT

ENDOSCOPÍA

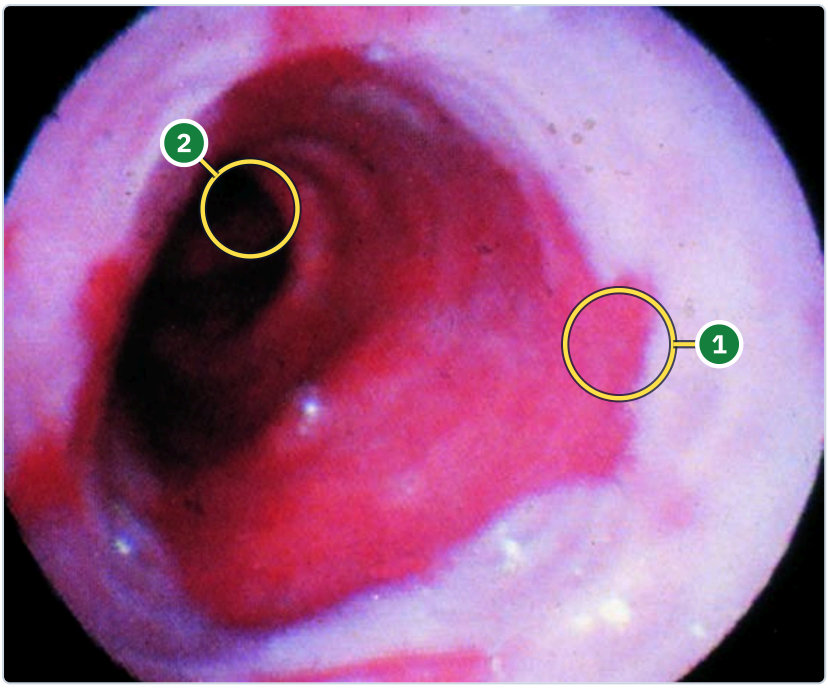


Imagen: Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 27

QUÉ TIENES QUE VER

1. Lengüeta salmón
2. Mucosa esofágica pálida normal

DIAGNÓSTICO

Esófago de Barrett

Lengüetas color salmón que suben sobre la mucosa pálida: metaplasia intestinal.

CONDUCTA INICIAL

Biopsia: lo que decide la conducta es la displasia, no la metaplasia; IBP y vigilancia endoscópica.

1.06.1.027 **Reflujo gastroesofágico**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

1.06.4.007 **Endoscopía digestiva alta y baja**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Esofagitis erosiva: erosiones rojas lineales.

PREGUNTA REAL

Julio 2017 · P38 «Un paciente de 27 años, con historia de pirosis y regurgitación de algunos meses de evolución, siendo diagnosticado de reflujo gastroesofágico....» → **Tratamiento quirúrgico**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 7** Tema 1.1

Clase 1.1 en video

04 TEMA 1.2 · ÚLCERA PÉPTICA, DISPEPSIA FUNCIONAL Y HELICOBACTER PYLORI

ENDOSCOPÍA

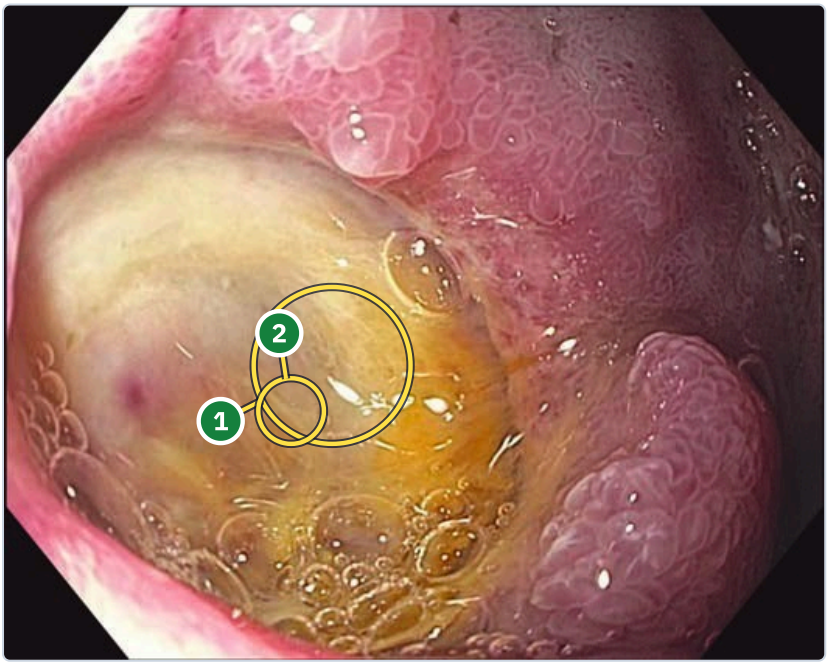


Imagen: Harrison 21.ª ed., p. 2430

QUÉ TIENES QUE VER

1. Fondo de fibrina de la úlcera
2. Mancha pigmentada en la base

DIAGNÓSTICO

Úlcera duodenal con mancha pigmentada

Úlcera duodenal con un estigma de sangrado reciente en la base; no se maligniza.

CONDUCTA INICIAL

Erradicar H. pylori aunque el test sea negativo: IBP + amoxicilina + claritromicina 14 días.

1.06.1.030 **Úlcera péptica**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Úlcera gástrica: exige biopsia del borde por riesgo de cáncer.

PREGUNTA REAL

Julio 2013 · P12 «Paciente de 27 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por cuadro de 3 meses de dolor epigástrico tipo urente que aumenta durante los periodos...» → **Iniciar omeprazol, amoxicilina y claritromicina**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 11** Tema 1.2

Clase 1.2 en video

05 TEMA 1.2 · ÚLCERA PÉPTICA, DISPEPSIA FUNCIONAL Y HELICOBACTER PYLORI

ENDOSCOPÍA

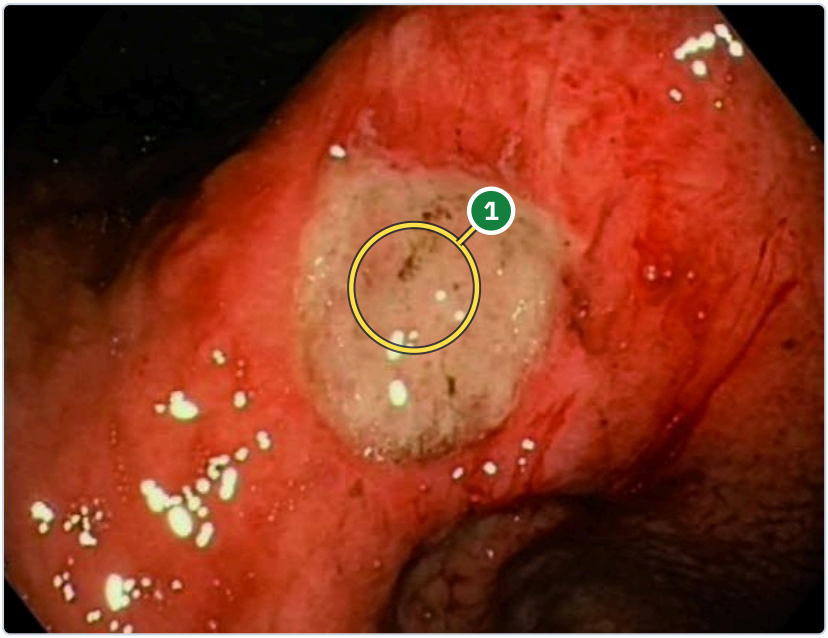


Imagen: Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 63

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cráter con fondo de fibrina

DIAGNÓSTICO

Úlcera gástrica (Forrest IIc)

Cráter de bordes regulares con fondo de fibrina y puntos de hematina.

CONDUCTA INICIAL

Biopsia del borde y endoscopía de control tras el tratamiento.

1.06.1.030	Úlcera péptica	Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo
1.06.4.007	Endoscopía digestiva alta y baja	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Cáncer gástrico Borrmann II: úlcera de bordes elevados.

PREGUNTA REAL

Julio 2015 · P124 «Un paciente es diagnosticado de úlcera gástrica, con test de ureasa positiva, por lo que se inicia tratamiento con amoxicilina 1g cada 12 horas,...» → **Indicar tratamiento erradicador de segunda línea**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 11** Tema 1.2

Clase 1.2 en video

06 TEMA 1.3 · DISFAGIA Y TRASTORNOS MOTORES DEL ESÓFAGO

ENDOSCOPÍA

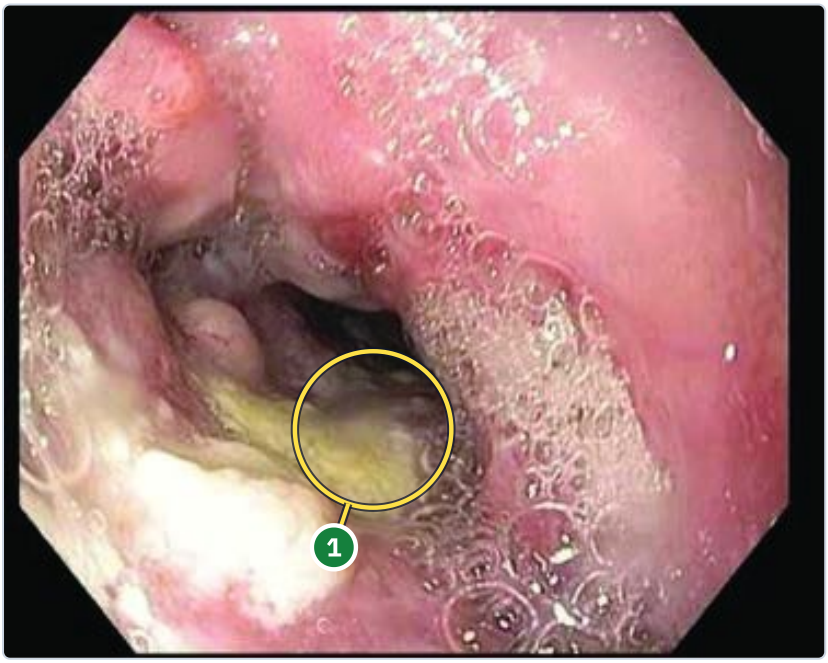


Imagen: Harrison 21.ª ed., p. 2460

QUÉ TIENES QUE VER

1 Masa ulcerada que estrecha la luz

DIAGNÓSTICO

Cáncer de esófago distal

Lesión irregular y ulcerada que estrecha la luz: disfagia lógica.

CONDUCTA INICIAL

Endoscopía con biopsia (no manometría ni esofagograma).

4.01.1.005	Cáncer del esófago	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
1.06.1.013	Disfagia	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Acalasia: disfagia ilógica, sin masa.

PREGUNTA REAL

Julio 2013 · P22 «Paciente de 80 años, con antecedente de hipertensión, diabetes insulinodependiente con mal control metabólico y epigastralgia en tratamiento...» → **Cáncer esofágico**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 15** Tema 1.3

Clase 1.3 en video

07 TEMA 1.3 · DISFAGIA Y TRASTORNOS MOTORES DEL ESÓFAGO

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Wikimedia Commons «Chagas megaseophagus.JPG», Public domain, autor en Commons

QUÉ TIENES QUE VER

1. Esófago muy dilatado

DIAGNÓSTICO

Megaesófago chagásico

Esófago muy dilatado y lleno de contraste; disfagia ilógica como en la acalasia.

CONDUCTA INICIAL

Serología de Chagas en quien vivió en zona endémica.

1.06.1.013 Disfagia

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Acalasia idiopática: misma imagen.

PREGUNTA REAL

Julio 2019 · P38 «Una paciente de 56 años, con antecedente de haber vivido en Brasil, hasta hace 6 meses, consulta por disfagia lógica y progresiva, asociada a…» → **Cáncer de esófago**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 15** Tema 1.3

Clase 1.3 en video

08 TEMA 1.3 · DISFAGIA Y TRASTORNOS MOTORES DEL ESÓFAGO

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

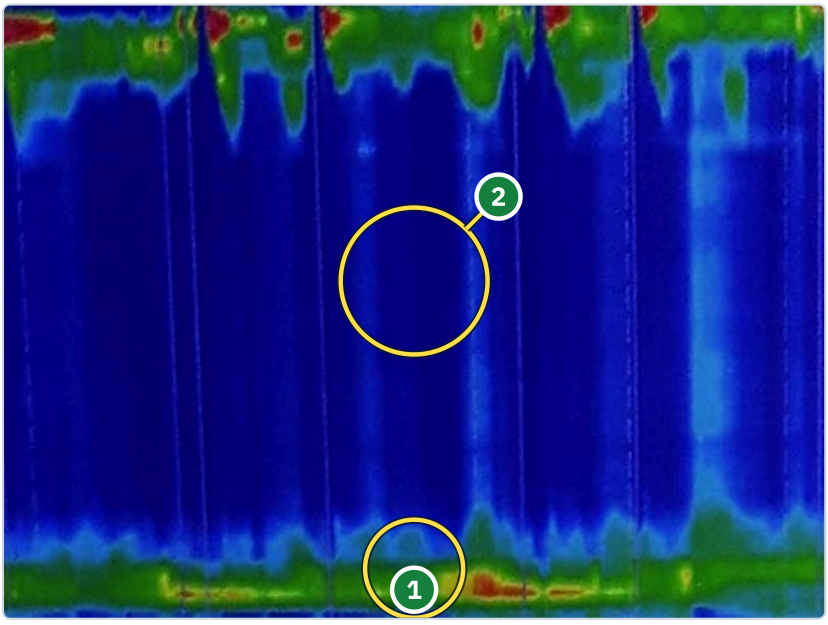


Imagen: Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 18

QUÉ TIENES QUE VER

1. EEI hipertónico que no se relaja
2. Cuerpo sin ondas peristálticas

DIAGNÓSTICO

Manometría de alta resolución: acalasia

Esfínter inferior que no se relaja y cuerpo sin peristalsis.

CONDUCTA INICIAL

La manometría es el examen de elección en la disfagia ilógica.

4.01.1.004 Acalasia

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Esclerodermia: EEI hipotónico con aperistalsis.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P43 «Un paciente de 70 años consulta por dificultad para tragar de 2 años de evolución, que se presenta tanto al ingerir alimentos sólidos como…» → **Acalasia esofágica**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 15** Tema 1.3

Clase 1.3 en video

09 TEMA 1.3 · DISFAGIA Y TRASTORNOS MOTORES DEL ESÓFAGO

IMAGEN RADIOLÓGICA

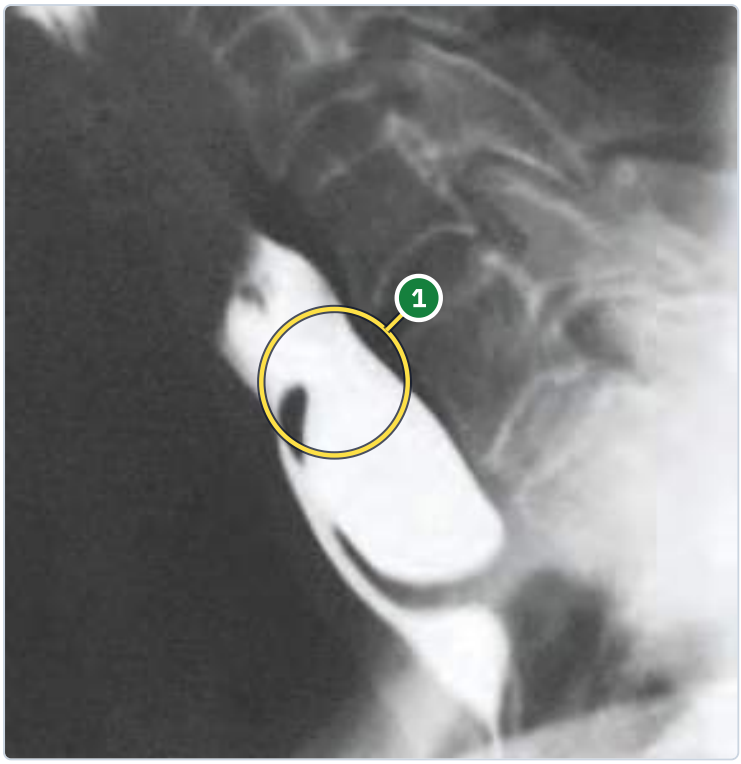


Imagen: Bailey & Love's Short Practice of Surgery, 27th ed., p. 1123

QUÉ TIENES QUE VER

1 Saco del divertículo con bario

DIAGNÓSTICO

Divertículo de Zenker

Saco en el esfínter esofágico superior: disfagia alta con halitosis.

CONDUCTA INICIAL

Esofagograma con bario; tratamiento quirúrgico.

4.01.1.002	Divertículos esofágicos	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
1.06.1.013	Disfagia	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Cáncer de esófago: disfagia lógica sin halitosis.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P112 «Un paciente de 80 años consulta por dificultades para comer, caracterizada por disfagia alta intermitente, tanto para alimentos sólidos como…» → **Divertículo de Zenker**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 15 Tema 1.3

Clase 1.3 en video

10 TEMA 1.3 · DISFAGIA Y TRASTORNOS MOTORES DEL ESÓFAGO

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Harrison 21.ª ed., Fig. 322-56

QUÉ TIENES QUE VER

1 Saco diverticular (flecha)

DIAGNÓSTICO

Divertículo de Zenker en el esofagograma

Saco con bario en la parte alta del esófago, por detrás.

CONDUCTA INICIAL

Sintomático: cirugía o miotomía endoscópica; no pasar sonda a ciegas.

4.01.1.002	Divertículos esofágicos	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
1.06.1.013	Disfagia	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Acalasia: esófago dilatado en pico de pájaro distal.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P112 «Un paciente de 80 años consulta por dificultades para comer, caracterizada por disfagia alta intermitente, tanto para alimentos sólidos como…» → **Divertículo de Zenker**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 15 Tema 1.3

Clase 1.3 en video

11 TEMA 1.4 · ÚLCERA PERFORADA, PERFORACIÓN ESOFÁGICA E INGESTA DE CÁUSTICO

IMAGEN RADIOLÓGICA

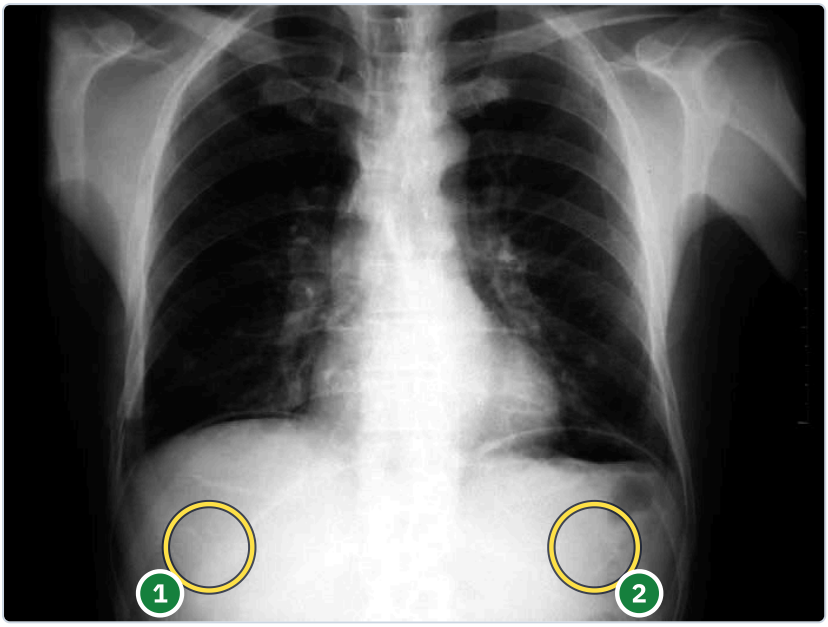


Imagen: Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 65

QUÉ TIENES QUE VER

1. Aire bajo el diafragma
2. Aire bajo el diafragma

DIAGNÓSTICO

Neumoperitoneo

Aire libre bajo ambos hemidiafragmas en la Rx de tórax de pie.

CONDUCTA INICIAL

Perforación de víscera hueca: cirugía de urgencia.

4.01.2.003	Peritonitis	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar
1.06.1.030	Úlcera péptica	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Cámara gástrica: solo a la izquierda, con nivel.

PREGUNTA REAL

Julio 2019 · P162 «Un paciente de 43 años presenta dolor epigástrico urente, de un mes de evolución. Hace 24 horas deja de eliminar gases y el dolor se vuelve…» → **Perforación de úlcera péptica**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA
p. 18
Tema 1.4

Clase 1.4 en video

12 TEMA 1.4 · ÚLCERA PERFORADA, PERFORACIÓN ESOFÁGICA E INGESTA DE CÁUSTICO

ENDOSCOPÍA

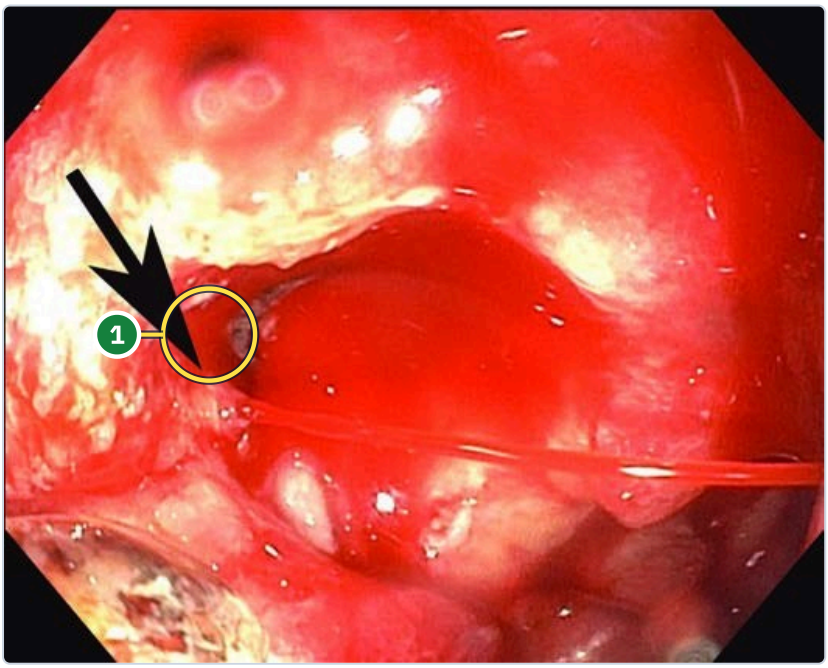


Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1. Desgarro mucoso (flecha)

DIAGNÓSTICO

Síndrome de Mallory-Weiss

Desgarro de la mucosa en la unión gastroesofágica tras vómitos, con sangre fresca.

CONDUCTA INICIAL

Autolimitado y de buen pronóstico; terapia endoscópica si sigue sangrando.

4.01.2.019	Perforación esofágica - Mediastinitis	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
1.06.2.007	Hemorragia digestiva alta y baja	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Boerhaave: perforación transmural con aire en el mediastino.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P36 «Un niño de 3 años de edad es traído al servicio de urgencia, ya que desde hace 24 horas que ha presentado diarrea y múltiples episodios de…» → **Síndrome de Mallory Weiss**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA
p. 18
Tema 1.4

Clase 1.4 en video

13 TEMA 1.4 · ÚLCERA PERFORADA, PERFORACIÓN ESOFÁGICA E INGESTA DE CÁUSTICO

ENDOSCOPÍA

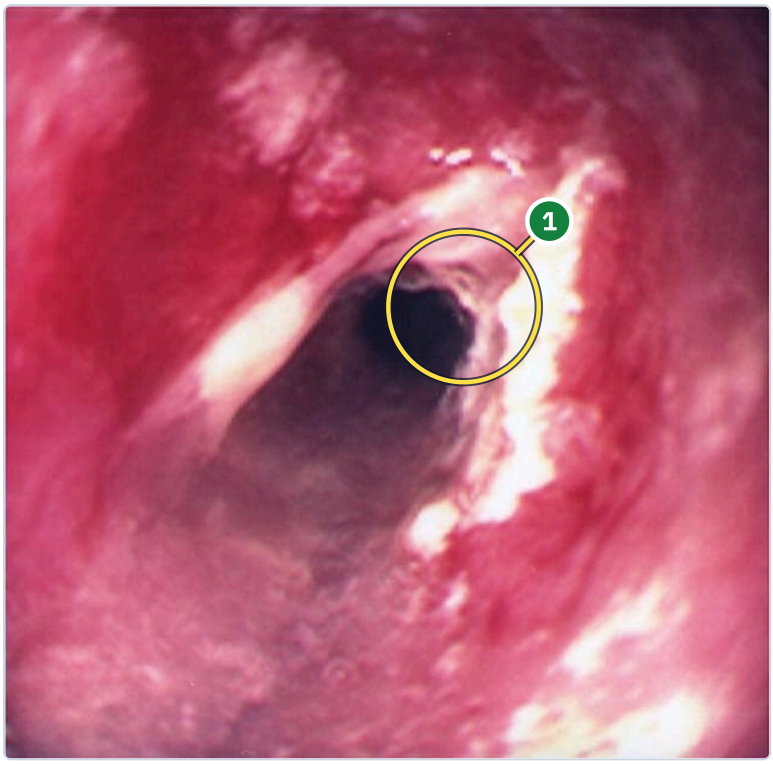


Imagen: Knoop, Atlas of Emergency Medicine, p. 633

QUÉ TIENES QUE VER

1 Mucosa necrótica con exudado

DIAGNÓSTICO

Esofagitis cáustica

Mucosa quemada con exudado y estenosis incipiente tras ingerir soda cáustica.

CONDUCTA INICIAL

Endoscopía precoz define la conducta; carbón activado y lavado gástrico contraindicados.

4.01.2.001 **Esofagitis cáustica**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Esofagitis por reflujo: erosiones distales.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 18** Tema 1.4

Clase 1.4 en video

14 TEMA 1.4 · ÚLCERA PERFORADA, PERFORACIÓN ESOFÁGICA E INGESTA DE CÁUSTICO

IMAGEN RADIOLÓGICA

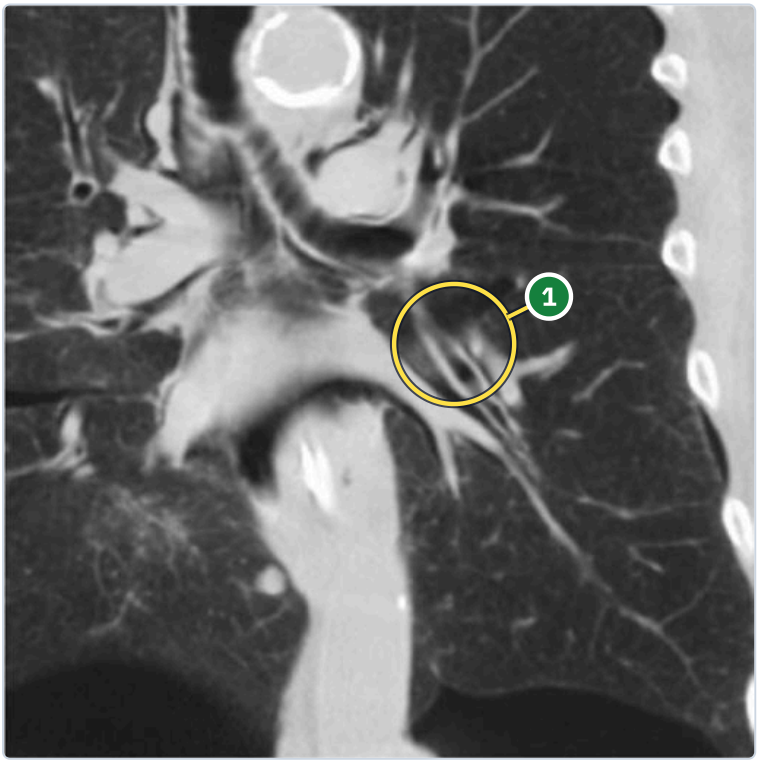


Imagen: Herring, Learning Radiology, 4.ª ed., p. 361

QUÉ TIENES QUE VER

1 Aire que delinea el mediastino

DIAGNÓSTICO

Síndrome de Boerhaave

Vómitos y luego dolor torácico con neumomediastino y enfisema subcutáneo.

CONDUCTA INICIAL

TAC de tórax y cirugía; la endoscopía no es el primer examen.

4.01.2.019 **Perforación esofágica - Mediastinitis**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Mallory-Weiss: hematemesis sin aire extraluminal.

PREGUNTA REAL

Julio 2013 · P154 «Paciente de 43 años, con historia de epigastralgia desde hace 3 semanas sin otros síntomas, como parte del estudio de su patología se realiza…» → **Tomografía axial computada de tórax**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 20** Tema 1.4

Clase 1.4 en video

15 TEMA 1.4 · ÚLCERA PERFORADA, PERFORACIÓN ESOFÁGICA E INGESTA DE CÁUSTICO

IMAGEN RADIOLÓGICA

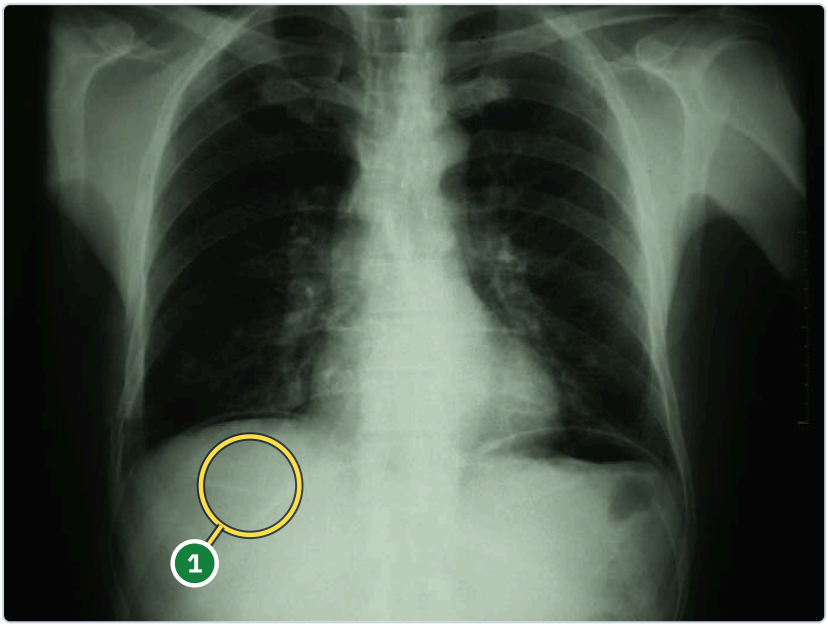


Imagen: Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 65

QUÉ TIENES QUE VER

1. Aire bajo el hemidiafragma derecho

DIAGNÓSTICO

Neumoperitoneo bajo el diafragma

Media luna de aire bajo el diafragma en la radiografía de tórax de pie.

CONDUCTA INICIAL

Úlcera perforada: cirugía urgente; la endoscopía está contraindicada.

4.01.2.003	Peritonitis	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar
1.06.1.030	Úlcera péptica	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Signo de Chilaiditi: colon interpuesto, con haustras.

PREGUNTA REAL

Julio 2019 · P162 «Un paciente de 43 años presenta dolor epigástrico urente, de un mes de evolución. Hace 24 horas deja de eliminar gases y el dolor se vuelve…» → **Perforación de úlcera péptica**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 18** Tema 1.4

Clase 1.4 en video

16 TEMA 1.5 · CÁNCER DE ESÓFAGO Y CÁNCER GÁSTRICO

ENDOSCOPÍA

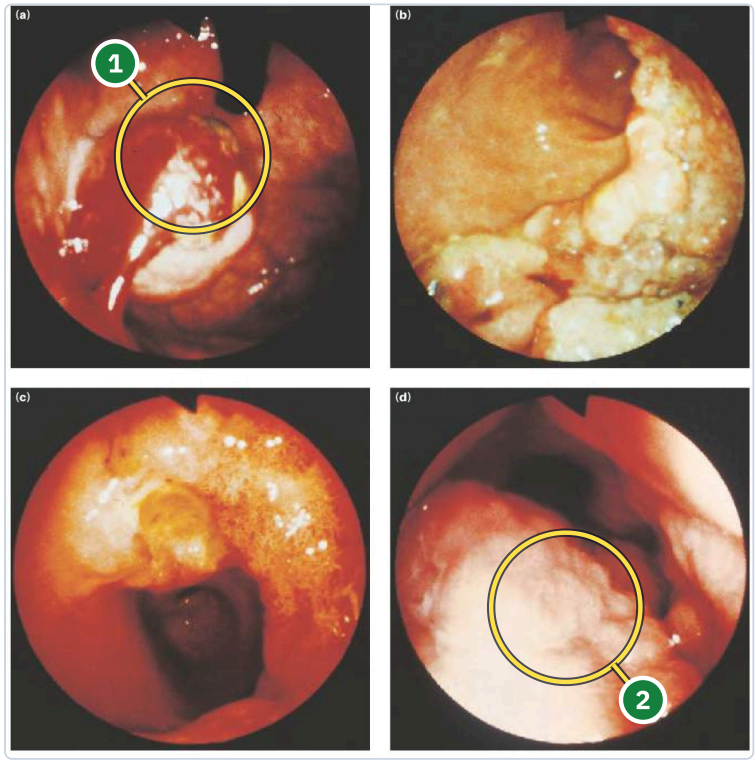


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 63.29

QUÉ TIENES QUE VER

1. (a) Tipo I: masa polipoide
2. (d) Tipo IV: infiltra toda la pared

DIAGNÓSTICO

Cáncer gástrico avanzado: Borrmann I a IV

I polipoide, II úlcera de bordes netos, III úlcera infiltrante, IV linitis plástica.

CONDUCTA INICIAL

Epigastralgia ≥ 40 años o con signos de alarma: endoscopía con biopsias (GES).

1.06.1.004	Cáncer gástrico	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
4.01.1.008	Cáncer gástrico	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Úlcera gástrica benigna: bordes regulares y fondo limpio.

PREGUNTA REAL

Julio 2019 · P91 «Un hombre de 57 años presenta epigastralgia, inapetencia y baja de peso, de 2 meses de evolución, a lo cual se agrega un episodio de melena, por…» → **Cáncer gástrico**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 22** Tema 1.5

Clase 1.5 en video

17 TEMA 1.5 · CÁNCER DE ESÓFAGO Y CÁNCER GÁSTRICO

ESQUEMA

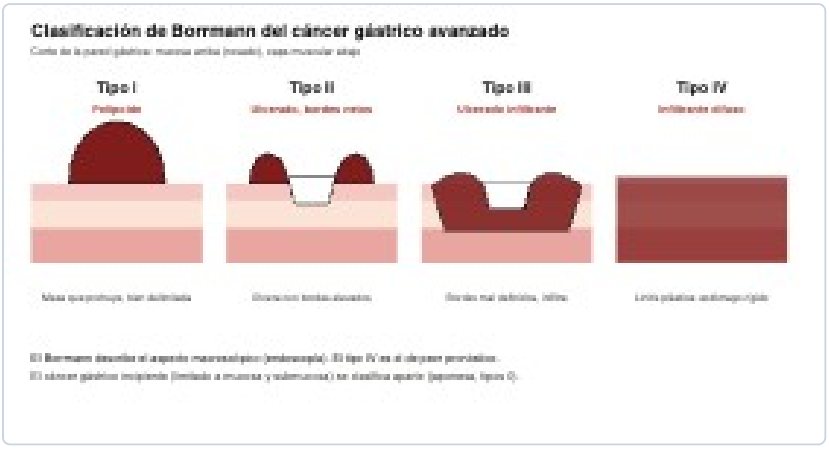


Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

- Tipo I a III: crecen hacia la luz o la ulceran
- Tipo IV: linitis plástica, estómago rígido

DIAGNÓSTICO

Esquema de Borrmann

El tipo IV casi no se ve desde adentro porque infiltra la pared.

CONDUCTA INICIAL

El factor pronóstico principal es la invasión transmural.

1.06.1.004 Cáncer gástrico — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Cáncer incipiente: limitado a mucosa y submucosa (clasificación japonesa).

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 22** Tema 1.5

Clase 1.5 en video

18 TEMA 1.5 · CÁNCER DE ESÓFAGO Y CÁNCER GÁSTRICO

IMAGEN RADIOLÓGICA

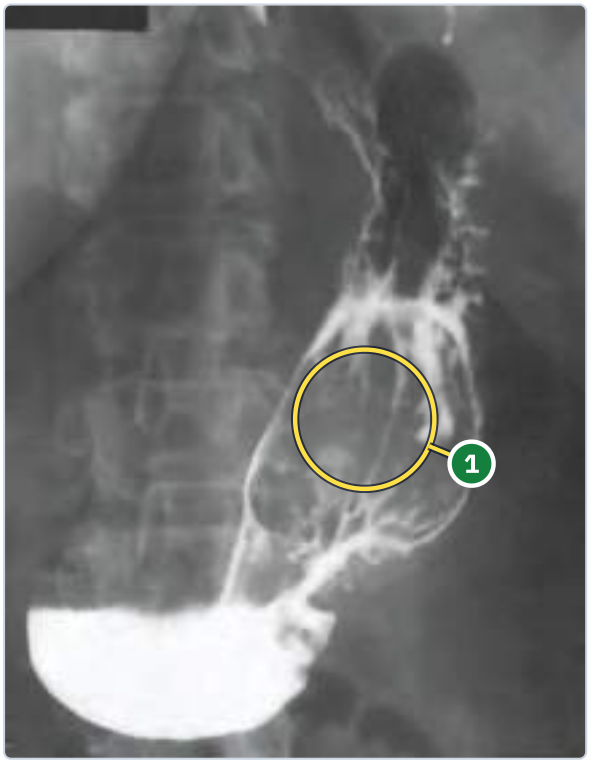


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., p. 1150

QUÉ TIENES QUE VER

1. Defecto de llenado de bordes lisos

DIAGNÓSTICO

Tumor de músculo liso gástrico (estudio baritado)

Defecto de llenado redondeado y liso en el estómago.

CONDUCTA INICIAL

Endoscopía con biopsia y TAC; GIST se reseca.

1.06.1.004 Cáncer gástrico — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Cáncer gástrico: borde irregular y ulcerado.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 22** Tema 1.5

Clase 1.5 en video

19 TEMA 1.5 · CÁNCER DE ESÓFAGO Y CÁNCER GÁSTRICO

ENDOSCOPÍA



Imagen: Bailey & Love's Short Practice of Surgery, 27.ª ed., p. 1154

QUÉ TIENES QUE VER

1 Lesión elevada irregular

DIAGNÓSTICO

Cáncer gástrico incipiente

Lesión elevada blanquecina e irregular en la mucosa gástrica.

CONDUCTA INICIAL

Biopsia; incipiente (mucosa o submucosa): resección endoscópica o cirugía.

1.06.1.004	Cáncer gástrico	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
4.01.1.008	Cáncer gástrico	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pólipo hiperplásico: liso y de aspecto benigno.

PREGUNTA REAL

Julio 2019 · P91 «Un hombre de 57 años presenta epigastralgia, inapetencia y baja de peso, de 2 meses de evolución, a lo cual se agrega un episodio de melena, por…» → **Cáncer gástrico**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 22** Tema 1.5

Clase 1.5 en video

20 TEMA 1.6 · HERNIA HIATAL, HERNIA DIAFRAGMÁTICA Y TUMORES DEL MEDIASTINO

IMAGEN RADIOLÓGICA

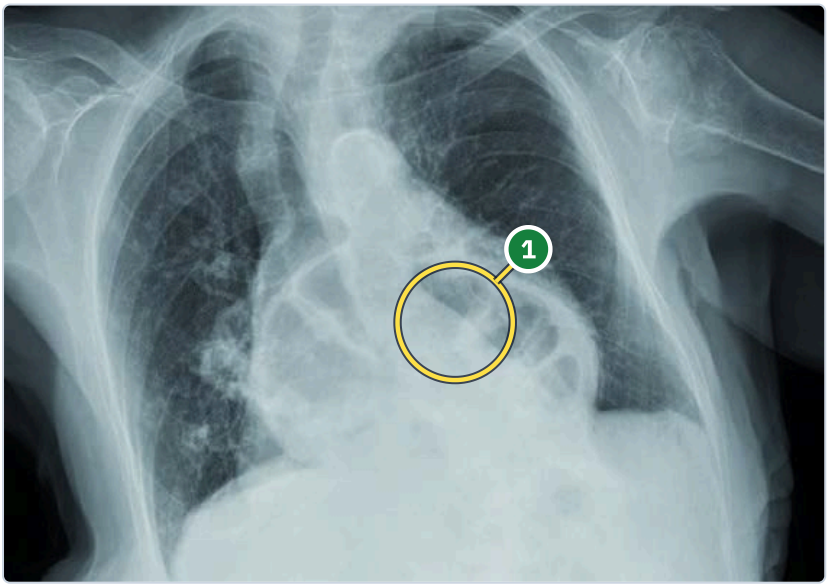


Imagen: Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 35

QUÉ TIENES QUE VER

1 Aire retrocardíaco

DIAGNÓSTICO

Hernia hiatal paraesofágica

Imagen redonda con aire detrás de la silueta cardíaca: estómago en el tórax.

CONDUCTA INICIAL

Cirugía electiva por riesgo de vólvulo y estrangulación.

4.01.1.006	Hernia hiatal	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hernia por deslizamiento: casi normal, solo se trata el reflujo.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 25** Tema 1.6

Clase 1.6 en video

21 TEMA 1.6 · HERNIA HIATAL, HERNIA DIAFRAGMÁTICA Y TUMORES DEL MEDIASTINO

ESQUEMA

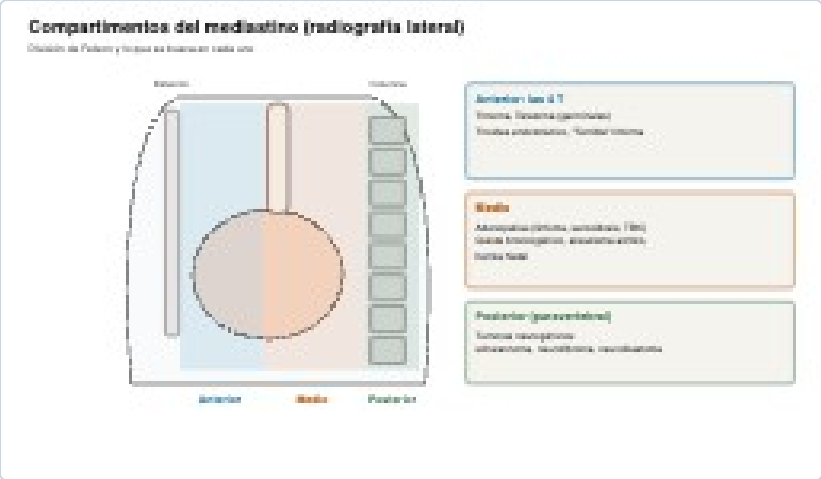


Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

- Anterior: timoma, teratoma, tiroides, «terrible» linfoma
- Toda masa: TAC de tórax con contraste

DIAGNÓSTICO

Compartimentos del mediastino

Anterior: las 4 T; medio: adenopatías y quistes; posterior: tumores neurogénicos.

CONDUCTA INICIAL

Timoma + miastenia gravis: timectomía.

4.01.1.041 **Síndromes mediastínicos**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hernia hiatal: retrocardíaca, con nivel hidroaéreo.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 25** Tema 1.6

Clase 1.6 en video

22 TEMA 1.6 · HERNIA HIATAL, HERNIA DIAFRAGMÁTICA Y TUMORES DEL MEDIASTINO

IMAGEN RADIOLÓGICA

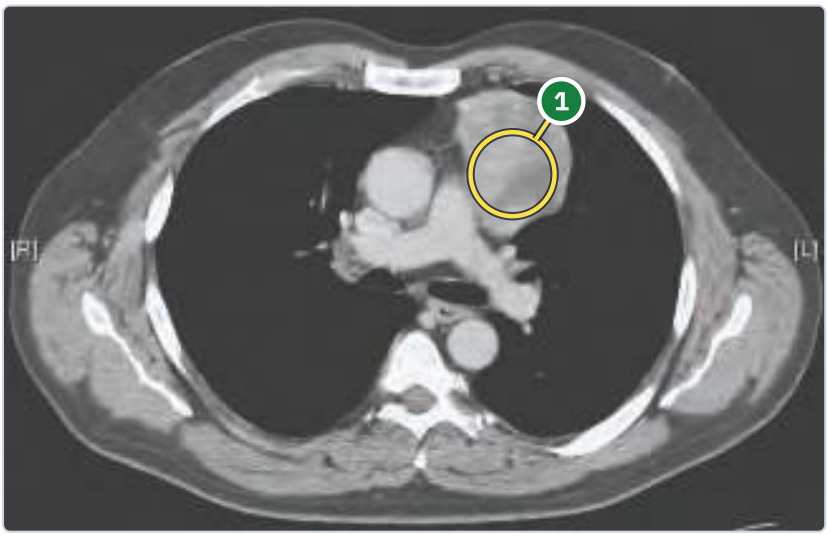


Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1. Masa anterior a los grandes vasos

DIAGNÓSTICO

Masa del mediastino anterior

Masa delante de los grandes vasos en la TAC con contraste.

CONDUCTA INICIAL

TAC de tórax con contraste; pensar en las 4 T.

4.01.1.041 **Síndromes mediastínicos**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Aneurisma aórtico: realza como la aorta.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 25** Tema 1.6

Clase 1.6 en video

23 TEMA 1.6 · HERNIA HIATAL, HERNIA DIAFRAGMÁTICA Y TUMORES DEL MEDIASTINO

IMAGEN RADIOLÓGICA

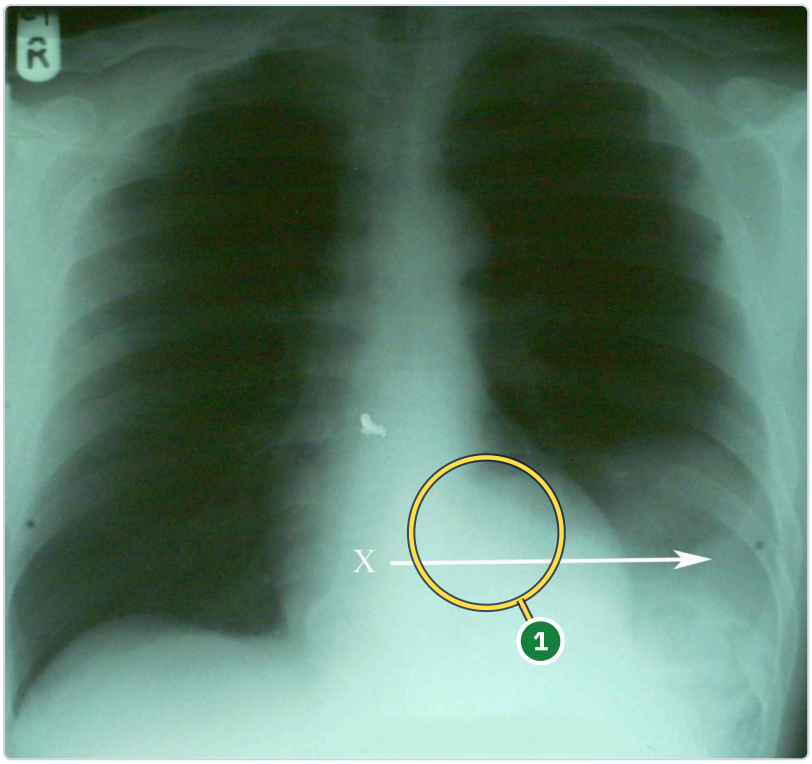


Imagen: Wikimedia Commons, CC BY 2.0

QUÉ TIENES QUE VER

1. Contenido abdominal sobre el diafragma

DIAGNÓSTICO

Hernia diafragmática traumática

Estómago o asas en el hemitórax izquierdo tras un trauma.

CONDUCTA INICIAL

Aguda: cirugía urgente; crónica: cirugía electiva. Nunca se observa.

4.01.1.040 **Hernias diafragmáticas traumáticas y congénitas**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Derrame pleural o elevación diafragmática.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 25** Tema 1.6

Clase 1.6 en video

24 TEMA 1.6 · HERNIA HIATAL, HERNIA DIAFRAGMÁTICA Y TUMORES DEL MEDIASTINO

IMAGEN RADIOLÓGICA

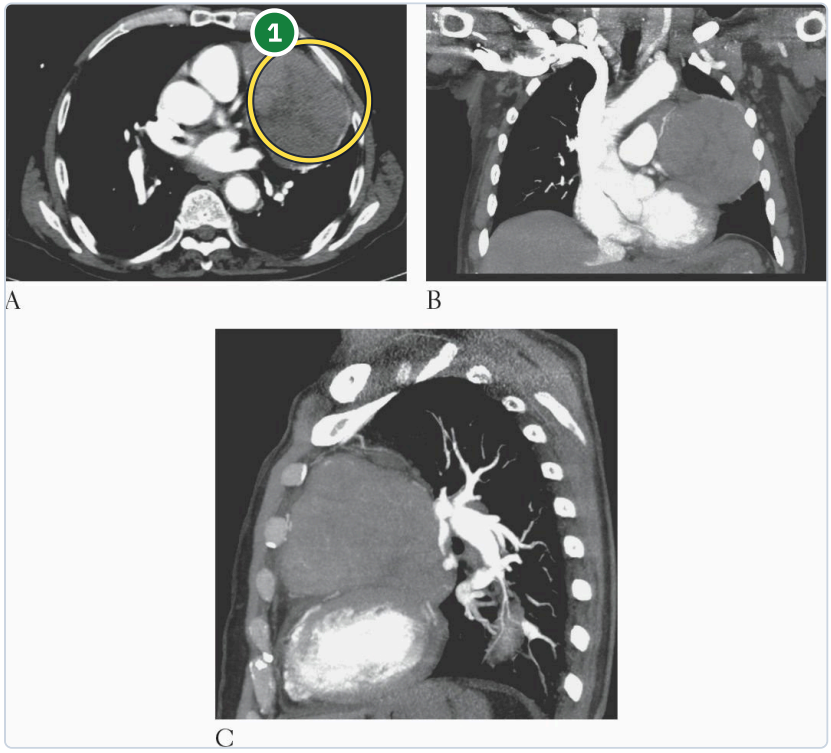


Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 256

QUÉ TIENES QUE VER

1. Masa mediastínica

DIAGNÓSTICO

Masa mediastínica anterior en la TAC

Masa del mediastino anterior en cortes axial, coronal y sagital.

CONDUCTA INICIAL

TAC con contraste y biopsia; las 4 T: timoma, teratoma, tiroides, linfoma.

4.01.1.041 **Síndromes mediastínicos**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hernia hiatal: tiene aire o contraste del estómago.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 25** Tema 1.6

Clase 1.6 en video

25 TEMA 1.6 · HERNIA HIATAL, HERNIA DIAFRAGMÁTICA Y TUMORES DEL MEDIASTINO

IMAGEN RADIOLÓGICA

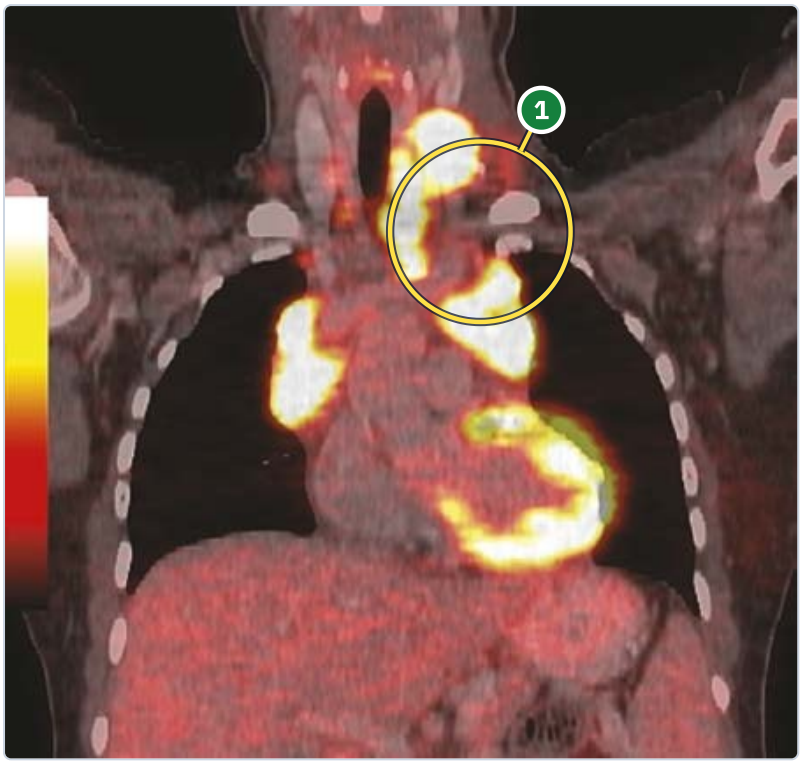


Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22nd ed., p. 3984

QUÉ TIENES QUE VER

1 Masas hipercaptantes

DIAGNÓSTICO

Masa mediastínica en el PET-CT

Captación intensa de las masas del mediastino.

CONDUCTA INICIAL

El PET-CT etapifica linfomas y guía la biopsia.

4.01.1.041 **Síndromes mediastínicos**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Captación fisiológica del corazón.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 25** Tema 1.6

Clase 1.6 en video

26 TEMA 2.2 · DIARREA AGUDA, DIARREA CRÓNICA Y CONSTIPACIÓN

ENDOSCOPÍA



Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pseudomembranas amarillentas

DIAGNÓSTICO

Colitis pseudomembranosa (C. difficile)

Placas amarillentas sobre la mucosa del colon tras antibióticos.

CONDUCTA INICIAL

PCR de toxina; metronidazol y, si falla, vancomicina oral; evaluar la respuesta clínica.

1.04.1.009 **Diarrea asociada a antibióticos**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

1.06.1.010 **Diarrea asociada a antibióticos**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

1.06.4.014 **Determinación toxina C difficile en deposiciones**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Colitis ulcerosa: sin pseudomembranas.

PREGUNTA REAL **Julio 2015 · P128** «Una paciente está en tratamiento con ciprofloxacino por una infección urinaria. Al séptimo día inicia diarrea acuosa, abundante, asociada a dolor…» → **Clostridium difficile**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 35** Tema 2.2

Clase 2.2 en video

27 TEMA 2.2 · DIARREA AGUDA, DIARREA CRÓNICA Y CONSTIPACIÓN

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

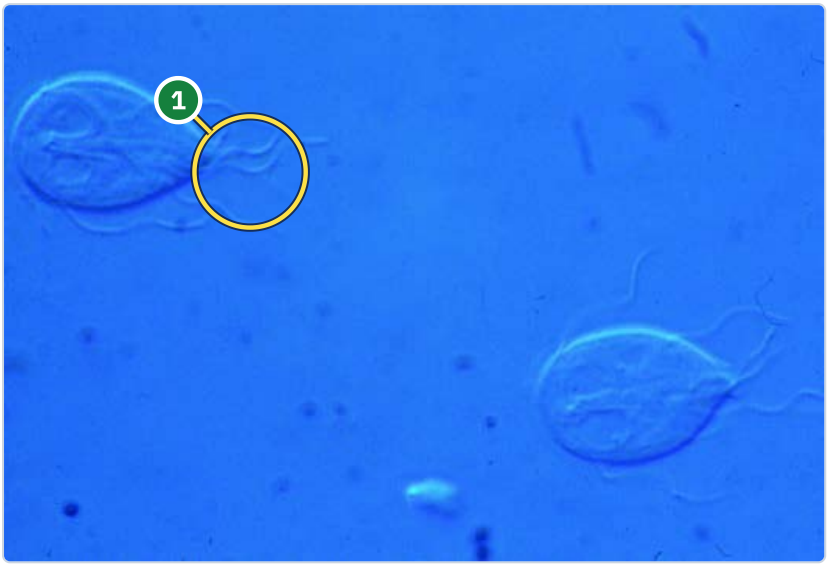


Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1 Trofozoíto piriforme con flagelos

DIAGNÓSTICO

Trofozoítos de Giardia

Trofozoítos en forma de pera con flagelos: diarrea con malabsorción.

CONDUCTA INICIAL

Tinidazol 2 g dosis única o metronidazol 5 días; descartarla antes de diagnosticar celíaca.

1.04.1.022 Parasitosis intestinales

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Enfermedad celíaca: también malabsorción.

PREGUNTA REAL

Julio 2018 · P39 «Un niño de 4 años es traído por su madre, ya que presenta un cuadro de 2 meses de evolución de diarrea intermitente, que dura 4 a 5 días, con…» → **Giardiasis intestinal**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 35 Tema 2.2

Clase 2.2 en video

28 TEMA 2.2 · DIARREA AGUDA, DIARREA CRÓNICA Y CONSTIPACIÓN

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

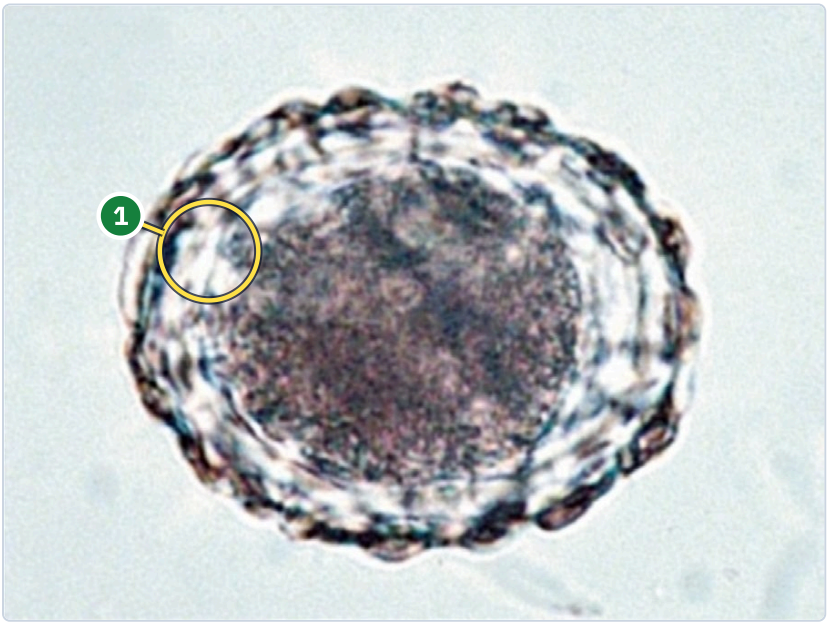


Imagen: Nelson 22.ª ed., p. 2813

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cubierta gruesa e irregular

DIAGNÓSTICO

Huevo de Ascaris

Huevo redondeado de cubierta irregular, mamelonada.

CONDUCTA INICIAL

Albendazol o mebendazol en dosis única.

1.04.1.022 Parasitosis intestinales

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Huevo de tricocéfalo: en barril con tapones.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 35 Tema 2.2

Clase 2.2 en video

29 TEMA 2.2 · DIARREA AGUDA, DIARREA CRÓNICA Y CONSTIPACIÓN

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA



Imagen: Nelson 22.ª ed., p. 2820

QUÉ TIENES QUE VER

1 Tapones polares

DIAGNÓSTICO

Huevo de tricocéfalo

Huevo alargado en barril con un tapón claro en cada extremo.

CONDUCTA INICIAL

Albendazol 3 días.

1.04.1.022 Parasitosis intestinales

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Huevo de Ascaris: redondo y mamelonado.

PREGUNTA REAL

Julio 2025 · P101 «Paciente de 45 años con diarrea crónica de 6 meses. Se realiza colonoscopía que muestra imágenes de parásitos adheridos a la mucosa del colon…» → **Trichuris trichiura (tricocefalosis)**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 35** Tema 2.2

Clase 2.2 en video

30 TEMA 2.3 · SÍNDROME DE MALABSORCIÓN, ENFERMEDAD CELÍACA E INTOLERANCIA A LA LACTOSA

FOTO CLÍNICA



Imagen: Harrison 21.ª ed., p. 413

QUÉ TIENES QUE VER

1 Lesiones agrupadas en el codo

DIAGNÓSTICO

Dermatitis herpetiforme

Pápulas y vesículas agrupadas y excoriadas en los codos: la celíaca de la piel.

CONDUCTA INICIAL

Responde a la dieta sin gluten; estudiar enfermedad celíaca.

1.06.1.015 Enfermedad celiaca

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Psoriasis: placas con escama gruesa, sin vesículas.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 39** Tema 2.3

Clase 2.3 en video

31 TEMA 2.3 · SÍNDROME DE MALABSORCIÓN, ENFERMEDAD CELÍACA E INTOLERANCIA A LA LACTOSA

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

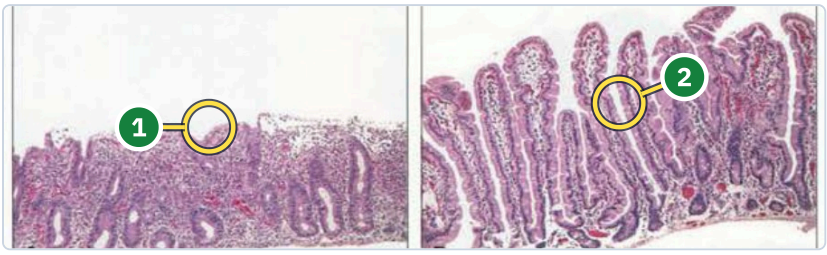


Imagen: Pathoma, Fig. 10.18

QUÉ TIENES QUE VER

1. Mucosa plana, sin vellosidades
2. Vellosidades normales para comparar

DIAGNÓSTICO

Atrofia vellositaria (enfermedad celíaca)

Mucosa plana sin vellosidades, hiperplasia de criptas y linfocitosis intraepitelial.

CONDUCTA INICIAL

Anti-transglutaminasa IgA + IgA total y biopsia duodenal comiendo gluten.

1.06.1.015 **Enfermedad celiaca**
Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Giardiasis: puede dar atrofia, descartarla primero.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2017 · P25 «Una paciente de 24 años, presenta un cuadro de amenorrea y baja de peso, asociada a náuseas y dolor abdominal de varios meses de evolución. Tiene…» → **Solicitar anticuerpos antitransglutaminasa**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA
p. 39
Tema 2.3

Clase 2.3 en video

32 TEMA 2.4 · ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

ENDOSCOPÍA

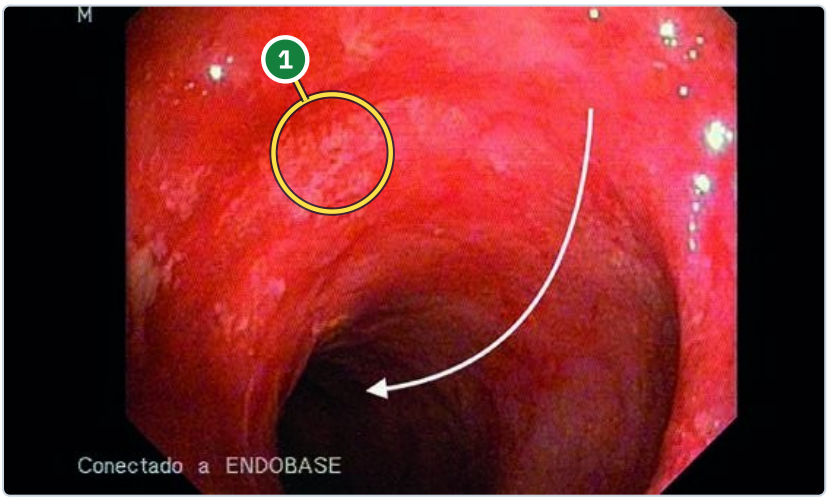


Imagen: Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 103

QUÉ TIENES QUE VER

1. Mucosa roja, granular y continua

DIAGNÓSTICO

Colitis ulcerosa

Mucosa inflamada de forma continua, roja y friable, sin zonas sanas.

CONDUCTA INICIAL

Joven con diarrea disentérica crónica: colonoscopía con biopsias.

1.06.1.018 **Enfermedad inflamatoria intestinal**
Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Crohn: úlceras en parches con mucosa sana entre ellas.

PREGUNTA REAL

Julio 2025 · P164 «Mujer de 35 años con diarrea crónica mucosanguinolenta de 6 meses de evolución, urgencia defecatoria, pujo y tenesmo. Colonoscopía: mucosa…» → **Colitis ulcerosa**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA
p. 42
Tema 2.4

Clase 2.4 en video

33 TEMA 2.4 · ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

ENDOSCOPÍA

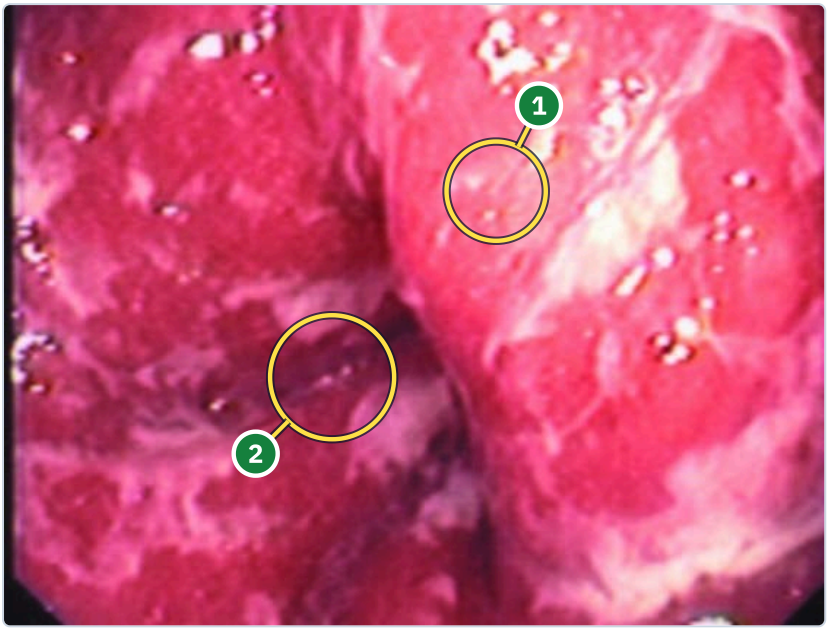


Imagen: Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 104

QUÉ TIENES QUE VER

1. Úlceras con fibrina
2. Mucosa de aspecto en empedrado

DIAGNÓSTICO

Enfermedad de Crohn

Úlceras con fibrina en parches sobre una mucosa irregular.

CONDUCTA INICIAL

Basta una característica de Crohn para diagnosticarlo; cirugía solo del segmento complicado.

1.06.1.018 Enfermedad inflamatoria intestinal

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Colitis ulcerosa: continua desde el recto.

PREGUNTA REAL **Julio 2025 · P163** «Joven de 25 años con diarrea crónica de 8 meses, 5-6 deposiciones al día sin sangre, pérdida de peso de 7 kg, úlceras orales recurrentes, dolor…» → **Enfermedad de Crohn**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 42** Tema 2.4

Clase 2.4 en video

34 TEMA 2.4 · ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

IMAGEN RADIOLÓGICA

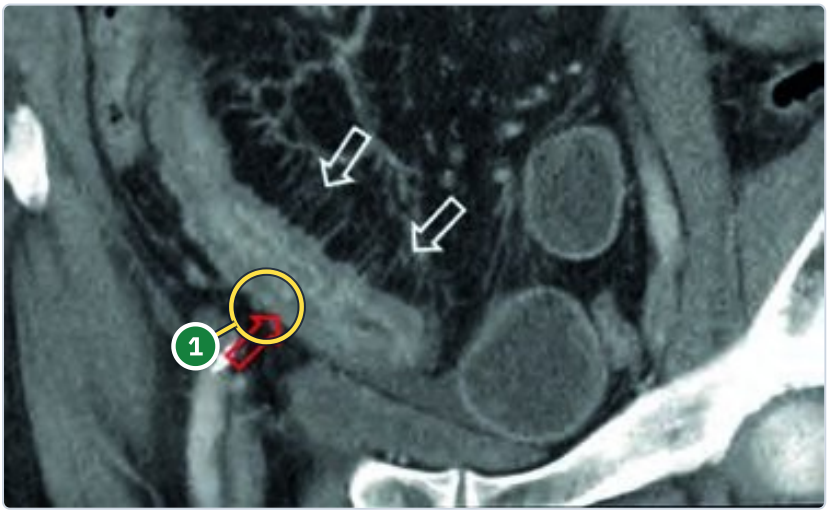


Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 40

QUÉ TIENES QUE VER

1. Íleon terminal engrosado (flecha roja)

DIAGNÓSTICO

Crohn: íleon terminal engrosado

Íleon terminal con la pared engrosada e hiperemia mesentérica.

CONDUCTA INICIAL

Localización ileal es de Crohn: la CU solo compromete el colon.

1.06.1.018 Enfermedad inflamatoria intestinal

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Apendicitis o linfoma ileal.

PREGUNTA REAL **Agosto 2021 · P110** «Un paciente de 25 años presenta un cuadro de 3 semanas de dolor abdominal tipo cólico y diarrea acuosa, que en ocasiones es sanguinolenta….» → **Enfermedad de Cröhn**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 43** Tema 2.4

Clase 2.4 en video

35 TEMA 2.4 · ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

FOTO CLÍNICA



Imagen: Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine, p. 611

QUÉ TIENES QUE VER

1 Nódulo eritematoso pretibial

DIAGNÓSTICO

Eritema nodoso

Nódulos rojos y dolorosos en las piernas: la manifestación cutánea más frecuente de la EII.

CONDUCTA INICIAL

Sigue la actividad intestinal: tratar la enfermedad de base.

1.06.1.018 Enfermedad inflamatoria intestinal

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pioderma gangrenoso: úlcera de bordes violáceos.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 42 Tema 2.4

Clase 2.4 en video

36 TEMA 2.4 · ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

FOTO CLÍNICA



Imagen: Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine, p. 338

QUÉ TIENES QUE VER

1 Borde violáceo socavado

DIAGNÓSTICO

Pioderma gangrenoso

Úlcera dolorosa de bordes violáceos socavados asociada a EII.

CONDUCTA INICIAL

No desbridar; tratar la EII y corticoides.

1.06.1.018 Enfermedad inflamatoria intestinal

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Úlcera infecciosa: no se agrava al desbridar.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 42 Tema 2.4

Clase 2.4 en video

37 TEMA 2.4 · ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

FOTO CLÍNICA



Imagen: Knoop, Atlas of Emergency Medicine, p. 415

QUÉ TIENES QUE VER

1 Nódulos dolorosos

DIAGNÓSTICO

Eritema nodoso en la EII

Nódulos rojo-violáceos dolorosos en la cara anterior de las piernas.

CONDUCTA INICIAL

Sigue la actividad de la enfermedad: tratar la EII.

1.06.1.018 Enfermedad inflamatoria intestinal

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pioderma gangrenoso: úlcera de borde violáceo.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 42 Tema 2.4

Clase 2.4 en video

38 TEMA 2.4 · ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

FOTO CLÍNICA

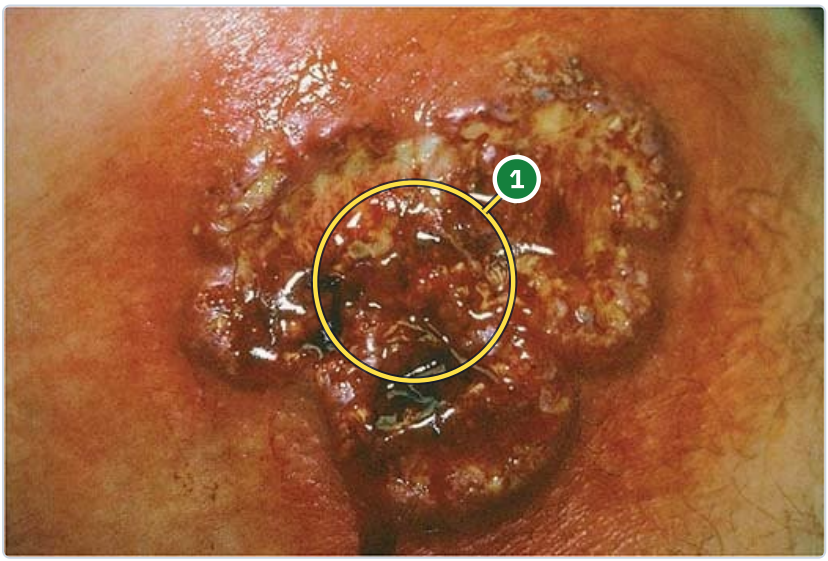


Imagen: Knoop, Atlas of Emergency Medicine, p. 413

QUÉ TIENES QUE VER

1 Borde violáceo socavado

DIAGNÓSTICO

Pioderma gangrenoso

Úlcera con fondo necrótico y borde violáceo socavado.

CONDUCTA INICIAL

Corticoides; no desbridar (patergia).

1.06.1.018 Enfermedad inflamatoria intestinal

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Úlcera infectada: mejora con aseo.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 42 Tema 2.4

Clase 2.4 en video

39 TEMA 2.5 · PÓLIPOS Y CÁNCER COLORRECTAL · TAMIZAJE

ENDOSCOPÍA

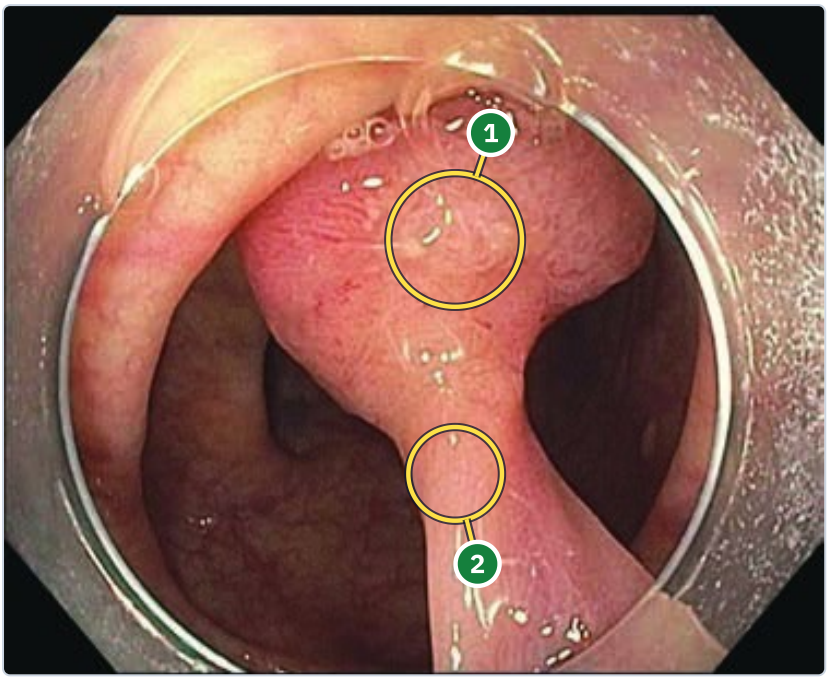


Imagen: Harrison 21.ª ed., p. 2433

QUÉ TIENES QUE VER

1. Cabeza del pólipo
2. Tallo (pedículo)

DIAGNÓSTICO

Pólipo pediculado

Cabeza sobre un tallo: se reseca con asa en la misma colonoscopía.

CONDUCTA INICIAL

Polipectomía y control en 1-3 años según número, tamaño e histología.

4.01.1.014	Pólipos de colon y recto	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
1.06.1.029	Tumores de colon	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pólipo sésil: base ancha, más riesgo.

PREGUNTA REAL

Enero 2023 · P175 «Paciente mayor de 50 años con pólipo resecado en colonoscopía: adenoma velloso con displasia de bajo grado. ¿Cuál es la conducta?» → **Colonoscopía de control en 3 años**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 47** Tema 2.5

Clase 2.5 en video

40 TEMA 2.5 · PÓLIPOS Y CÁNCER COLORRECTAL · TAMIZAJE

ENDOSCOPÍA

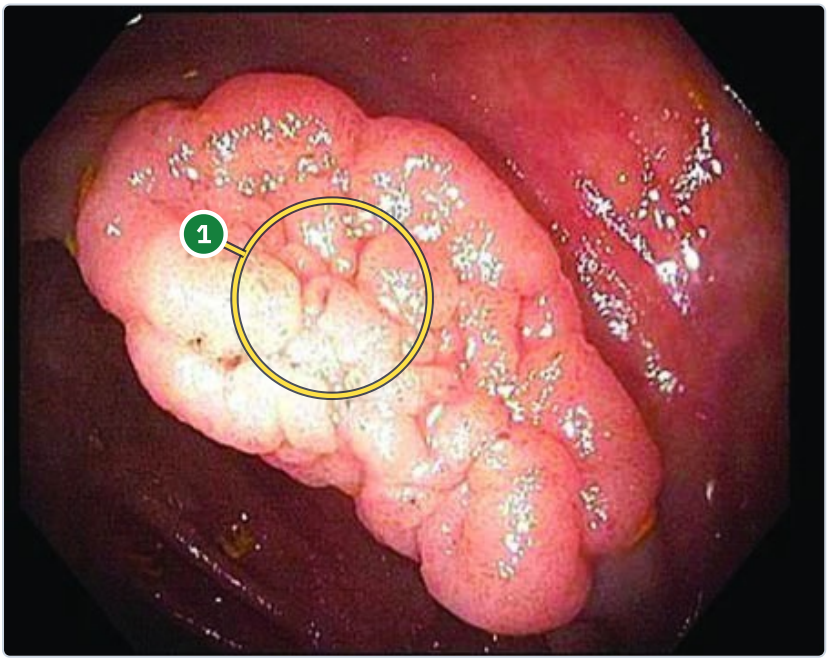


Imagen: Harrison 21.ª ed., p. 2433

QUÉ TIENES QUE VER

1. Pólipo de base ancha

DIAGNÓSTICO

Pólipo sésil

Base ancha y sin tallo: más difícil de resecar y con más riesgo de degenerar.

CONDUCTA INICIAL

Adenoma = precursor del cáncer: resecarlo previene el cáncer.

4.01.1.014	Pólipos de colon y recto	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
1.06.1.029	Tumores de colon	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pólipo pediculado: con tallo.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 47** Tema 2.5

Clase 2.5 en video

41 TEMA 2.5 · PÓLIPOS Y CÁNCER COLORRECTAL · TAMIZAJE

ENDOSCOPÍA

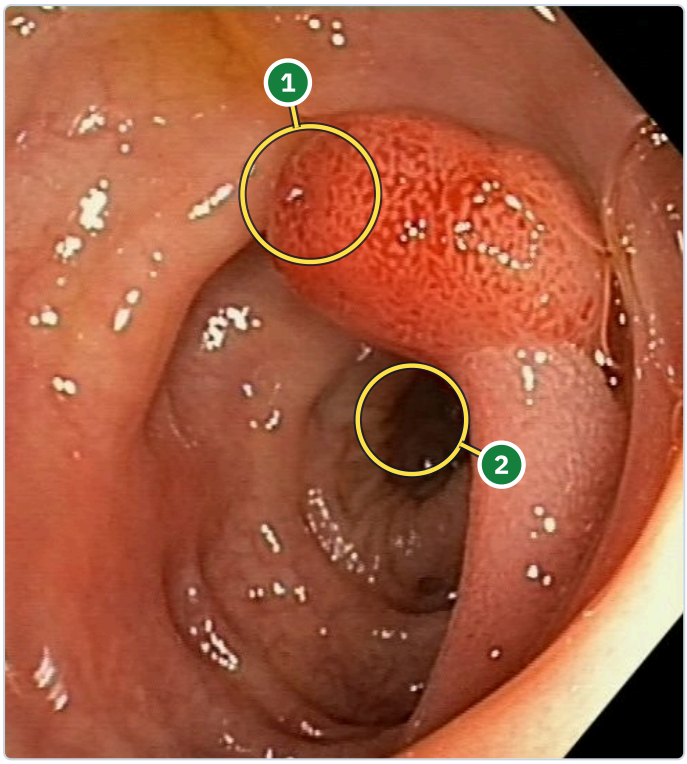


Imagen: Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 119

QUÉ TIENES QUE VER

1. Cabeza del pólipo
2. Tallo

DIAGNÓSTICO

Pólipo pediculado en la colonoscopía

Pólipo con cabeza lobulada y tallo.

CONDUCTA INICIAL

Polipectomía y biopsia; control según el informe.

4.01.1.014	Pólipos de colon y recto	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
1.06.1.029	Tumores de colon	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pólipo sésil: base ancha, sin tallo.

PREGUNTA REAL

Enero 2023 · P175 «Paciente mayor de 50 años con pólipo resecado en colonoscopía: adenoma velloso con displasia de bajo grado. ¿Cuál es la conducta?» → **Colonoscopía de control en 3 años**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 47** Tema 2.5

Clase 2.5 en video

42 TEMA 2.5 · PÓLIPOS Y CÁNCER COLORRECTAL · TAMIZAJE

ENDOSCOPÍA

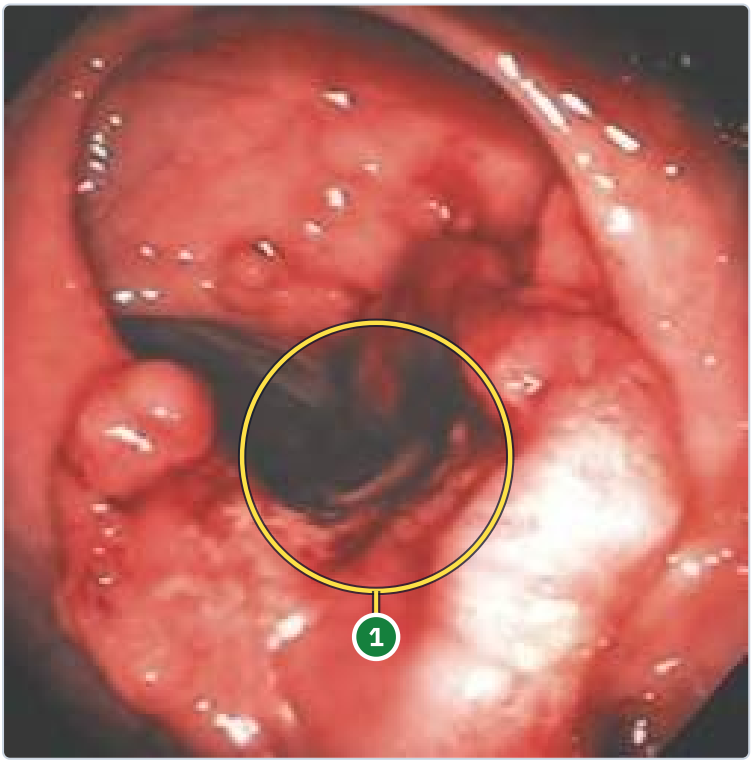


Imagen: Bailey & Love's Short Practice of Surgery, 27.ª ed., p. 1284

QUÉ TIENES QUE VER

1. Masa que estrecha la luz

DIAGNÓSTICO

Cáncer colorrectal en la colonoscopía

Masa ulcerada que estrecha la luz.

CONDUCTA INICIAL

Biopsia, CEA y TAC de etapificación; cirugía.

4.01.1.015	Cáncer colorectal	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
1.06.1.029	Tumores de colon	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Colitis: mucosa inflamada sin masa.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 47** Tema 2.5

Clase 2.5 en video

43 TEMA 2.5 · PÓLIPOS Y CÁNCER COLORRECTAL · TAMIZAJE

PIEZA ANATÓMICA



Imagen: Bailey & Love's Short Practice of Surgery, 27th ed., p. 257

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pólipos en toda la mucosa

DIAGNÓSTICO

Poliposis adenomatosa familiar (pieza)

Cientos de pólipos cubren todo el colon.

CONDUCTA INICIAL

Colectomía profiláctica; estudiar a la familia (APC).

4.01.1.014 Pólipos de colon y recto
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.06.1.029 Tumores de colon
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pólipos aislados: polipectomía basta.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO GASTROENTEROLOGÍA
p. 48
Tema 2.5

Clase 2.5 en video

44 TEMA 2.6 · PATOLOGÍA PERIANAL

FOTO CLÍNICA

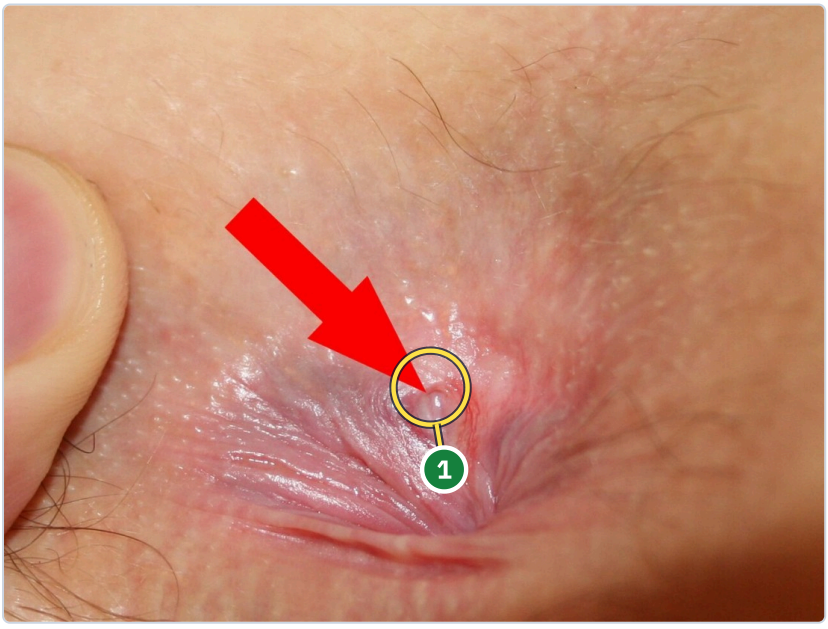


Imagen: Wikimedia Commons «Anal fissure 1.jpg», Public domain, Bernardo Gui

QUÉ TIENES QUE VER

1 Desgarro lineal (flecha)

DIAGNÓSTICO

Fisura anal

Desgarro lineal del anodermo en la línea media posterior; dolor que persiste minutos.

CONDUCTA INICIAL

Manejo médico: fibra, baños de asiento y relajante tópico; esfinterotomía interna si es crónica.

4.01.1.020 Fisura anorectal
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

4.01.1.016 Hemorroides - fisura anal
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Fístula: trayecto con orificio que supura, quirúrgica.

PREGUNTA REAL

Julio 2017 · P54 «Un paciente de 54 años consulta por dolor anal, que se presenta al defecar, persis- tiendo por algunos minutos luego de la defecación. En algunas…» → **Fisura anal**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA
p. 51
Tema 2.6

Clase 2.6 en video

45 TEMA 2.6 · PATOLOGÍA PERIANAL

FOTO CLÍNICA

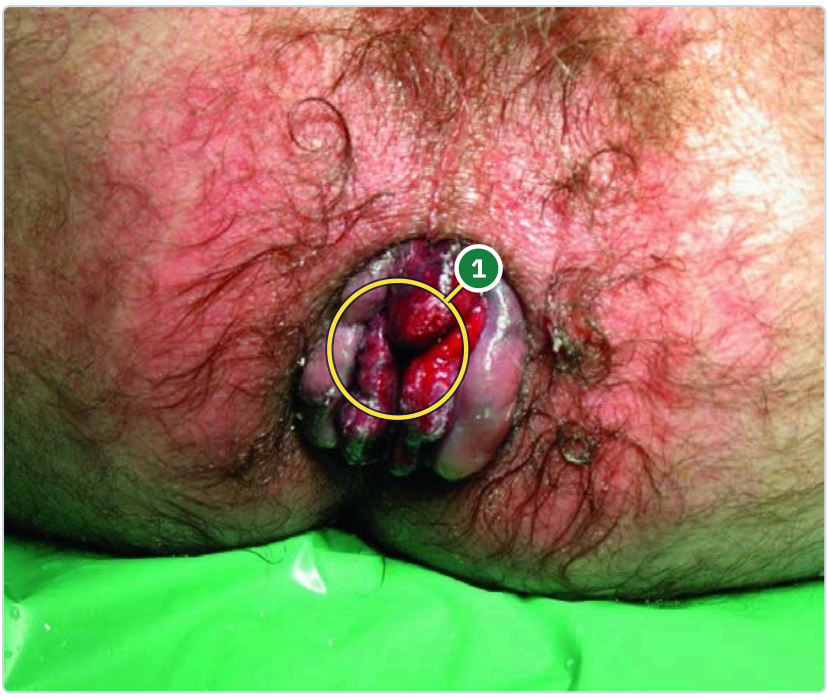


Imagen: Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 149

QUÉ TIENES QUE VER

1 Paquetes hemorroidales prolapsados

DIAGNÓSTICO

Prolapso hemorroidal grado IV

Hemorroides que salen y no se pueden reducir: grado quirúrgico.

CONDUCTA INICIAL

Hemorroidectomía; siempre descartar otras causas de hemorragia digestiva baja.

4.01.1.016 Hemorroides - fisura anal

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Prolapso rectal: pliegues concéntricos.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 51 Tema 2.6

Clase 2.6 en video

46 TEMA 2.6 · PATOLOGÍA PERIANAL

FOTO CLÍNICA

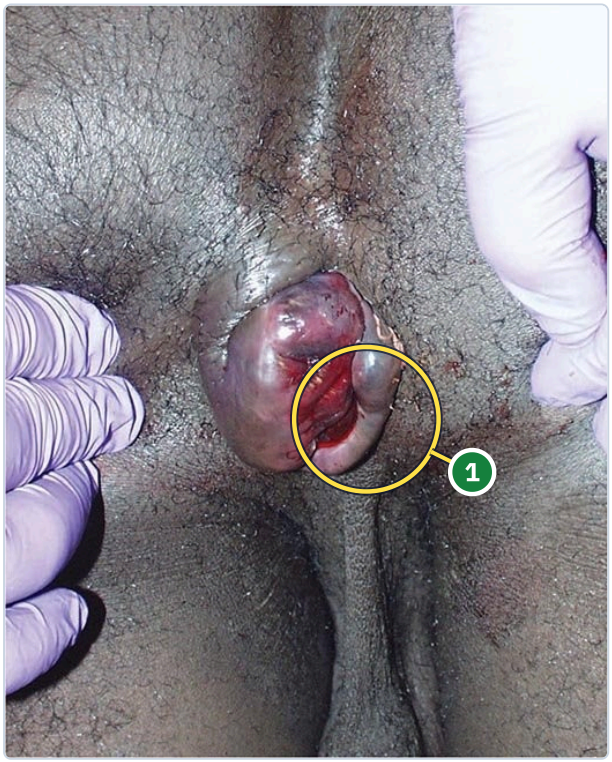


Imagen: Knoop, Atlas of Emergency Medicine, p. 258

QUÉ TIENES QUE VER

1 Trombo violáceo

DIAGNÓSTICO

Hemorroide externo trombosado

Nódulo violáceo, tenso y doloroso en el borde anal.

CONDUCTA INICIAL

Menos de 72 horas: trombectomía; después, manejo médico.

4.01.1.016 Hemorroides - fisura anal

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Fisura anal: dolor al defecar, sin nódulo.

PREGUNTA REAL

Julio 2025 · P27 «Paciente de 52 años con hemorroides externas trombosadas desde hace 6 horas, violáceas, protruidas, irreducibles y muy dolorosas. ¿Cuál es el…» → **Trombectomía hemorroidal bajo anestesia local**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 51 Tema 2.6

Clase 2.6 en video

47 TEMA 2.6 · PATOLOGÍA PERIANAL

FOTO CLÍNICA

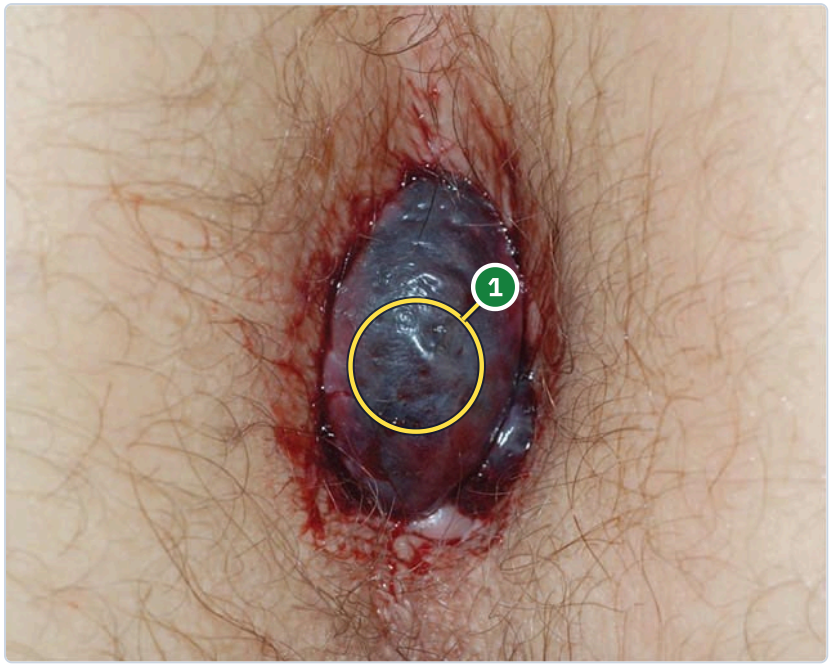


Imagen: The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 241

QUÉ TIENES QUE VER

1 Nódulo violáceo trombosado

DIAGNÓSTICO

Hemorroide externo trombosado

Nódulo violáceo, tenso y doloroso en el margen anal.

CONDUCTA INICIAL

Baños de asiento; trombectomía solo dentro de las primeras 48-72 h.

4.01.1.016 **Hemorroides - fisura anal**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Absceso perianal: eritematoso y fluctuante, con dolor progresivo.

PREGUNTA REAL

Julio 2025 · P27 «Paciente de 52 años con hemorroides externas trombosadas desde hace 6 horas, violáceas, protruidas, irreducibles y muy dolorosas. ¿Cuál es el…» → **Trombectomía hemorroidal bajo anestesia local**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 51** Tema 2.6

Clase 2.6 en video

48 TEMA 2.6 · PATOLOGÍA PERIANAL

FOTO CLÍNICA



Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22nd ed., p. 3113

QUÉ TIENES QUE VER

1 Zona roja y fluctuante

DIAGNÓSTICO

Absceso perianal

Aumento de volumen rojo y fluctuante junto al ano.

CONDUCTA INICIAL

Drenaje quirúrgico; los antibióticos solos no bastan.

4.01.1.017 **Abscesos y fístulas ano rectales**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hemorroide trombosado: nódulo violáceo.

PREGUNTA REAL

Julio 2015 · P41 «Un hombre de 60 años presenta aumento de volumen doloroso en la zona sacra baja. Al examen físico se aprecia aumento de volumen de 4 cm de…» → **Drenaje quirúrgico**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 51** Tema 2.6

Clase 2.6 en video

49 TEMA 2.6 · PATOLOGÍA PERIANAL

FOTO CLÍNICA

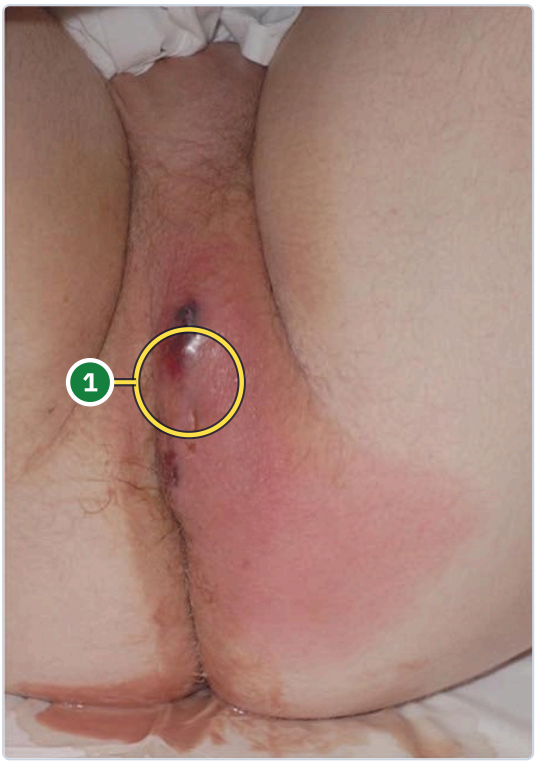


Imagen: Knoop, Atlas of Emergency Medicine, p. 257

QUÉ TIENES QUE VER

1 Tumefacción perianal

DIAGNÓSTICO

Absceso perianal

Tumefacción roja perianal con dolor que aumenta día a día.

CONDUCTA INICIAL

Drenaje quirúrgico en pabellón; los antibióticos solos no bastan.

4.01.1.017 **Abscesos y fístulas ano rectales**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hemorroide trombosado: dolor súbito y nódulo violáceo.

PREGUNTA REAL

Julio 2015 · P41 «Un hombre de 60 años presenta aumento de volumen doloroso en la zona sacra baja. Al examen físico se aprecia aumento de volumen de 4 cm de...» → **Drenaje quirúrgico**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 51 Tema 2.6

Clase 2.6 en video

50 TEMA 3.1 · ICTERICIA Y COLESTASIA

FOTO CLÍNICA



Imagen: Knoop, Atlas of Emergency Medicine, p. 34

QUÉ TIENES QUE VER

1 Esclera amarilla

DIAGNÓSTICO

Ictericia escleral

Escleras amarillas: bilirrubina sobre 2–3 mg/dl.

CONDUCTA INICIAL

Ecografía: vía biliar dilatada (obstructiva) o no.

1.06.1.007 **Colestasia**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

4.01.1.026 **Ictericia obstructiva**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Carotenemia: piel amarilla con escleras blancas.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 59 Tema 3.1

Clase 3.1 en video

51 TEMA 3.1 · ICTERICIA Y COLESTASIA

ECOGRAFÍA

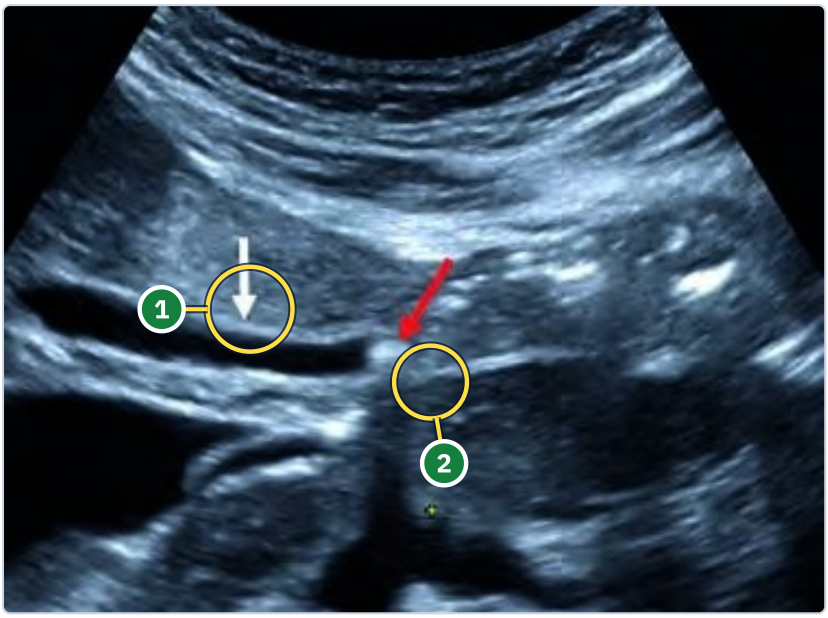


Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 45

QUÉ TIENES QUE VER

1. Colédoco dilatado (flecha blanca)
2. Cálculo (flecha roja)

DIAGNÓSTICO

Colédoco dilatado por coledocolitiasis

Vía biliar ancha = ictericia obstructiva: buscar cálculo o tumor.

CONDUCTA INICIAL

Eco → colangiorresonancia → CPRE.

1.06.4.006	Ecotomografía abdominal — examen/procedimiento
4.01.1.026	Ictericia obstructiva — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Colestasia intrahepática: vía biliar no dilatada.

PREGUNTA REAL **Agosto 2021 · P124** «Un paciente de 54 años consulta por dolor abdominal epigástrico intenso, tipo cólico, asociado a náuseas de 6 horas de evolución, por lo que…» → **Ecografía abdominal**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 59 Tema 3.1

Clase 3.1 en video

52 TEMA 3.1 · ICTERICIA Y COLESTASIA

IMAGEN RADIOLÓGICA

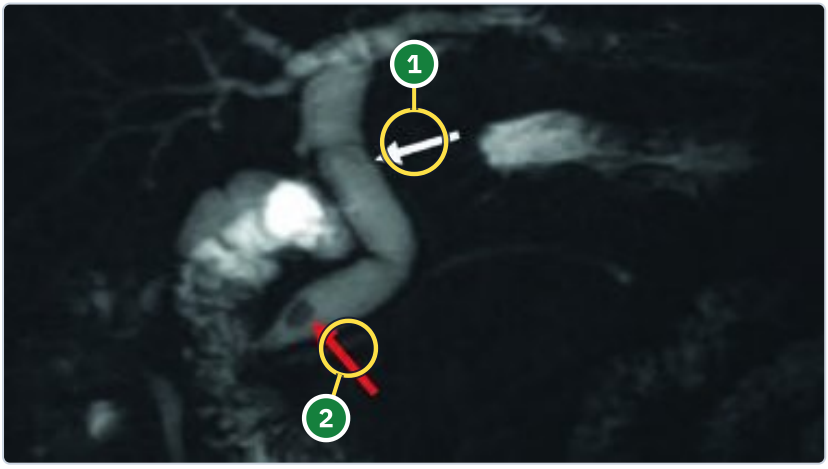


Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 45

QUÉ TIENES QUE VER

1. Colédoco dilatado (flecha blanca)
2. Cálculo (flecha roja)

DIAGNÓSTICO

Coledocolitiasis en colangiorresonancia

Colédoco dilatado con un cálculo que lo obstruye.

CONDUCTA INICIAL

Colangiorresonancia confirma; CPRE extrae.

1.06.4.015	Colangiografía por resonancia magnética — examen/procedimiento
1.06.1.006	Colelitiasis — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Colangiocarcinoma: estenosis sin cálculo.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2019 · P96** «Un paciente de 35 años, colecistectomizado hace 6 meses por vía laparoscópica, consulta por dolor epigástrico, progresivo, que inició hace 24…» → **Colangioresonancia**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 59 Tema 3.1

Clase 3.1 en video

53 TEMA 3.1 · ICTERICIA Y COLESTASIA

FOTO CLÍNICA

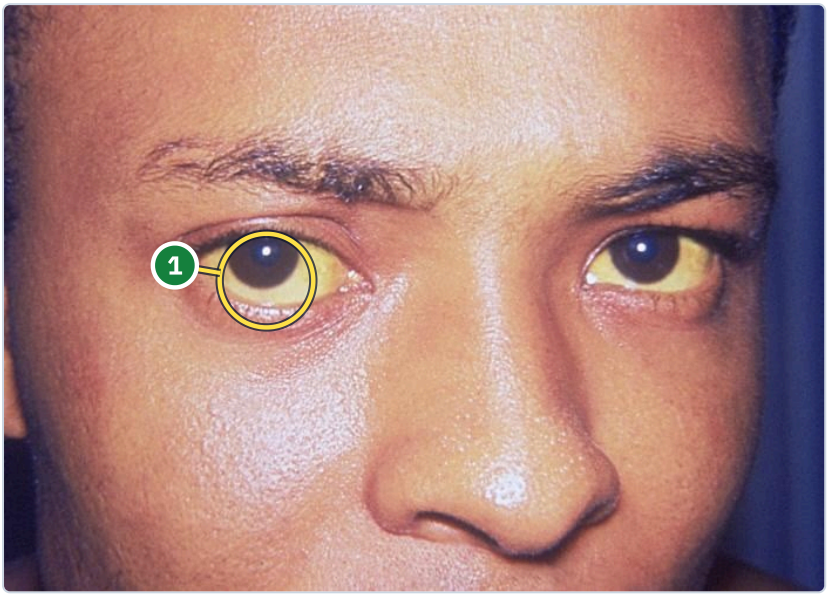


Imagen: Wikimedia Commons, Public domain

QUÉ TIENES QUE VER

1. Escleras amarillas

DIAGNÓSTICO

Ictericia escleral

Las escleras son lo primero que se tiñe: visible sobre 2,5-3 mg/dL.

CONDUCTA INICIAL

Primer examen: ecografía abdominal (vía biliar dilatada o no).

1.06.1.007	Colestasia	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar
4.01.1.026	Ictericia obstructiva	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Carotenemia: piel amarilla con escleras blancas.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 59 Tema 3.1

Clase 3.1 en video

54 TEMA 3.1 · ICTERICIA Y COLESTASIA

IMAGEN RADIOLÓGICA

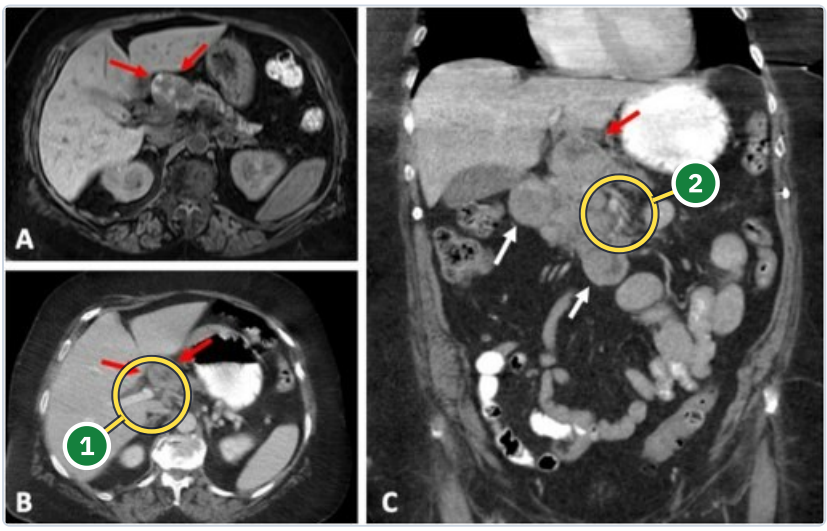


Imagen: Open-i (NLM), CC BY

QUÉ TIENES QUE VER

1. Masa en la cabeza pancreática
2. Vía biliar dilatada

DIAGNÓSTICO

Cáncer de la cabeza del páncreas

Masa en la cabeza del páncreas con vía biliar dilatada: ictericia silente (Courvoisier-Terrier).

CONDUCTA INICIAL

Baja de peso + ictericia indolora: TAC (no endoscopía).

1.06.1.002	Cáncer de páncreas	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
4.01.1.031	Cáncer de páncreas	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Coledocolitiasis: ictericia dolorosa.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2025 · P85** «Un paciente de 60 años consulta por ictericia de dos semanas de evolución, que ha ido en aumento y se ha asociado a orinas oscuras. Como…» → **Tumor de páncreas**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 59 Tema 3.1

Clase 3.1 en video

55 TEMA 3.2 · HEPATITIS AGUDA Y CRÓNICA

ESQUEMA



Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

- Período de ventana: solo IgM anti-HBc positiva
- Anti-HBs = inmunidad

DIAGNÓSTICO

Hepatitis B aguda: marcadores en el tiempo

Entre la caída del HBsAg y la aparición del anti-HBs solo está la IgM anti-HBc (ventana).

CONDUCTA INICIAL

HBsAg = hay virus; IgM anti-HBc = es aguda; HBsAg (+) con IgM (–) = crónica.

1.06.4.012	Estudio de marcadores virales para hepatitis A, B y C	examen/procedimiento
1.06.1.020	Hepatitis agudas B, C, por otros virus, por drogas y tóxicas	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Vacunado: solo anti-HBs positivo.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 63** Tema 3.2

Clase 3.2 en video

56 TEMA 3.2 · HEPATITIS AGUDA Y CRÓNICA

ECOGRAFÍA

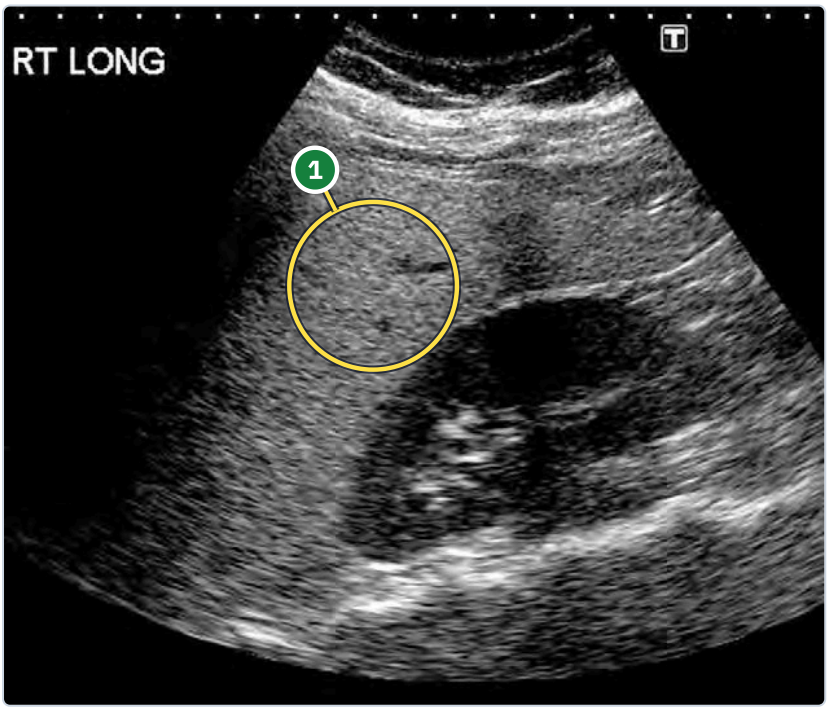


Imagen: Diagnostic Ultrasound (Rumack), p. 1827

QUÉ TIENES QUE VER

1. Parénquima hepático hiperecogénico

DIAGNÓSTICO

Esteatosis hepática

Hígado brillante, hiperecogénico.

CONDUCTA INICIAL

Esteatopatía no alcohólica: baja de peso y control de factores de riesgo.

1.06.3.006	Esteatopatía no alcohólica	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Cirrosis: contorno nodular y heterogéneo.

PREGUNTA REAL — **Diciembre 2024 · P102** «Mujer obesa 2-3 copas de vino sólo el fin de semana en tratamiento con estatinas, transaminasas con doble del valor normal:» → **esteatohepatitis no alcoholica**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 63** Tema 3.2

Clase 3.2 en video

57 TEMA 3.3 · DAÑO HEPÁTICO CRÓNICO E HIPERTENSIÓN PORTAL

ECOGRAFÍA

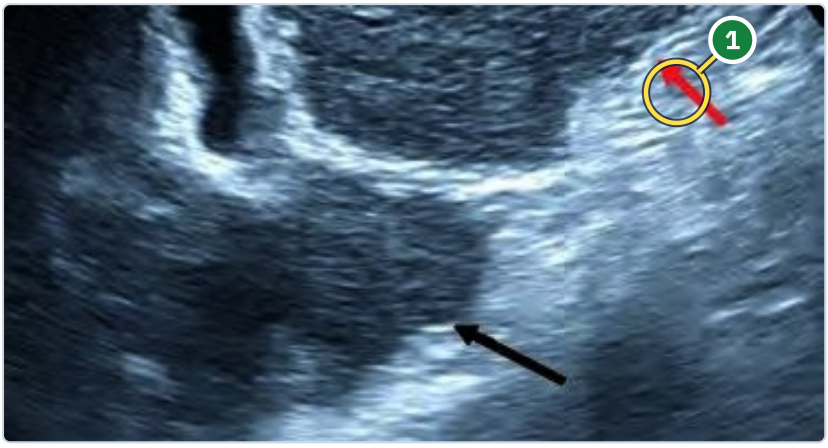


Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 42

QUÉ TIENES QUE VER

1 Superficie irregular (flechas)

DIAGNÓSTICO

Cirrosis en la ecografía

Hígado heterogéneo con contorno lobulado.

CONDUCTA INICIAL

Toda ascitis en cirrótico: paracentesis diagnóstica.

1.06.1.005 **Cirrosis hepática**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Esteatosis: hígado brillante pero liso.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 66** Tema 3.3

Clase 3.3 en video

58 TEMA 3.3 · DAÑO HEPÁTICO CRÓNICO E HIPERTENSIÓN PORTAL

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 216

QUÉ TIENES QUE VER

1 Colaterales tortuosas

DIAGNÓSTICO

Portografía: colaterales

Várices tortuosas que salen del sistema porta.

CONDUCTA INICIAL

Hipertensión portal: endoscopía para buscar várices.

4.01.3.009 **Conceptos generales de hipertensión portal**
examen/procedimiento

1.06.1.005 **Cirrosis hepática**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Trombosis portal: no se rellena la vena porta.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 66** Tema 3.3

Clase 3.3 en video

59 TEMA 3.3 · DAÑO HEPÁTICO CRÓNICO E HIPERTENSIÓN PORTAL

FOTO CLÍNICA

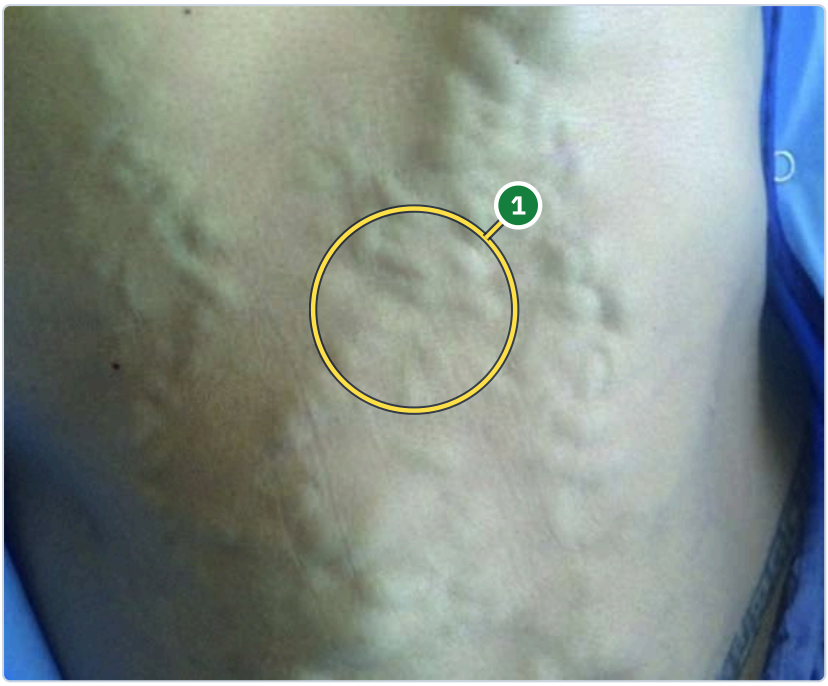


Imagen: Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 216

QUÉ TIENES QUE VER

1 Colaterales venosas en la pared abdominal

DIAGNÓSTICO

Cabeza de medusa

Venas dilatadas periumbilicales por hipertensión portal.

CONDUCTA INICIAL

Hipertensión portal: buscar várices con endoscopía.

4.01.3.009 **Conceptos generales de hipertensión portal** — examen/procedimiento

1.06.1.005 **Cirrosis hepática** — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Obstrucción de cava inferior: flujo hacia arriba.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 66** Tema 3.3

Clase 3.3 en video

60 TEMA 3.3 · DAÑO HEPÁTICO CRÓNICO E HIPERTENSIÓN PORTAL

ENDOSCOPÍA

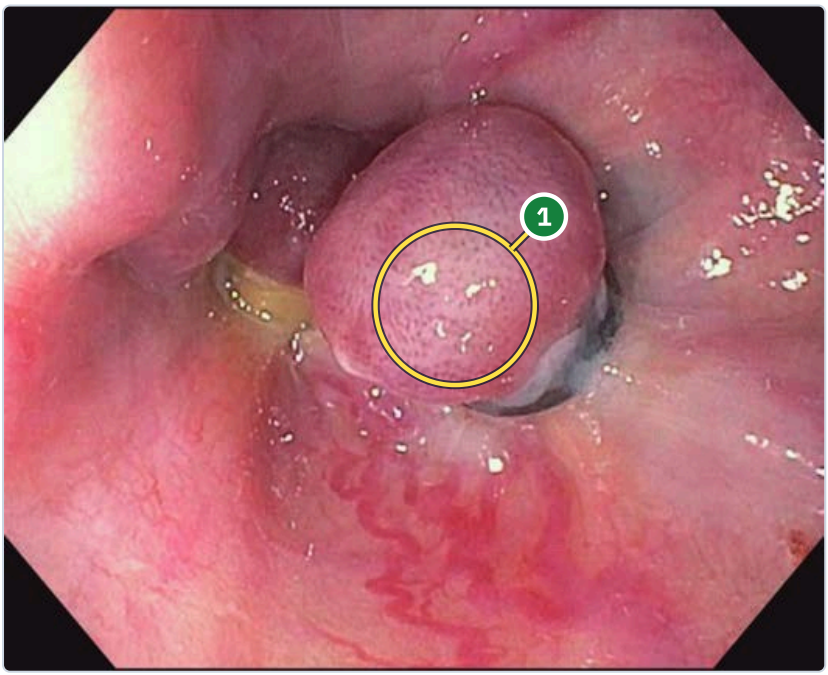


Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1 Várice ligada

DIAGNÓSTICO

Várice esofágica con ligadura

Várice abultada con la banda elástica puesta en su base.

CONDUCTA INICIAL

Terlipresina + antibióticos + tiamina + ligadura en < 12 h; profilaxis con propranolol.

1.06.2.007 **Hemorragia digestiva alta y baja** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

4.01.3.009 **Conceptos generales de hipertensión portal** — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Úlcera sangrante: IBP y hemostasia.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2017 · P31** «Una paciente diabética, presenta hematemesis en 3 oportunidades. Su frecuencia cardíaca es 117x', su presión arterial es 90/60 mmHg. Al examen…» → **Várices esofágicos**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 66** Tema 3.3

Clase 3.3 en video

61 TEMA 3.4 · LESIONES HEPÁTICAS FOCALES Y PÓLIPOS VESICULARES

ECOGRAFÍA

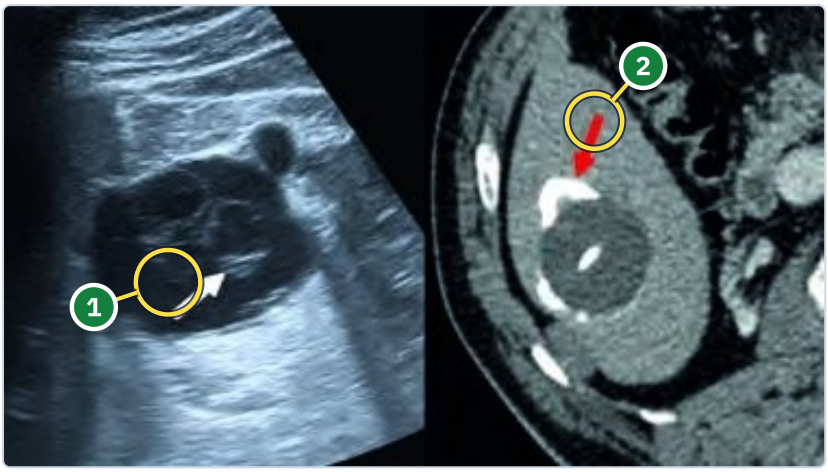


Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 43

QUÉ TIENES QUE VER

1. Vesículas hijas (flecha blanca)
2. Calcificación (flecha roja)

DIAGNÓSTICO

Quiste hidatídico hepático

Lesión quística con membranas y vesículas hijas en un paciente que convive con perros.

CONDUCTA INICIAL

Serología y cirugía o PAIR según estadio; albendazol.

4.01.1.022	Hidatidosis hepática	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
1.06.1.024	Masa hepática	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Quiste simple: anecoico sin tabiques.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 70** Tema 3.4

Clase 3.4 en video

62 TEMA 3.4 · LESIONES HEPÁTICAS FOCALES Y PÓLIPOS VESICULARES

IMAGEN RADIOLÓGICA

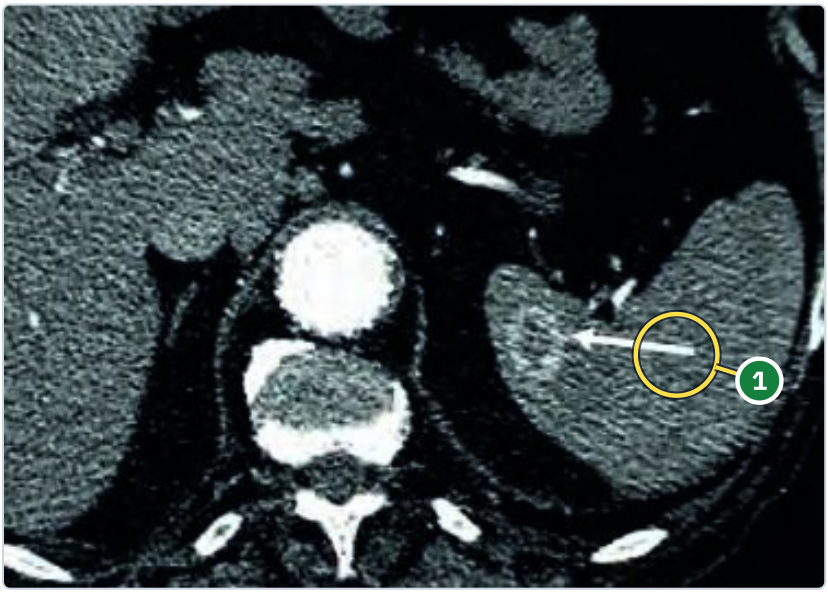


Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 51

QUÉ TIENES QUE VER

1. Realce periférico globular (flecha)

DIAGNÓSTICO

Hemangioma hepático

Lesión con realce periférico en glóbulos que se llena hacia el centro.

CONDUCTA INICIAL

Se observa; solo se opera si es gigante y sintomático.

1.06.1.024	Masa hepática	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
4.01.1.024	Tumores hepáticos	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hepatocarcinoma: realce arterial y lavado.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 70** Tema 3.4

Clase 3.4 en video

63 TEMA 3.4 · LESIONES HEPÁTICAS FOCALES Y PÓLIPOS VESICULARES

IMAGEN RADIOLÓGICA

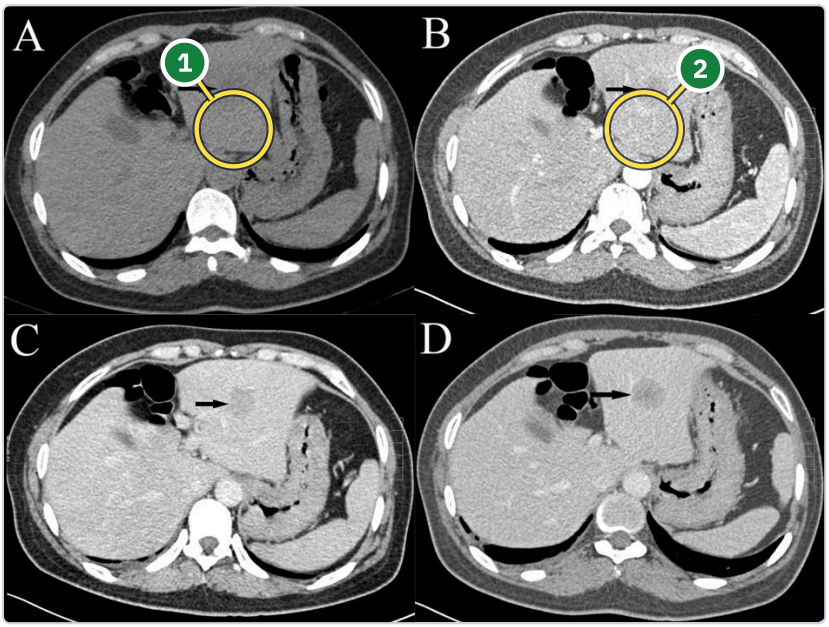


Imagen: Wikimedia Commons «Triphasic CT scan of hepatocellular carcinoma.jpg», CC BY 4.0, Zhenyu Pan, Guozi Yang, Tingting Yuan, Lihua Dong, Lihua Don

QUÉ TIENES QUE VER

1. Lesión que capta en arterial (A)
2. Lavado en fase portal

DIAGNÓSTICO

Hepatocarcinoma en TAC trifásico

Realce en fase arterial y lavado en fase portal en un hígado cirrótico.

CONDUCTA INICIAL

AFP alta + nódulo en cirrótico: resección, ablación o trasplante (criterios de Milán).

1.06.1.024 **Masa hepática** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

4.01.1.024 **Tumores hepáticos** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hemangioma: realce periférico globular.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2024 · P44** «Nódulo hepático sólido: Estudio con ecografía abdominal > con que continuar el estudio» → **TAC Trifasico**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 70** Tema 3.4

Clase 3.4 en video

64 TEMA 3.4 · LESIONES HEPÁTICAS FOCALES Y PÓLIPOS VESICULARES

IMAGEN RADIOLÓGICA

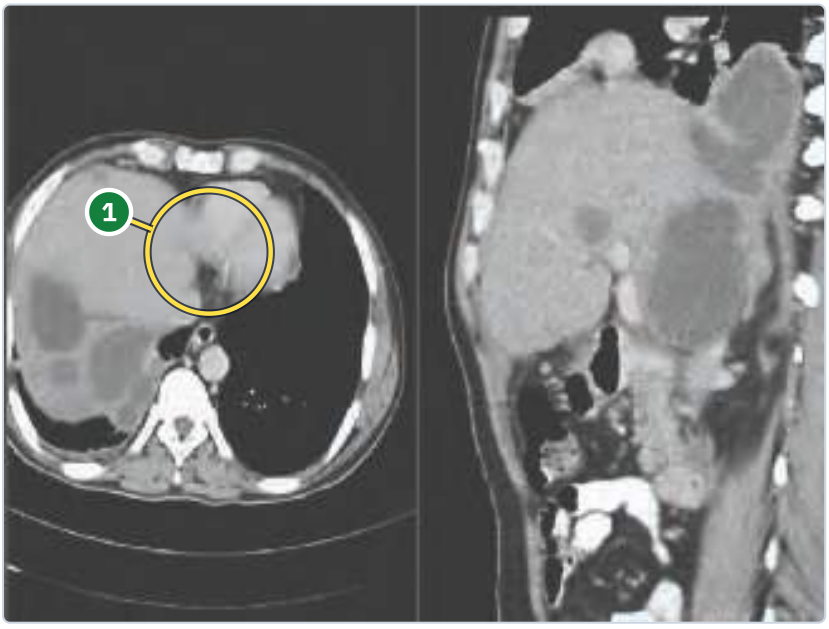


Imagen: Bailey & Love's Short Practice of Surgery, 27th ed., p. 80

QUÉ TIENES QUE VER

1. Colección hepática

DIAGNÓSTICO

Absceso hepático

Lesión hipodensa con pared que realza en el hígado de un paciente febril.

CONDUCTA INICIAL

Drenaje percutáneo y antibióticos.

4.01.1.023 **Quistes y abscesos hepáticos** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Metástasis: múltiples, sin fiebre.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 72** Tema 3.4

Clase 3.4 en video

65 TEMA 3.4 · LESIONES HEPÁTICAS FOCALES Y PÓLIPOS VESICULARES

IMAGEN RADIOLÓGICA

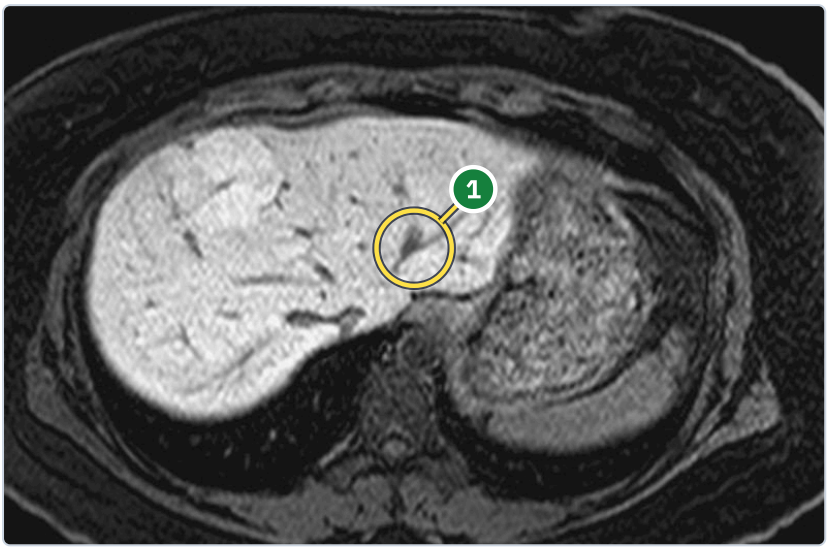


Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 320

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cicatriz central

DIAGNÓSTICO

Hiperplasia nodular focal

Lesión hepática con cicatriz central.

CONDUCTA INICIAL

Benigna: se observa.

1.06.1.024 Masa hepática

Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Adenoma: anticonceptivos, se reseca si > 5 cm.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 69 Tema 3.4

Clase 3.4 en video

66 TEMA 3.4 · LESIONES HEPÁTICAS FOCALES Y PÓLIPOS VESICULARES

IMAGEN RADIOLÓGICA

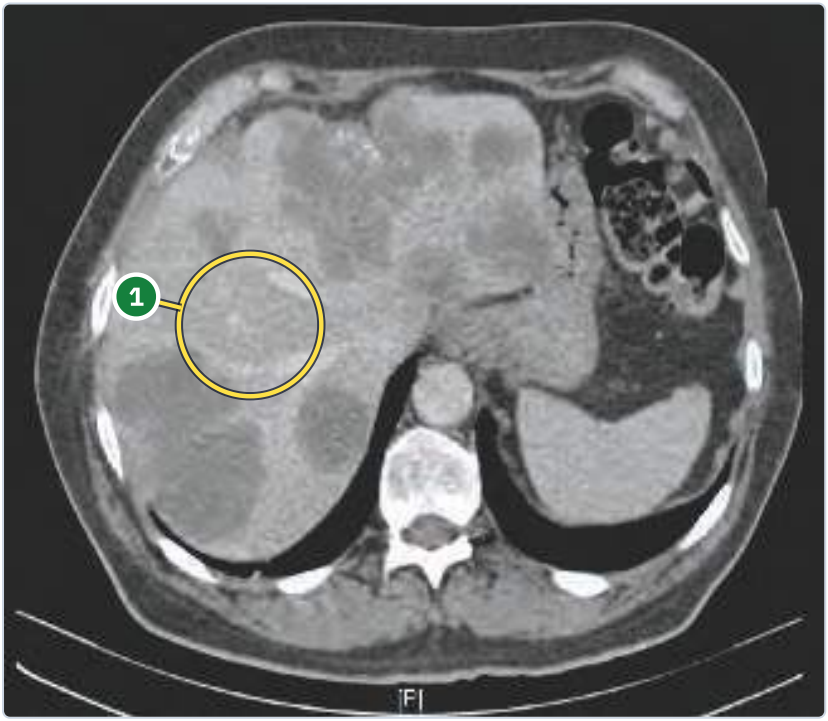


Imagen: Bailey & Love's Short Practice of Surgery, 27.ª ed., p. 1194

QUÉ TIENES QUE VER

1 Lesiones hipodensas múltiples

DIAGNÓSTICO

Metástasis hepáticas

Múltiples lesiones hipodensas repartidas por el parénquima.

CONDUCTA INICIAL

Buscar el primario (colon, mama, pulmón, estómago).

1.06.1.024 Masa hepática

Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Abscesos hepáticos: fiebre, pared gruesa.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 69 Tema 3.4

Clase 3.4 en video

67 TEMA 3.4 · LESIONES HEPÁTICAS FOCALES Y PÓLIPOS VESICULARES

ECOGRAFÍA

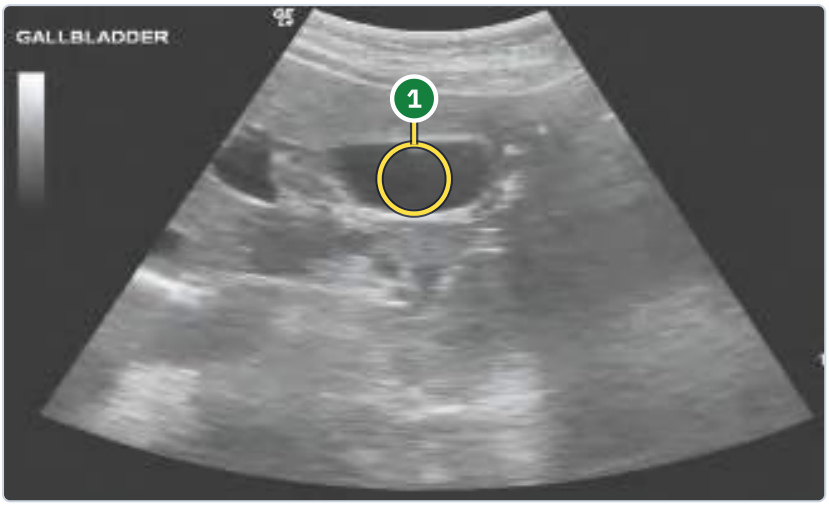


Imagen: Bailey & Love's Short Practice of Surgery, 27th ed., p. 1231

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pólipo adherido a la pared

DIAGNÓSTICO

Pólipo vesicular

Imagen fija en la pared, sin sombra acústica.

CONDUCTA INICIAL

≥ 10 mm, heterogéneo o con cálculos: colecistectomía.

1.06.1.003 Cáncer de vesícula y vías biliares — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Cálculo: móvil y con sombra.

PREGUNTA REAL

Julio 2019 · P27 «Una paciente de 35 años, presenta dolor en el hipocondrio izquierdo, asociado a meteorismo, por lo que se realiza una ecografía abdominal, que…» → **Control ecográfico en 6 meses**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 72 Tema 3.4

Clase 3.4 en video

68 TEMA 3.4 · LESIONES HEPÁTICAS FOCALES Y PÓLIPOS VESICULARES

IMAGEN RADIOLÓGICA

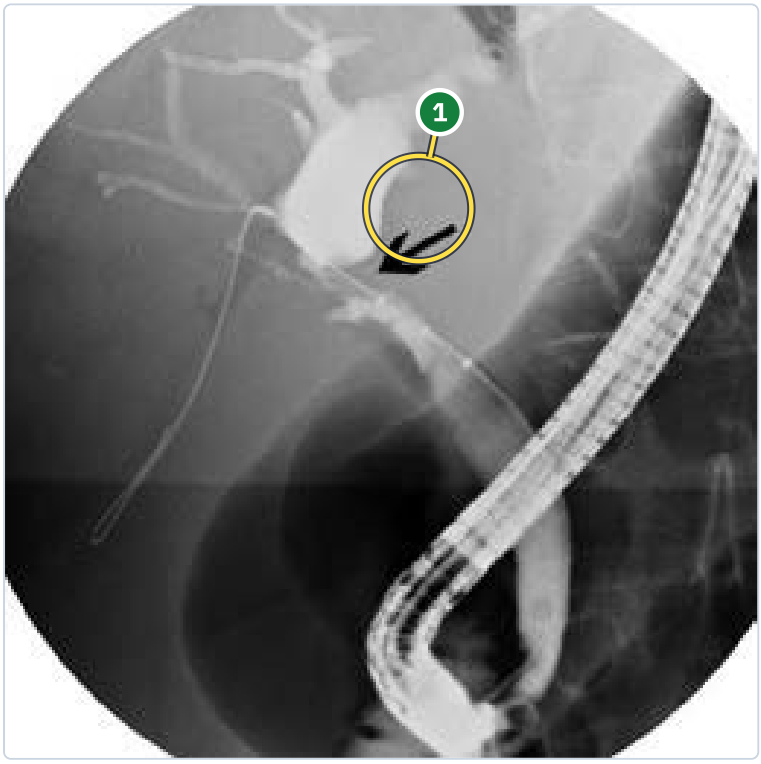


Imagen: Harrison 21.ª ed., p. 2436

QUÉ TIENES QUE VER

1 Estenosis hiliar (flecha)

DIAGNÓSTICO

Colangiocarcinoma hiliar (Klatskin)

Estenosis de la vía biliar en el hilio: ictericia progresiva indolora con prurito.

CONDUCTA INICIAL

Derivar a cirugía; el hiliar deja la vesícula colapsada.

1.06.1.003 Cáncer de vesícula y vías biliares — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

4.01.1.028 Cáncer de vesícula y vías biliares — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Coledocolitiasis: defecto redondeado móvil.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P118 «Una paciente de 82 años con antecedente de colecistectomía hace 5 años, consulta por un cuadro de 2 semanas de evolución caracterizado por…» → **Cáncer de la vía biliar**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 69 Tema 3.4

Clase 3.4 en video

69 TEMA 4.1 · COLELITIASIS, COLECISTITIS, COLEDOCOLITIASIS Y COLANGITIS

ECOGRAFÍA

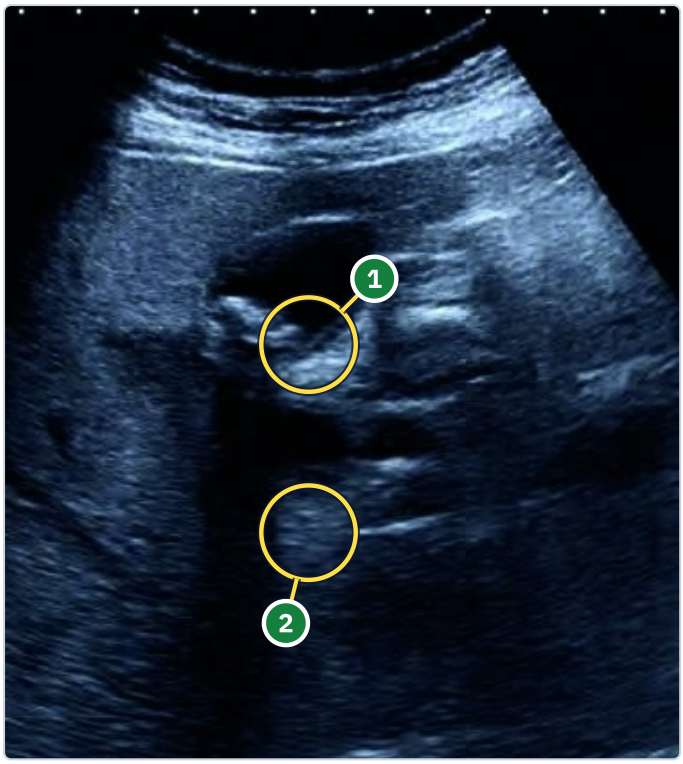


Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 44

QUÉ TIENES QUE VER

1. Cálculo hiperecogénico
2. Sombra acústica posterior

DIAGNÓSTICO

Colelitiasis

El cálculo es blanco y deja una sombra acústica negra detrás.

CONDUCTA INICIAL

Toda colelitiasis se opera (colecistectomía laparoscópica electiva).

1.06.1.006 Colelitiasis

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pólipo vesicular: sin sombra y fijo.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2019 · P174** «Una paciente de 40 años, IMC: 30, presenta dolor intermitente en el hipocondrio derecho, desde hace 3 meses, que cede espontáneamente. Se realiza...» → **Colelitiasis**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 77 Tema 4.1

Clase 4.1 en video

70 TEMA 4.1 · COLELITIASIS, COLECISTITIS, COLEDOCOLITIASIS Y COLANGITIS

ESQUEMA

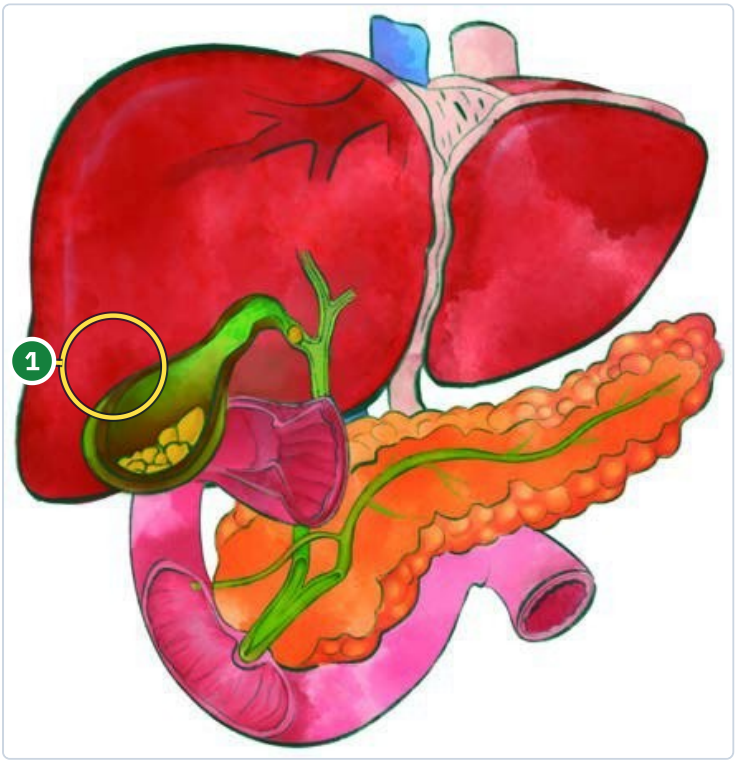


Imagen: Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 244

QUÉ TIENES QUE VER

1. Cálculos en la vesícula

DIAGNÓSTICO

Vesícula con cálculos

Cálculos dentro de la vesícula, junto al hígado y el páncreas.

CONDUCTA INICIAL

Sintomática: colecistectomía laparoscópica.

1.06.1.006 Colelitiasis

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Coledocolitiasis: cálculo en el colédoco, con ictericia.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2019 · P174** «Una paciente de 40 años, IMC: 30, presenta dolor intermitente en el hipocondrio derecho, desde hace 3 meses, que cede espontáneamente. Se realiza...» → **Colelitiasis**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 77 Tema 4.1

Clase 4.1 en video

71 TEMA 4.1 · COLELITIASIS, COLECISTITIS, COLEDOCOLITIASIS Y COLANGITIS

ECOGRAFÍA

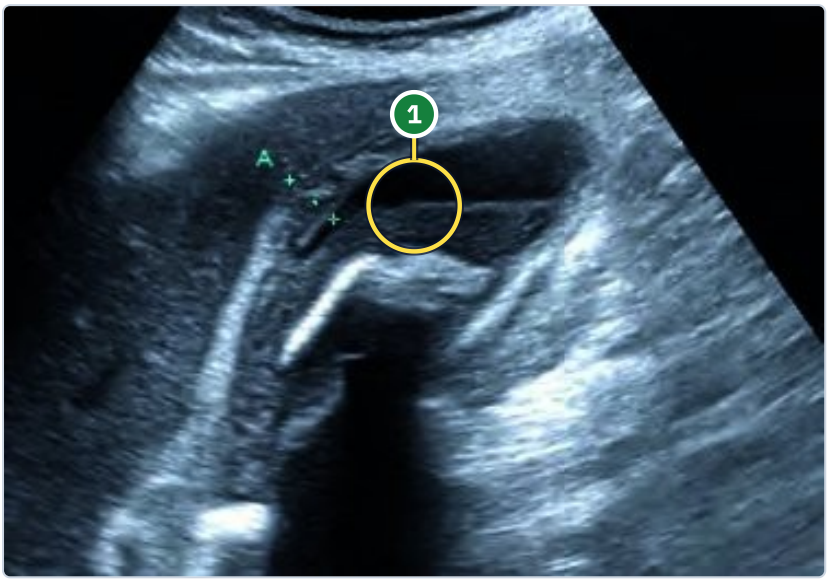


Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 44

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pared vesicular engrosada

DIAGNÓSTICO

Colecistitis aguda

Pared > 4 mm, sobredistensión y líquido perivesicular con cálculos.

CONDUCTA INICIAL

Colecistectomía en < 72 h y antibióticos.

1.06.2.004 **Colecistitis aguda**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Cólico biliar: sin fiebre ni pared engrosada.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 77** Tema 4.1

Clase 4.1 en video

72 TEMA 4.1 · COLELITIASIS, COLECISTITIS, COLEDOCOLITIASIS Y COLANGITIS

IMAGEN RADIOLÓGICA

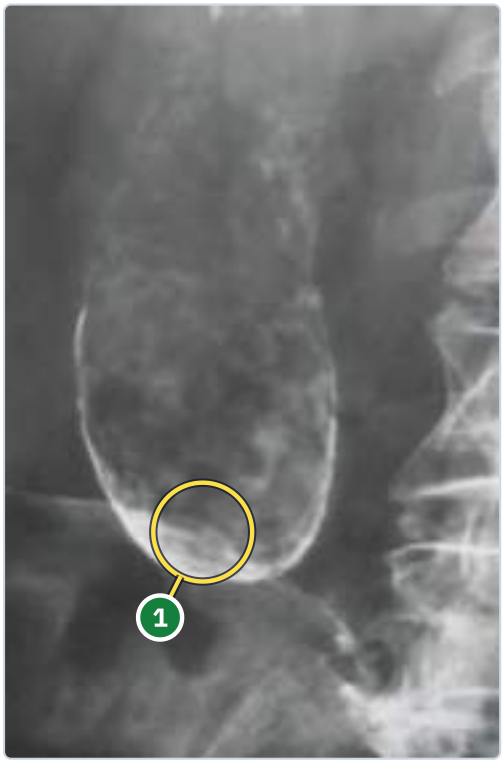


Imagen: Bailey & Love's Short Practice of Surgery, 27th ed., p. 1211

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pared calcificada

DIAGNÓSTICO

Vesícula en porcelana

Pared vesicular calcificada.

CONDUCTA INICIAL

Colecistectomía por riesgo de cáncer de vesícula.

1.06.1.003 **Cáncer de vesícula y vías biliares**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Cálculo grande: imagen intraluminal, no parietal.

PREGUNTA REAL

Julio 2019 · P180 «Una paciente de 91 años, diabética, con antecedente de cólicos biliares a repetición, consulta por astenia, decaimiento, ictericia marcada y…» → **Cáncer de vesícula**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 77** Tema 4.1

Clase 4.1 en video

73 TEMA 4.2 · PANCREATITIS AGUDA

IMAGEN RADIOLÓGICA

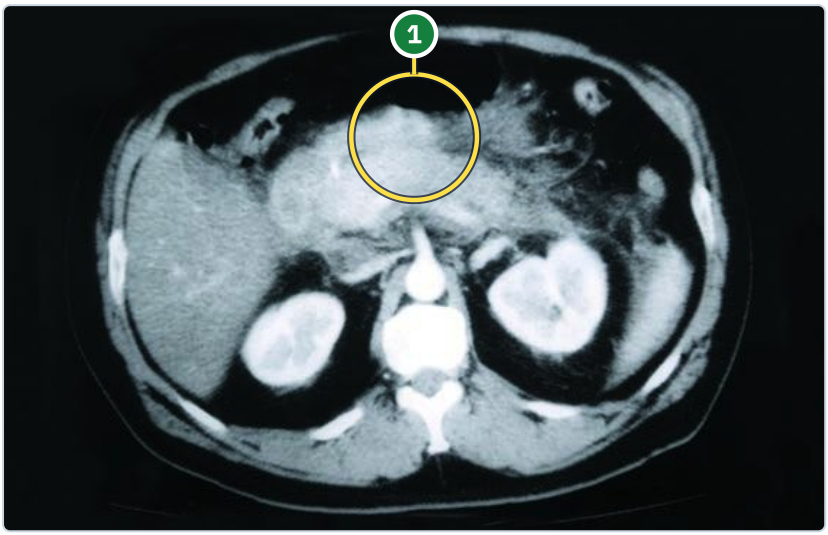


Imagen: Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 258

QUÉ TIENES QUE VER

1. Páncreas aumentado

DIAGNÓSTICO

Pancreatitis edematosa en la TAC

Páncreas aumentado, con borde mal definido y líquido alrededor.

CONDUCTA INICIAL

Hidratación, analgesia y alimentación precoz; TAC si no mejora.

1.06.2.010 Pancreatitis aguda — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.06.4.005 TAC abdominal — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Pancreatitis necrotizante: zonas del páncreas que no captan contraste.

PREGUNTA REAL **Julio 2015 · P35** «Un paciente presenta dolor epigástrico muy intenso, irradiado a ambos costados, . Tiene antecedente de una transgresión alimentaria y consumo de...» → **Pancreatitis aguda**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 80 Tema 4.2

Clase 4.2 en video

74 TEMA 4.2 · PANCREATITIS AGUDA

IMAGEN RADIOLÓGICA

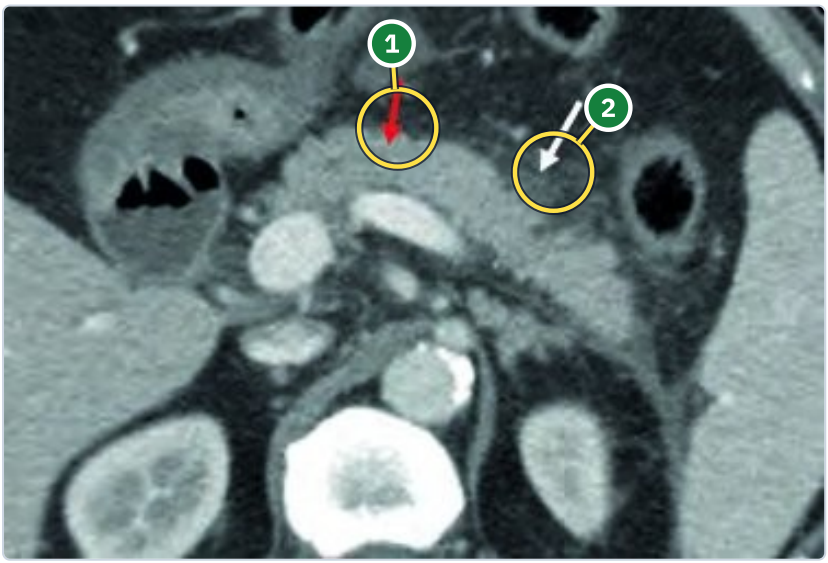


Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 46

QUÉ TIENES QUE VER

1. Páncreas engrosado (flecha roja)
2. Grasa peripancreática inflamada

DIAGNÓSTICO

Pancreatitis aguda edematosa

Páncreas aumentado de tamaño con la grasa vecina borrada por la inflamación.

CONDUCTA INICIAL

Volumen precoz con Ringer lactato; realimentación oral precoz; sin antibióticos profilácticos.

1.06.2.010 Pancreatitis aguda — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.06.4.005 TAC abdominal — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Úlcera perforada: neumoperitoneo.

PREGUNTA REAL **Julio 2015 · P35** «Un paciente presenta dolor epigástrico muy intenso, irradiado a ambos costados, . Tiene antecedente de una transgresión alimentaria y consumo de...» → **Pancreatitis aguda**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 80 Tema 4.2

Clase 4.2 en video

75 TEMA 4.2 · PANCREATITIS AGUDA

FOTO CLÍNICA



Imagen: Wikimedia Commons «Hemorrhagic pancreatitis - Grey Turner's sign.jpg», CC BY 2.0, Herbert L. Fred, MD and Hendrik A. van Dijk

QUÉ TIENES QUE VER

1. Equimosis en el flanco

DIAGNÓSTICO

Signo de Grey Turner

Equimosis en los flancos por sangre retroperitoneal en la pancreatitis hemorrágica.

CONDUCTA INICIAL

Pancreatitis grave: falla orgánica > 48 h, UCI.

1.06.2.010 **Pancreatitis aguda**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hematoma por anticoagulantes.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 80** Tema 4.2

Clase 4.2 en video

76 TEMA 5.1 · ABDOMEN AGUDO

ESQUEMA

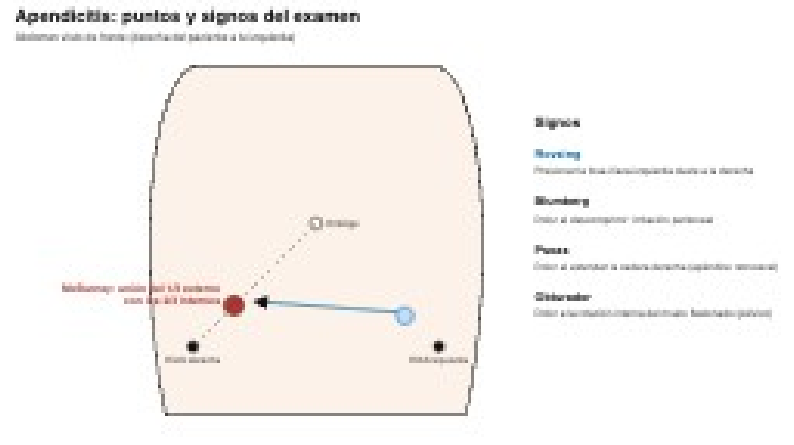


Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

- McBurney doloroso en la fosa ilíaca derecha
- Rovsing: presionar la izquierda duele a la derecha

DIAGNÓSTICO

Apendicitis: puntos y signos del examen

McBurney en la unión del tercio externo con los dos tercios internos.

CONDUCTA INICIAL

Dolor que migra a la FID + anorexia + Blumberg: apendicectomía.

4.01.2.006 **Apendicitis aguda**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Mujer en edad fértil: test de embarazo y evaluación ginecológica.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2022 · P62** «Una mujer de 25 años consulta por dolos abdominal intenso, mayor en la fosa ilíaca derecha y en el hipogastrio, EVA 8/10. Al examen físico tiene…» → **Apendicitis aguda**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 87** Tema 5.1

Clase 5.1 en video

77 TEMA 5.1 · ABDOMEN AGUDO

IMAGEN RADIOLÓGICA

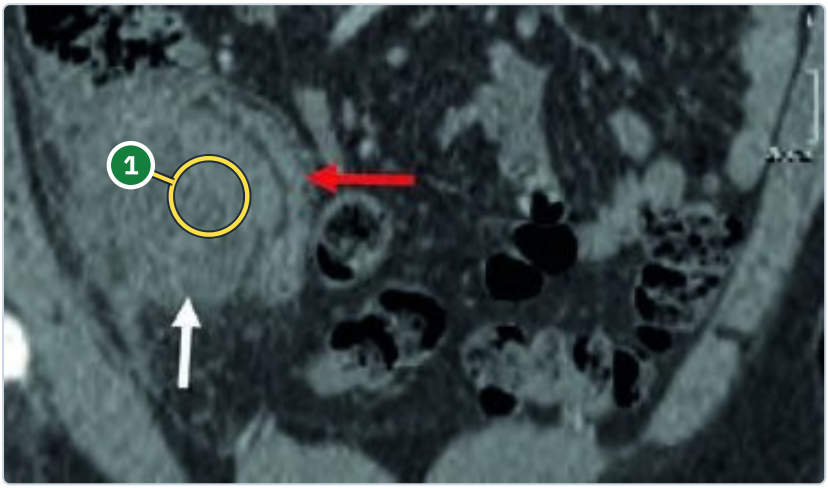


Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 41

QUÉ TIENES QUE VER

1 Apéndice engrosado (flechas)

DIAGNÓSTICO

Apendicitis aguda en TAC

Apéndice engrosado con la grasa que lo rodea inflamada.

CONDUCTA INICIAL

TAC solo en el adulto con duda; si la clínica es clara, pabellón.

4.01.2.006 Apendicitis aguda — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Diverticulitis derecha o Crohn ileal.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 87 Tema 5.1

Clase 5.1 en video

78 TEMA 5.1 · ABDOMEN AGUDO

PIEZA ANATÓMICA

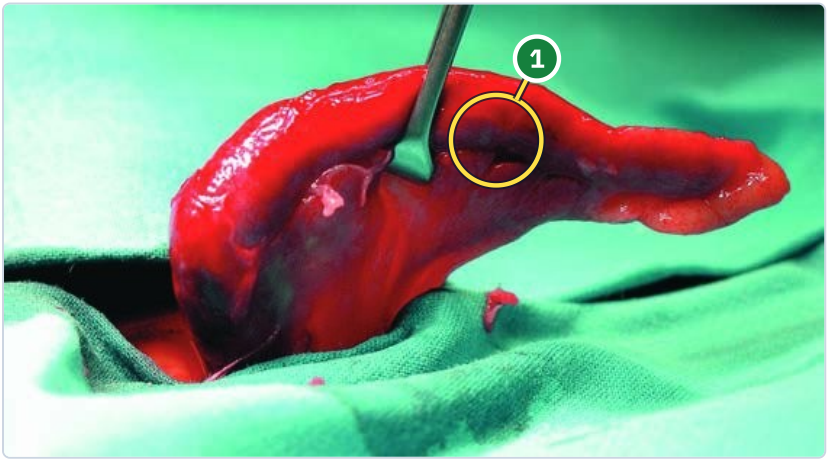


Imagen: Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 157

QUÉ TIENES QUE VER

1 Apéndice edematoso con fibrina

DIAGNÓSTICO

Apendicitis flemonosa (pieza)

Apéndice rojo y edematoso con fibrina en su superficie.

CONDUCTA INICIAL

Apendicectomía laparoscópica.

4.01.2.006 Apendicitis aguda — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Plastrón apendicular: antibióticos y cirugía diferida.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 87 Tema 5.1

Clase 5.1 en video

79 TEMA 5.2 · ISQUEMIA MESENTÉRICA Y ABDOMEN AGUDO DE ORIGEN VASCULAR

IMAGEN RADIOLÓGICA

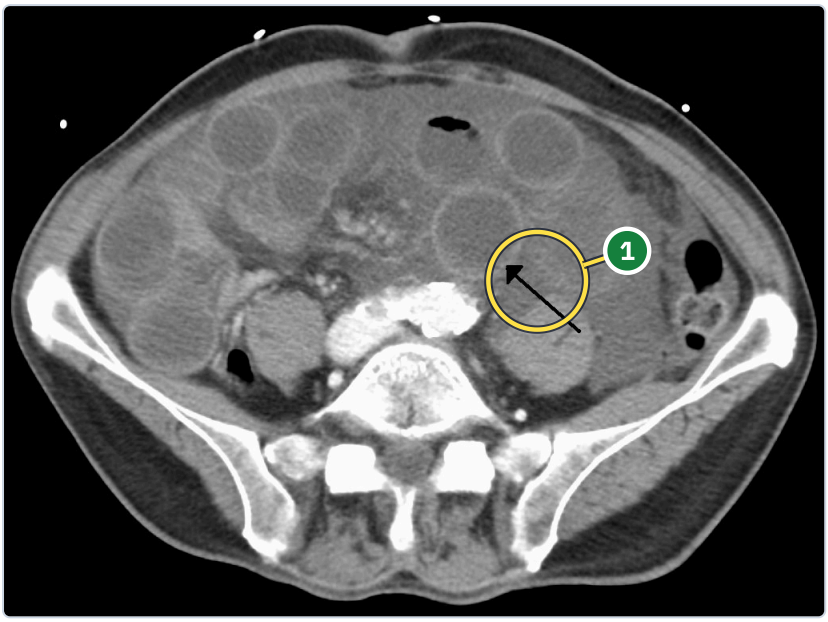


Imagen: Wikimedia Commons «Ischemicbowel.PNG», CC BY-SA 3.0, James Heilman, MD

QUÉ TIENES QUE VER

1 Asas de pared engrosada (flecha)

DIAGNÓSTICO

Trombosis venosa mesentérica

Asas dilatadas con pared engrosada en la TAC con contraste.

CONDUCTA INICIAL

TAC con contraste + anticoagulación; cirugía si hay necrosis.

4.01.2.007 Isquemia mesentérica aguda

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Embolia arterial: dolor súbito con abdomen blando.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2022 · P15 «Una mujer de 62 años acude al servicio de urgencia por dolor abdominal intenso, de dos horas de evolución, difuso, pero mayor en hemiabdomen…» → **Trombosis de la vena mesentérica**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 90** Tema 5.2

Clase 5.2 en video

80 TEMA 5.2 · ISQUEMIA MESENTÉRICA Y ABDOMEN AGUDO DE ORIGEN VASCULAR

IMAGEN RADIOLÓGICA

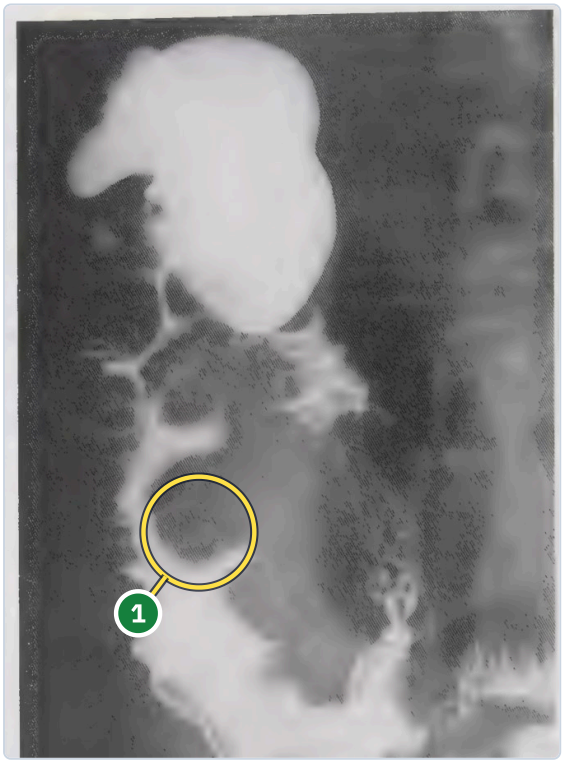


Imagen: Fundamentals of Diagnostic Radiology (Brant and Helms), p. 880

QUÉ TIENES QUE VER

1 Impresiones digitales en el colon

DIAGNÓSTICO

Colitis isquémica: «huellas digitales»

Engrosamiento de la pared del colon con impresiones digitales.

CONDUCTA INICIAL

Adulto mayor con dolor izquierdo y hematoquecia: suele resolver con manejo médico.

4.01.2.007 Isquemia mesentérica aguda

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Colitis ulcerosa: joven, continua desde el recto.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 90** Tema 5.2

Clase 5.2 en video

81 TEMA 5.2 · ISQUEMIA MESENTÉRICA Y ABDOMEN AGUDO DE ORIGEN VASCULAR

IMAGEN RADIOLÓGICA

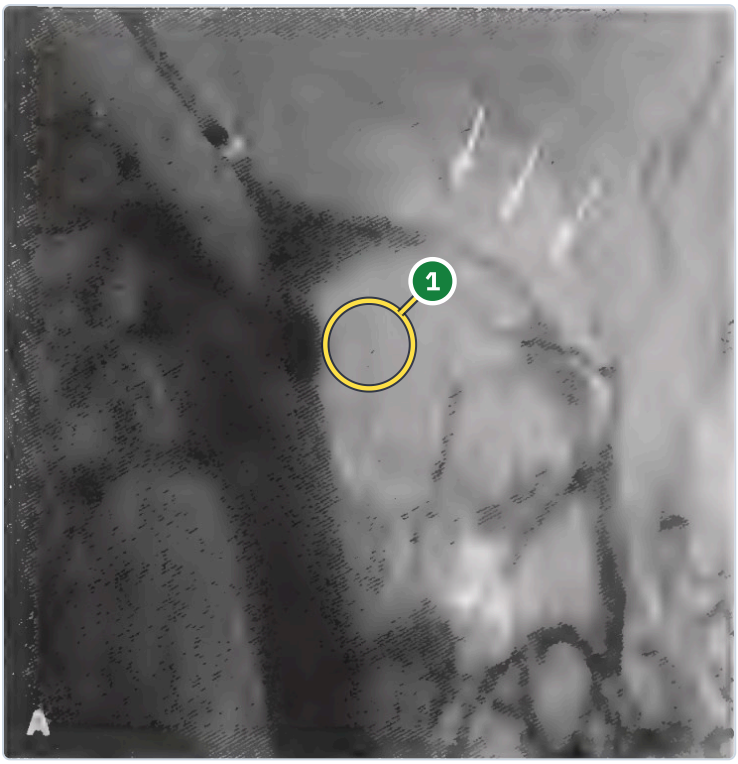


Imagen: Brant & Helms, Fundamentals of Diagnostic Radiology, p. 713

QUÉ TIENES QUE VER

1 Defecto de llene en la AMS

DIAGNÓSTICO

Embolia de la arteria mesentérica superior

Defecto de llene en la AMS en el angioTAC.

CONDUCTA INICIAL

FA + dolor súbito desproporcionado: heparina inmediata y angioTAC.

4.01.2.007 Isquemia mesentérica aguda — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Pancreatitis: lipasa alta.

PREGUNTA REAL

Julio 2025 · P5 «Hombre de 65 años con dolor abdominal postprandial, pérdida de peso de 6 kg y soplo abdominal. Antecedente de tabaquismo y cardiopatía coronaria….» → **AngioTAC de vasos mesentéricos**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 91 Tema 5.2

Clase 5.2 en video

82 TEMA 5.3 · HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA Y BAJA

ENDOSCOPÍA

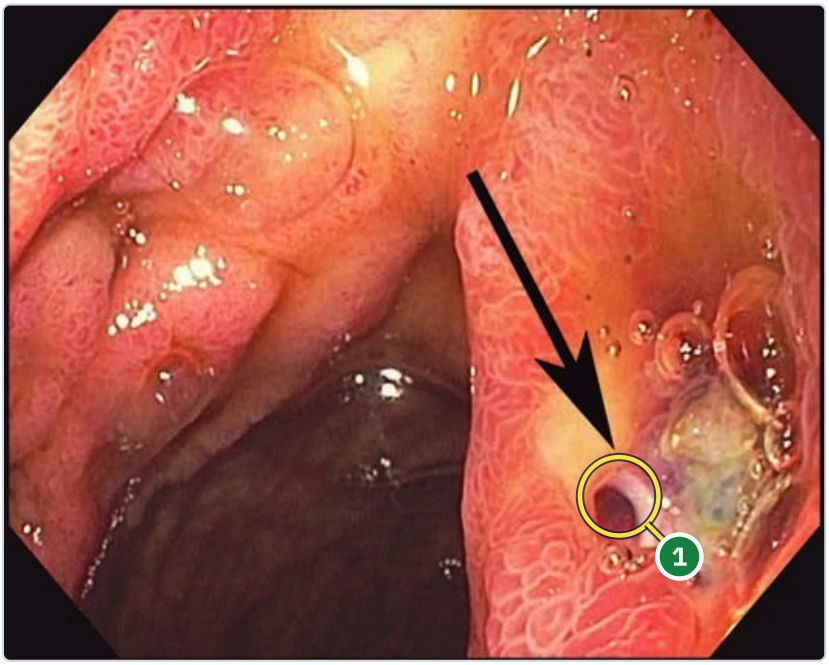


Imagen: Harrison 21.ª ed., p. 2430

QUÉ TIENES QUE VER

1 Vaso visible (flecha)

DIAGNÓSTICO

Úlcera con vaso visible (Forrest IIa)

Vaso visible en el fondo de la úlcera: alto riesgo de resangrado.

CONDUCTA INICIAL

IBP EV en dosis alta y terapia hemostática en la misma endoscopía.

1.06.2.007 Hemorragia digestiva alta y baja — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.06.1.030 Úlcera péptica — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Fondo limpio (Forrest III): bajo riesgo, sin terapia endoscópica.

PREGUNTA REAL

Julio 2019 · P148 «Un paciente de 55 años presenta múltiples episodios de hematemesis, de cerca de un litro, en la última hora. Al examen físico tiene palidez de…» → **Administrar cristaloides endovenosos**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 93 Tema 5.3

Clase 5.3 en video

83 TEMA 5.3 · HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA Y BAJA

ENDOSCOPÍA

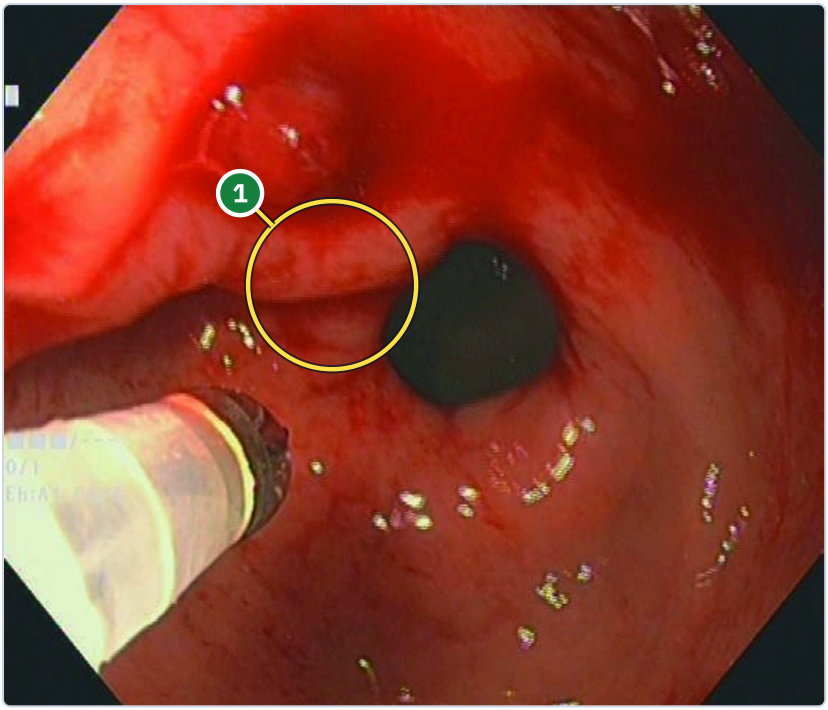


Imagen: Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 63

QUÉ TIENES QUE VER

1. Sangrado activo

DIAGNÓSTICO

Úlcera con sangrado activo (Forrest Ia)

Vaso sangrando activamente en chorro.

CONDUCTA INICIAL

Dos vías gruesas y cristaloides; IBP EV y hemostasia endoscópica.

1.06.2.007 **Hemorragia digestiva alta y baja**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Várices: terlipresina, antibióticos y ligadura.

PREGUNTA REAL **Julio 2019 · P148** «Un paciente de 55 años presenta múltiples episodios de hematemesis, de cerca de un litro, en la última hora. Al examen físico tiene palidez de…» → **Administrar cristaloides endovenosos**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 93** Tema 5.3

Clase 5.3 en video

84 TEMA 5.4 · CUERPO EXTRAÑO DIGESTIVO

IMAGEN RADIOLÓGICA

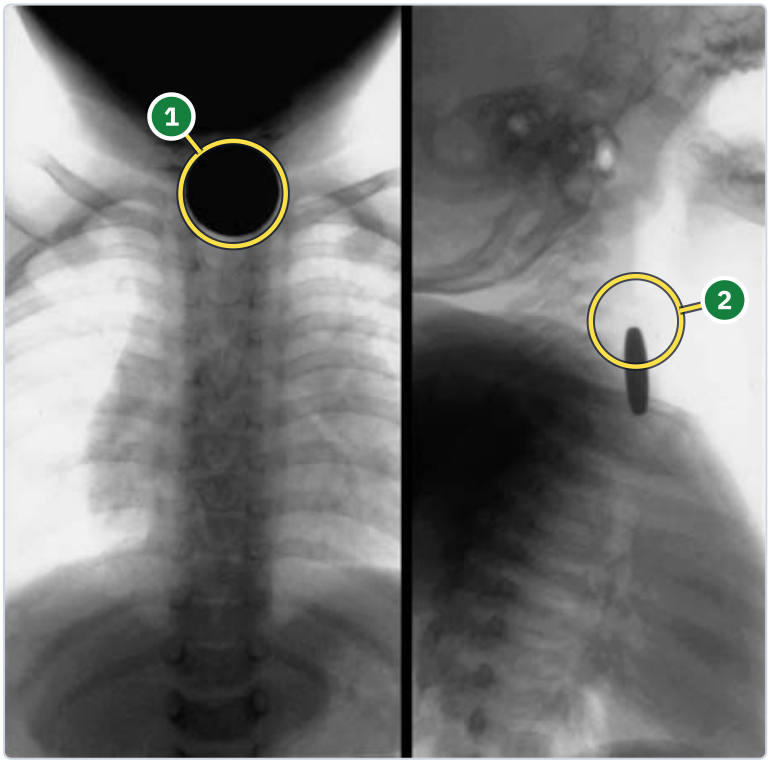


Imagen: Nelson 22.ª ed., p. 2925

QUÉ TIENES QUE VER

1. Disco de frente
2. Línea de perfil

DIAGNÓSTICO

Moneda en el esófago

De frente se ve como un disco completo; de lado, como una línea.

CONDUCTA INICIAL

Radiografía de cuello, tórax y abdomen; en el esófago se retira por endoscopía.

6.03.2.008 **Cuerpo extraño en el esófago**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Moneda en la tráquea: disco de perfil y línea de frente.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 97** Tema 5.4

Clase 5.4 en video

85 TEMA 5.4 · CUERPO EXTRAÑO DIGESTIVO

IMAGEN RADIOLÓGICA

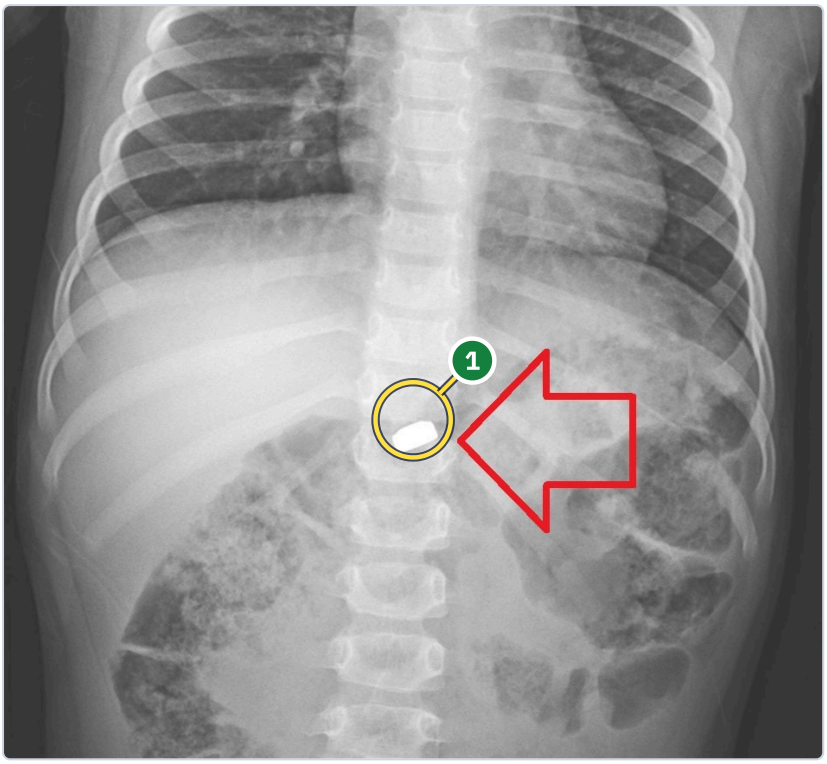


Imagen: Wikimedia Commons «ButtonBatteryIngestion.png», CC BY-SA 4.0, Doc James

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pila de botón (flecha)

DIAGNÓSTICO

Pila de botón ingerida

Objeto metálico muy denso: genera corriente y quema la pared.

CONDUCTA INICIAL

En el esófago es una emergencia: extracción inmediata; se retira en cualquier ubicación.

6.03.2.008 Cuerpo extraño en el esófago

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Moneda: sin doble contorno.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 97 Tema 5.4

Clase 5.4 en video

86 TEMA 5.4 · CUERPO EXTRAÑO DIGESTIVO

ENDOSCOPÍA

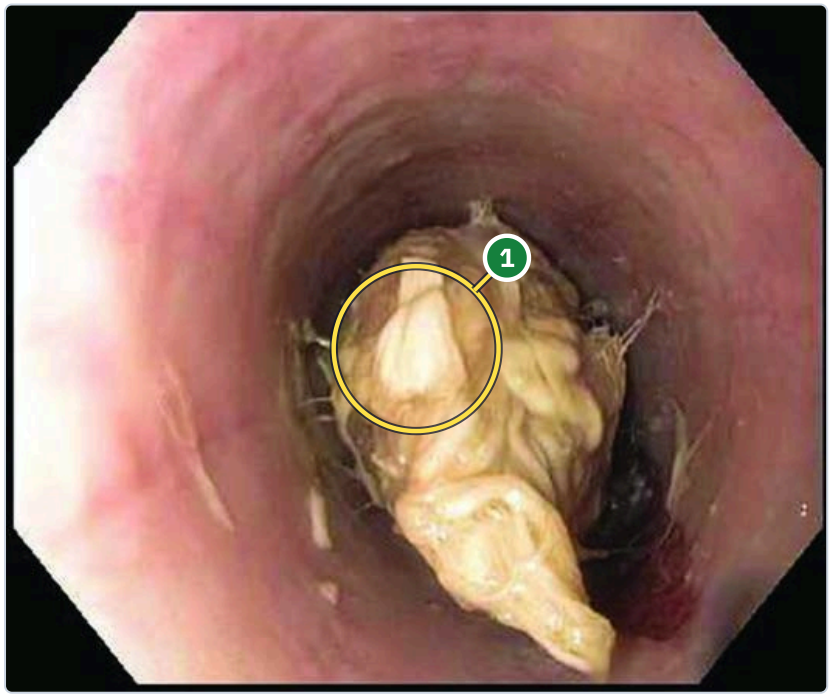


Imagen: Harrison 21.ª ed., p. 2454

QUÉ TIENES QUE VER

1 Bolo alimentario impactado

DIAGNÓSTICO

Bolo de carne impactado

Alimento atascado en el esófago visto por el endoscopio.

CONDUCTA INICIAL

Si no traga o tiene dolor: endoscopía para desimpactar.

1.06.2.002 Afagia aguda

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Cáncer de esófago: puede ser la causa de fondo.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2024 · P50** «Disfagia a nivel de xifoides luego de comer pollo, que no permitía el paso de agua. Conducta:» → **EDA**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 97 Tema 5.4

Clase 5.4 en video

87 TEMA 6.1 · DIARREA AGUDA Y CRÓNICA EN EL NIÑO

FOTO CLÍNICA

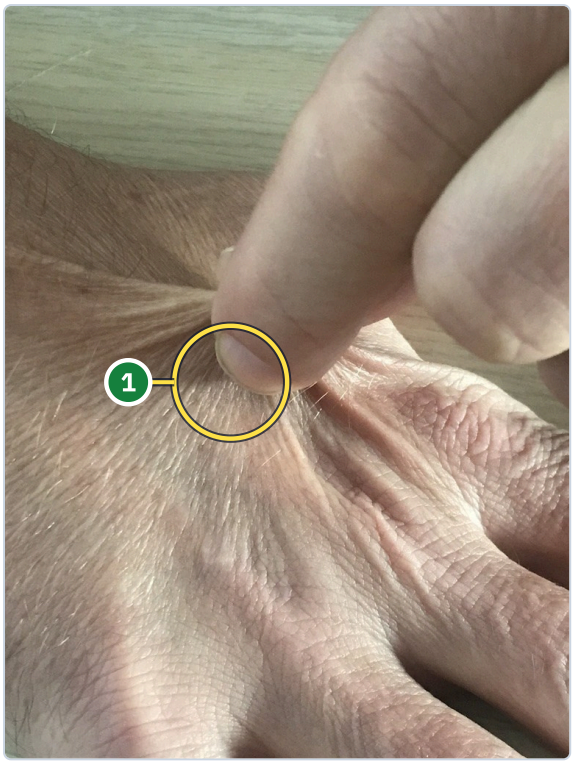


Imagen: Wikimedia Commons «SkinTurgorExamination.jpg», CC BY-SA 4.0, DRobert

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pliegue que no vuelve

DIAGNÓSTICO

Signo del pliegue

La piel pinchada tarda en volver: deshidratación.

CONDUCTA INICIAL

Deshidratación moderada: rehidratación oral; grave: endovenosa.

2.01.2.006 Deshidratación

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Desnutrición: pliegue lento sin deshidratación.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2018 · P161 «Un lactante de 11 meses presenta diarrea aguda, de 2 días de evolución, abundante, asociada a decaimiento marcado y tendencia al llanto. Al...» → **Suero salino al 0,9%**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 105 Tema 6.1

Clase 6.1 en video

88 TEMA 6.1 · DIARREA AGUDA Y CRÓNICA EN EL NIÑO

FOTO CLÍNICA

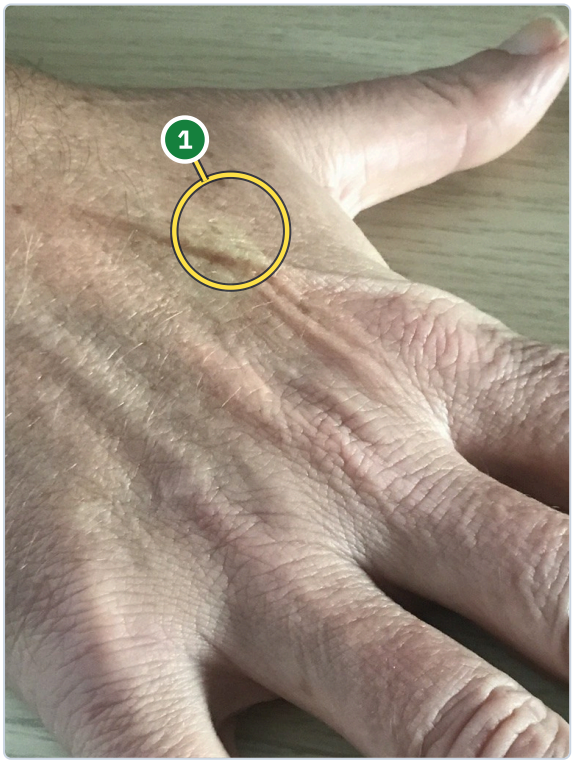


Imagen: Wikimedia Commons «LowSkinTurgor.jpg», CC BY-SA 4.0, DRobert

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pliegue que no vuelve

DIAGNÓSTICO

Signo del pliegue persistente

La piel queda levantada unos segundos: deshidratación.

CONDUCTA INICIAL

Hidratar según el grado: Plan A, B (SRO 50-100 mL/kg) o C (SF 20 mL/kg).

2.01.2.006 Deshidratación

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Piel del adulto mayor: pierde elasticidad sin deshidratación.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2018 · P161 «Un lactante de 11 meses presenta diarrea aguda, de 2 días de evolución, abundante, asociada a decaimiento marcado y tendencia al llanto. Al...» → **Suero salino al 0,9%**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 105 Tema 6.1

Clase 6.1 en video

89 TEMA 6.1 · DIARREA AGUDA Y CRÓNICA EN EL NIÑO

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA



Imagen: Nelson 22.ª ed., p. 2822

QUÉ TIENES QUE VER

1 Huevo con un lado aplanado

DIAGNÓSTICO

Huevos de oxiuros

Huevos ovalados con un lado aplanado en la cinta adhesiva.

CONDUCTA INICIAL

Test de Graham por la mañana; tratar a la familia.

2.01.1.007 **Enteroparasitosis**

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Huevo de Ascaris: redondo y grueso.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2017 · P120** «Un niño de 4 años presenta intenso prurito anal, desde hace varios días, lo que se ha asociado a dificultades para dormir y bruxismo. ¿Cuál es el…» → **Test de Graham**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 105** Tema 6.1

Clase 6.1 en video

90 TEMA 6.2 · REFLUJO DEL LACTANTE, DOLOR ABDOMINAL CRÓNICO Y CONSTIPACIÓN EN EL NIÑO

ESQUEMA



Imagen: Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 65

QUÉ TIENES QUE VER

1 Píloro engrosado

DIAGNÓSTICO

Estenosis hipertrófica del píloro

El músculo pilórico se engruesa y cierra la salida del estómago.

CONDUCTA INICIAL

Vómitos explosivos entre la 2.ª y 6.ª semana: ecografía y pilorotomía de Ramstedt.

2.01.1.046 **Displasia broncopulmonar / Reflujo gastroesofágico y vómitos del lactante (código repetido en el Perfil oficial)**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Reflujo del lactante: crece bien.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2025 · P137** «Un lactante de 2 meses presenta vómitos frecuentes, que iniciaron hace dos semanas y han ido en aumento, siendo abundantes y ocurriendo en…» → **Estenosis pilórica**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 108** Tema 6.2

Clase 6.2 en video

91 TEMA 6.2 · REFLUJO DEL LACTANTE, DOLOR ABDOMINAL CRÓNICO Y CONSTIPACIÓN EN EL NIÑO

ECOGRAFÍA

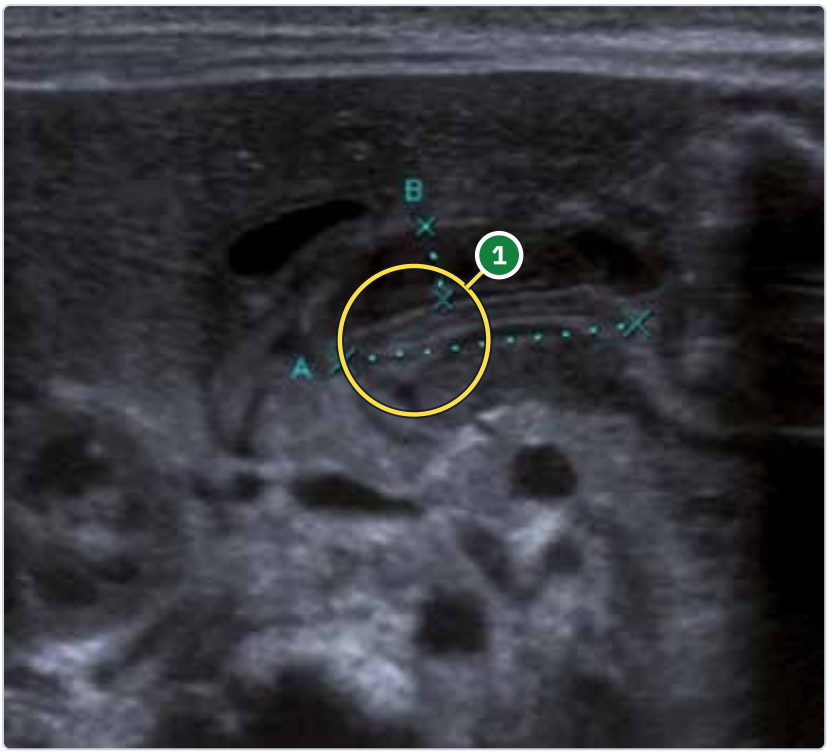


Imagen: Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 65

QUÉ TIENES QUE VER

1 Músculo pilórico engrosado (marcas)

DIAGNÓSTICO

Ecografía: oliva pilórica

Píloro alargado con el músculo engrosado.

CONDUCTA INICIAL

Alcalosis hipoclorémica: corregir y operar (Ramstedt).

2.01.1.046 **Displasia broncopulmonar / Reflujo gastroesofágico y vómitos del lactante (código repetido en el Perfil oficial)**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Reflujo fisiológico: ecografía normal.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2022 · P76** «Un recién niño de 28 días de vida presenta vómitos, desde hace una semana, que son explosivos, generalmente postprandiales. Además, ha detenido…» → **Ecografía abdominal**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 108** Tema 6.2

Clase 6.2 en video

92 TEMA 6.2 · REFLUJO DEL LACTANTE, DOLOR ABDOMINAL CRÓNICO Y CONSTIPACIÓN EN EL NIÑO

IMAGEN RADIOLÓGICA

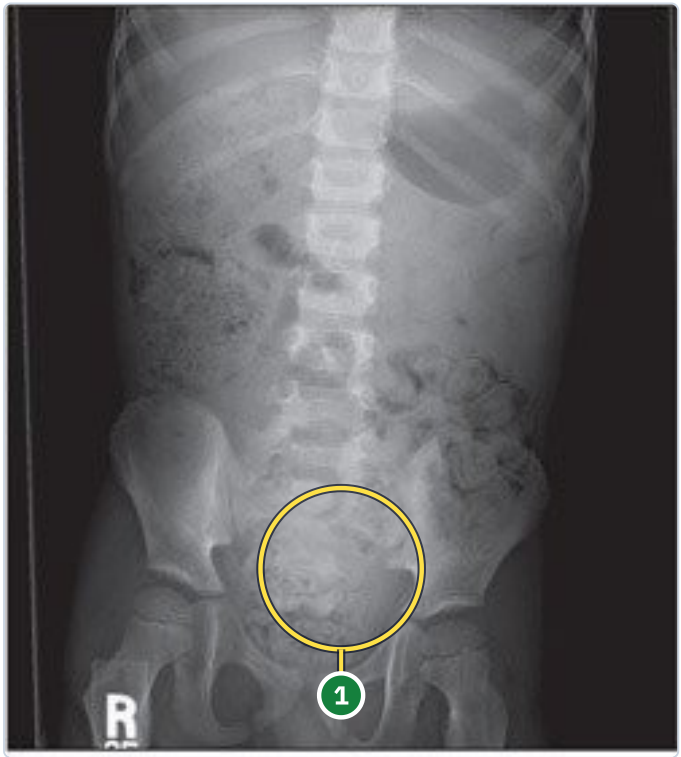


Imagen: Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 753

QUÉ TIENES QUE VER

1 Contenido fecal abundante

DIAGNÓSTICO

Fecaloma en un niño

Masa fecal en el colon: la causa más frecuente de masa abdominal en pediatría.

CONDUCTA INICIAL

Desimpactar con polietilenglicol oral y mantener con laxante ≥ 4 semanas.

2.01.1.038 **Constipación**

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Tumor abdominal: no se moldea con laxantes.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2018 · P163** «Un niño de 4 años presenta incontinencia fecal, en algunas ocasiones, desde hace dos meses. Sin embargo, en otras ocasiones, pasan muchos días…» → **Constipación funcional**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 108** Tema 6.2

Clase 6.2 en video

93 TEMA 6.3 · CIRUGÍA PEDIÁTRICA DIGESTIVA

IMAGEN RADIOLÓGICA

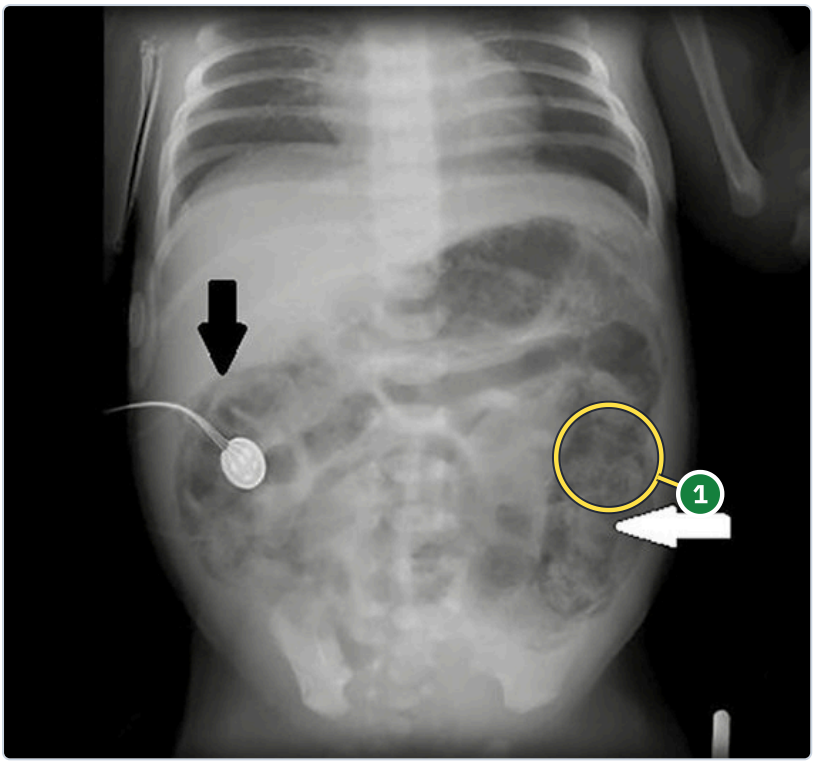


Imagen: Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 24

QUÉ TIENES QUE VER

1 Neumatosis (flechas)

DIAGNÓSTICO

Neumatosis intestinal (enterocolitis necrotizante)

Aire dentro de la pared del intestino: patognomónico.

CONDUCTA INICIAL

Prematuro con distensión y hematoquecia: régimen cero, sonda y antibióticos de amplio espectro.

2.01.1.116 Enterocolitis necrotizante (ECN)

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Neumoperitoneo: aire libre fuera del intestino.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2024 · P120 «RNPT que a los 6 días inicia con vómitos importantes y deposiciones con sangre, abdomen timpánico con RHA disminuidos o ausentes (no recuerdo…» → **Asas dilatadas con niveles hidroaéreos (esta era la más sugerente d…**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 111 Tema 6.3

Clase 6.3 en video

94 TEMA 6.3 · CIRUGÍA PEDIÁTRICA DIGESTIVA

ECOGRAFÍA

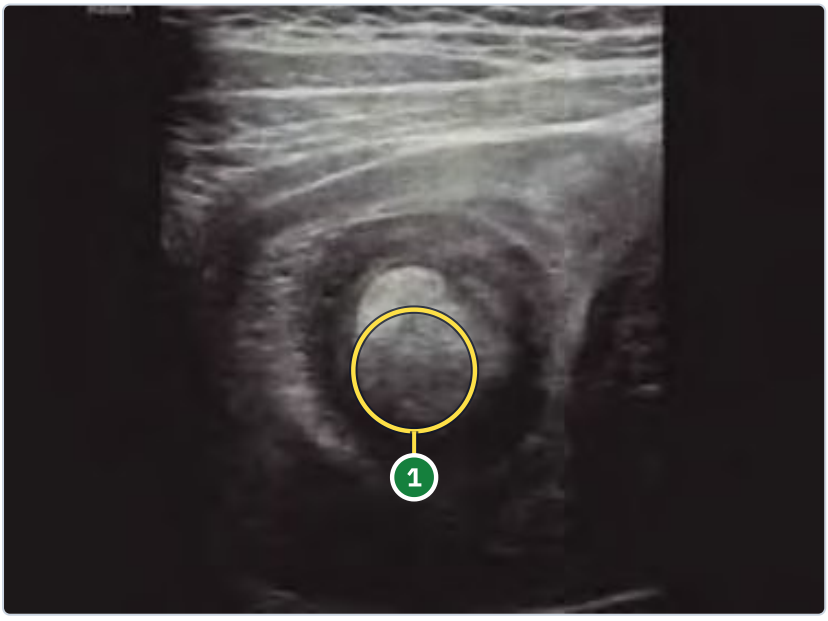


Imagen: Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 70

QUÉ TIENES QUE VER

1 Imagen en diana

DIAGNÓSTICO

Invaginación intestinal: signo de la dona

Anillos del intestino metido dentro del intestino, vistos en corte.

CONDUCTA INICIAL

Lactante con llanto en crisis y deposición en mermelada de grosella: reducción neumática.

2.01.2.019 Obstrucción intestinal

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Gastroenteritis: sin masa ni crisis de llanto.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 111 Tema 6.3

Clase 6.3 en video

95 TEMA 6.3 · CIRUGÍA PEDIÁTRICA DIGESTIVA

ESQUEMA

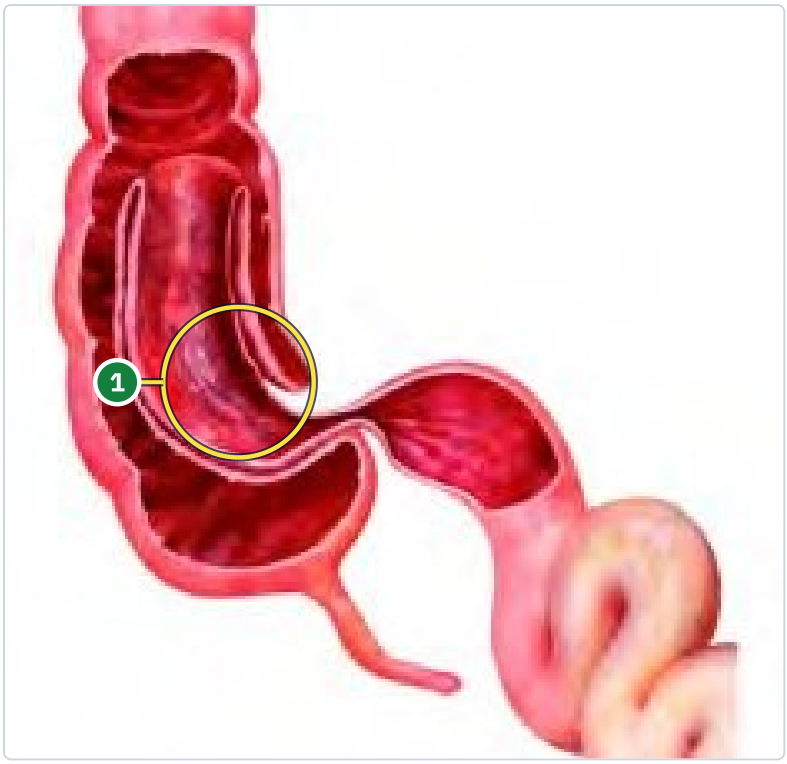


Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 155

QUÉ TIENES QUE VER

1 Segmento invaginado

DIAGNÓSTICO

Invaginación: el intestino como un telescopio

Un segmento se mete dentro del siguiente.

CONDUCTA INICIAL

Ecografía confirma; reducción neumática de primera línea.

2.01.2.019 Obstrucción intestinal — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Vólvulo: torsión del mesenterio.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 111 Tema 6.3

Clase 6.3 en video

96 TEMA 6.3 · CIRUGÍA PEDIÁTRICA DIGESTIVA

IMAGEN RADIOLÓGICA

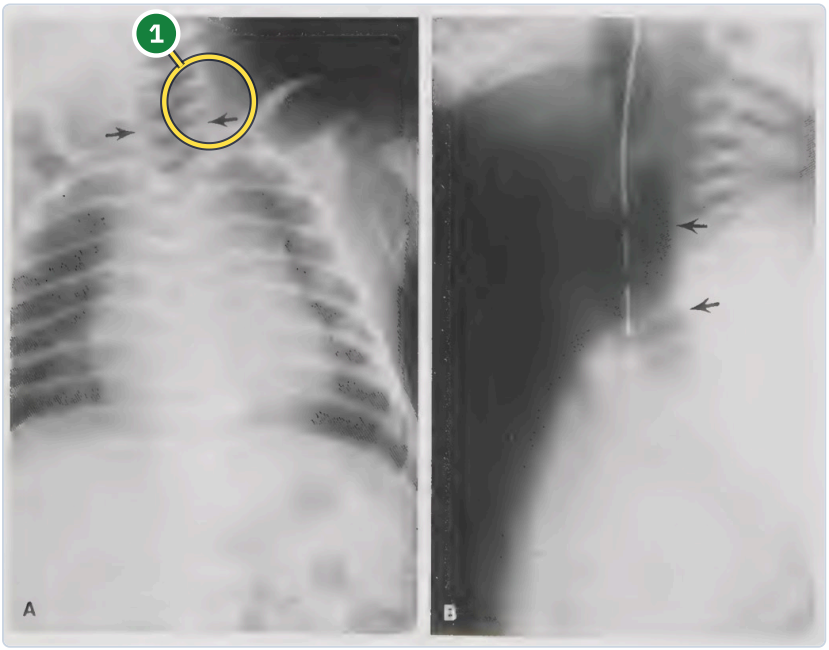


Imagen: Fundamentals of Diagnostic Radiology (Brant and Helms), p. 1330

QUÉ TIENES QUE VER

1 Sonda enrollada (flechas)

DIAGNÓSTICO

Atresia esofágica

Sonda nasogástrica enrollada en el bolsón esofágico.

CONDUCTA INICIAL

Sialorrea y sonda que no pasa: cirugía.

2.01.1.133 Malformaciones congénitas más frecuentes — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Reflujo: la sonda pasa al estómago.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 111 Tema 6.3

Clase 6.3 en video

97 TEMA 6.3 · CIRUGÍA PEDIÁTRICA DIGESTIVA

IMAGEN RADIOLÓGICA

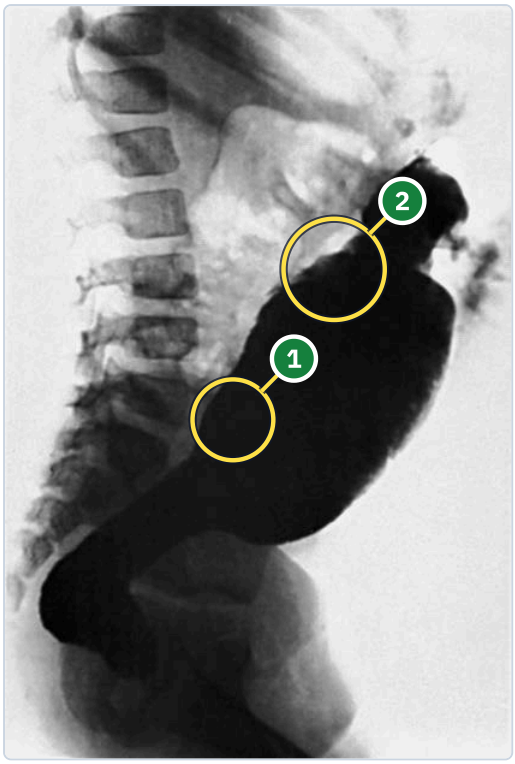


Imagen: Nelson 22.ª ed., p. 2962

QUÉ TIENES QUE VER

1. Zona de transición
2. Colon dilatado proximal

DIAGNÓSTICO

Enfermedad de Hirschsprung: zona de transición

Segmento distal estrecho, zona de transición en cono y colon dilatado arriba.

CONDUCTA INICIAL

Meconio > 48 h: biopsia rectal por succión.

4.01.1.012	Megacolon	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
2.01.2.019	Obstrucción intestinal	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Constipación funcional: sin retraso del meconio.

PREGUNTA REAL — **Diciembre 2019 · P112** «Un recién nacido de término, de 5 días de vida, aún no ha eliminado meconio. Además, presenta irritabilidad, vómitos postprandiales frecuentes y…» → **Biopsia por succión**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 111 Tema 6.3

Clase 6.3 en video

98 TEMA 6.4 · TRAUMA ABDOMINAL Y TORÁCICO

ECOGRAFÍA

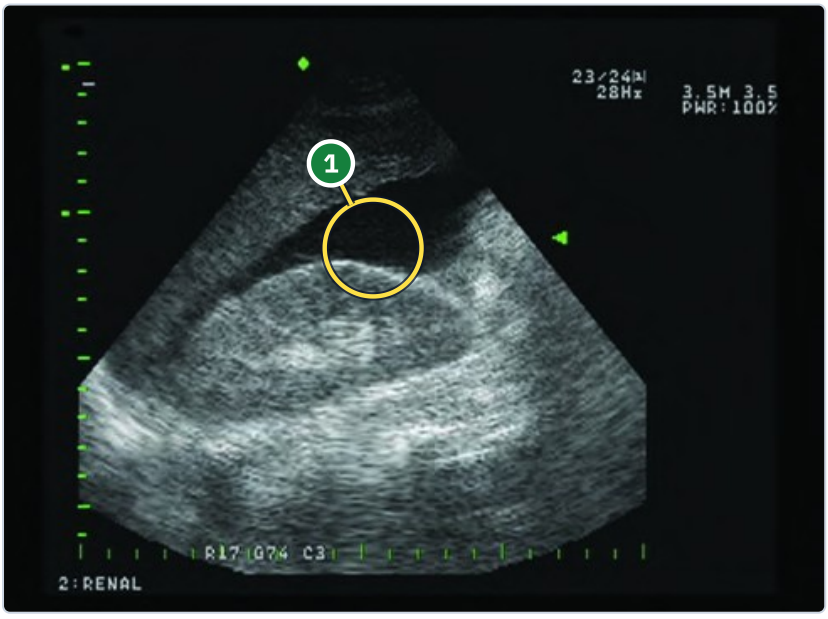


Imagen: ATLS 10.ª ed., p. 144

QUÉ TIENES QUE VER

1. Líquido en el espacio de Morison

DIAGNÓSTICO

Eco FAST positiva

Línea negra entre el hígado y el riñón: líquido libre.

CONDUCTA INICIAL

Inestable con FAST positiva: laparotomía.

4.01.2.010	Trauma abdominal abierto y cerrado	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

FAST negativa en estable: observación.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 114 Tema 6.4

Clase 6.4 en video

99 TEMA 6.4 · TRAUMA ABDOMINAL Y TORÁCICO

IMAGEN RADIOLÓGICA

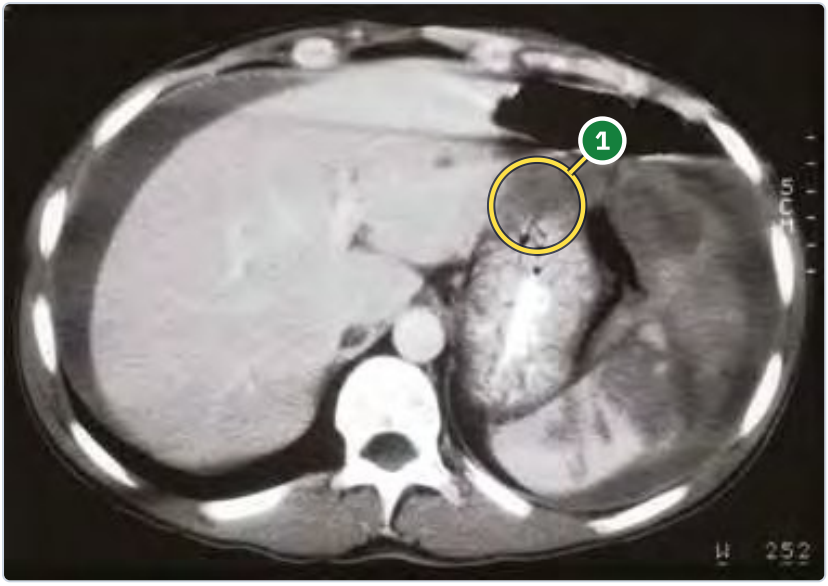


Imagen: Manual CTO Cirugía 14.ª ed., p. 69

QUÉ TIENES QUE VER

1 Bazo roto con hematoma

DIAGNÓSTICO

Rotura esplénica

Desestructuración del bazo con hematoma periesplénico.

CONDUCTA INICIAL

Estable: manejo conservador; lo que decide la cirugía es la estabilidad.

4.01.2.010 **Trauma abdominal abierto y cerrado**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Lesión hepática: mismo principio de manejo.

PREGUNTA REAL

Julio 2015 · P31 «Un paciente sufre una herida por arma blanca en el abdomen, hace 8 horas. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con signos…» → **Realizar laparoscopía exploradora**

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 114** Tema 6.4

Clase 6.4 en video

100 TEMA 6.4 · TRAUMA ABDOMINAL Y TORÁCICO

IMAGEN RADIOLÓGICA

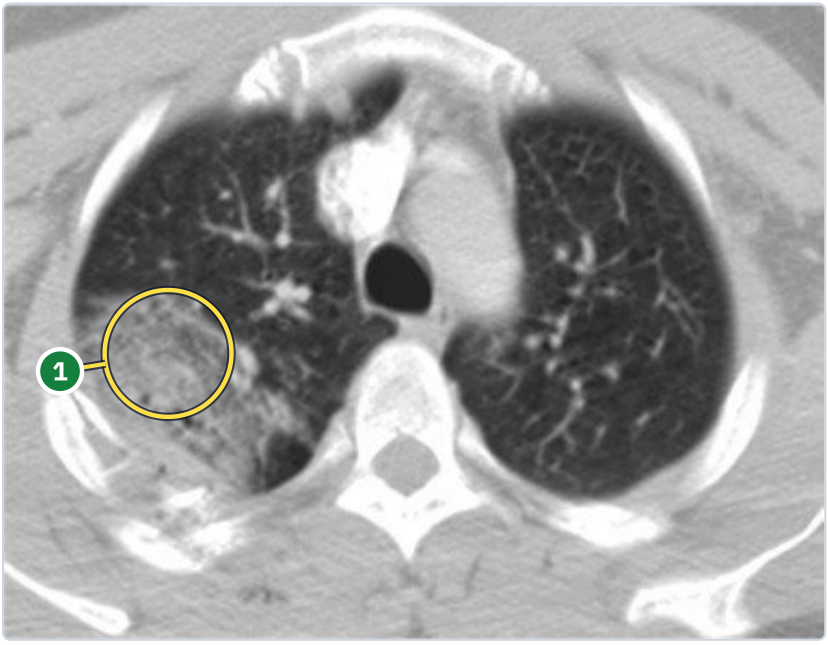


Imagen: Herring, Learning Radiology, 4.ª ed., p. 359

QUÉ TIENES QUE VER

1 Contusión pulmonar

DIAGNÓSTICO

Contusión pulmonar en la TAC de tórax

Opacidad en vidrio esmerilado y consolidación tras el trauma.

CONDUCTA INICIAL

Oxígeno, analgesia y control; puede empeorar en 24–48 horas.

4.01.2.016 **Traumatismo torácico grave**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Neumonía: fiebre, sin antecedente de trauma.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO GASTROENTEROLOGÍA **p. 114** Tema 6.4

Clase 6.4 en video

101 TEMA 6.4 · TRAUMA ABDOMINAL Y TORÁCICO

ECOGRAFÍA

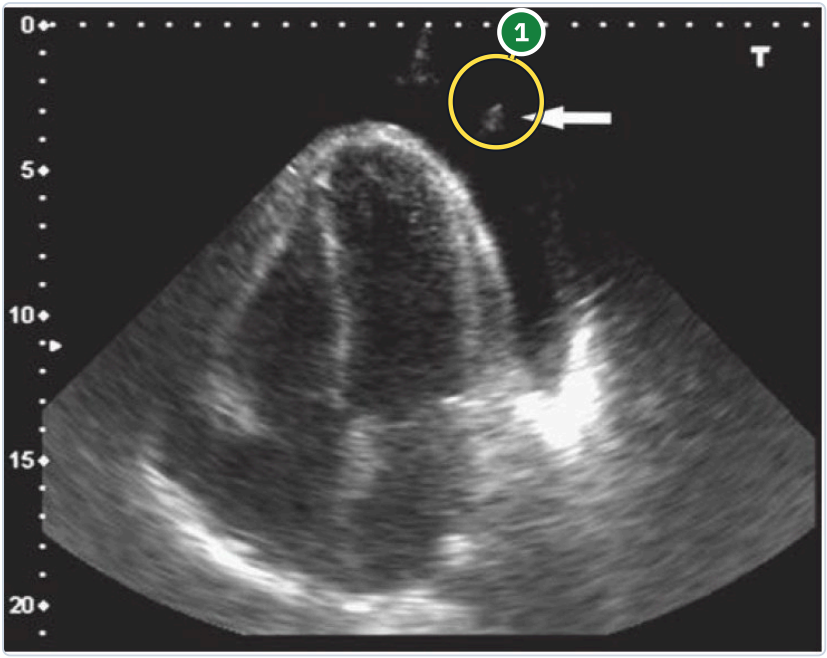


Imagen: Pocket Atlas of Emergency Ultrasound (Reardon, Ma), p. 388

QUÉ TIENES QUE VER

1 Líquido pericárdico (flecha)

DIAGNÓSTICO

Taponamiento cardíaco en trauma

Derrame pericárdico en la ventana subxifoidea.

CONDUCTA INICIAL

Pericardiocentesis descomprime, pero en trauma la fuente se resuelve con toracotomía.

4.01.2.016 Traumatismo torácico grave — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Derrame pleural.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 114 Tema 6.4

Clase 6.4 en video

102 TEMA 6.4 · TRAUMA ABDOMINAL Y TORÁCICO

ECOGRAFÍA

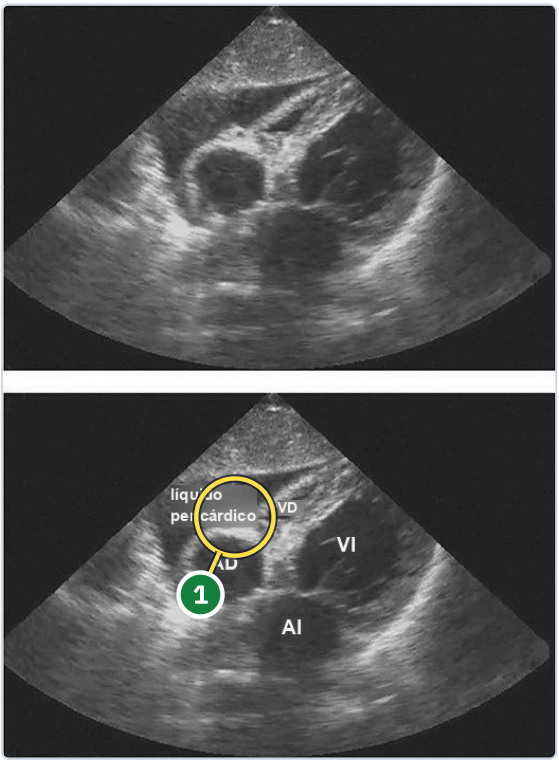


Imagen: Knoop, Atlas of Emergency Medicine, p. 185

QUÉ TIENES QUE VER

1 Líquido pericárdico

DIAGNÓSTICO

Derrame pericárdico en la ecografía

Líquido negro alrededor del corazón.

CONDUCTA INICIAL

Con shock: pericardiocentesis o ventana pericárdica urgente.

4.01.2.016 Traumatismo torácico grave — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Derrame pleural: líquido fuera del pericardio.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

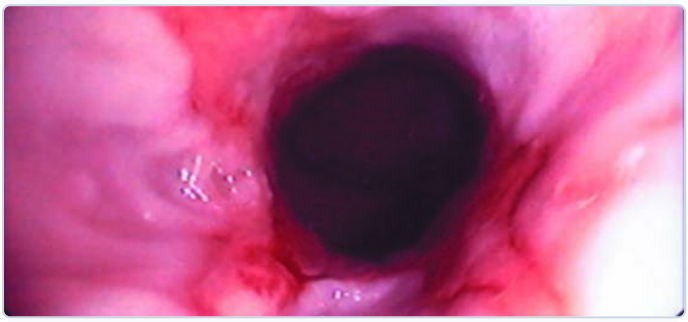
TOMO GASTROENTEROLOGÍA p. 114 Tema 6.4

Clase 6.4 en video

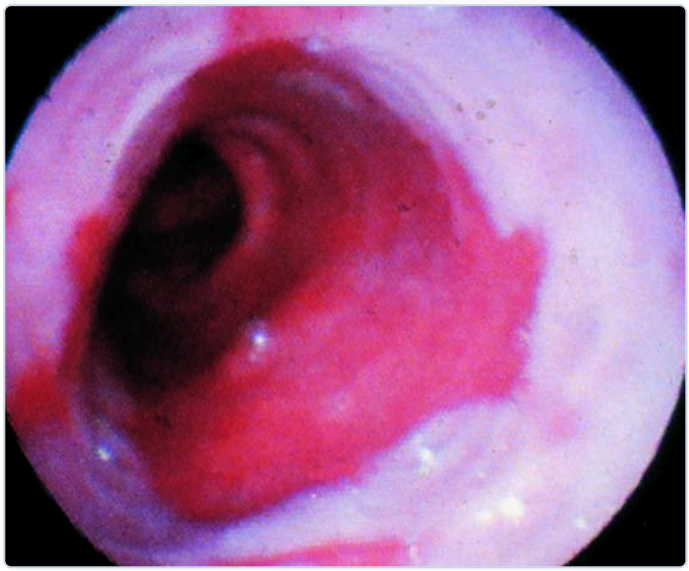
Parecidas pero distintas

Las mismas fotos de las fichas, lado a lado y sin marcadores: primero intenta decir cuál es cuál.

PARECIDAS PERO DISTINTAS Esofagitis erosiva vs Barrett



VS



A Esofagitis erosiva por reflujo

- Erosiones lineales rojas
- Daño agudo del ácido

Ficha n.° 01 · p. 4

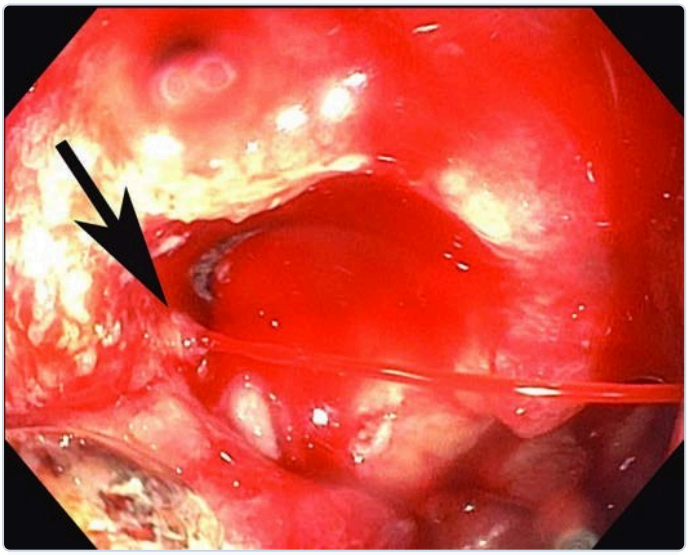
B Esófago de Barrett

- Lengüetas color salmón
- Metaplasia intestinal

Ficha n.° 03 · p. 5

LA DIFERENCIA Barrett se confirma con biopsia; la conducta la decide la displasia.

PARECIDAS PERO DISTINTAS Mallory-Weiss vs Boerhaave



VS



A Síndrome de Mallory-Weiss

- Desgarro solo de la mucosa
- Hematemesis

Ficha n.° 12 · p. 9

B Síndrome de Boerhaave

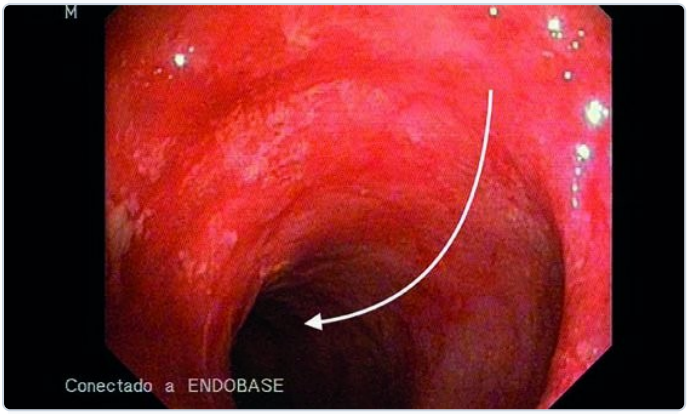
- Perforación transmural
- Aire en el mediastino

Ficha n.° 14 · p. 10

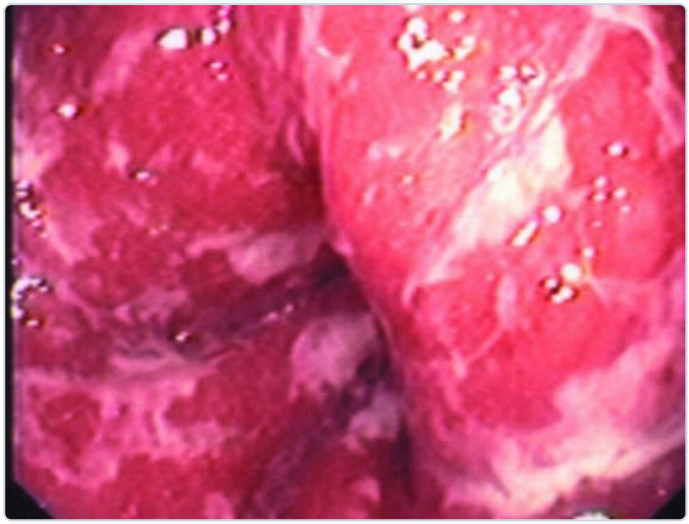
LA DIFERENCIA Vómitos y luego sangre: Mallory-Weiss; vómitos y luego dolor con enfisema: Boerhaave.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Colitis ulcerosa vs Crohn



VS



A Colitis ulcerosa

- Continua desde el recto
- Solo mucosa

Ficha n.º 32 · p. 19

B Enfermedad de Crohn

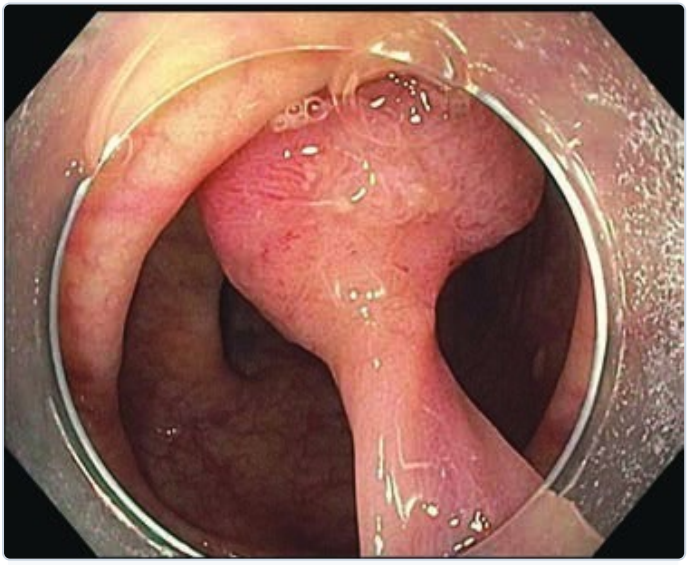
- En parches, empedrado
- Transmural, íleon

Ficha n.º 33 · p. 20

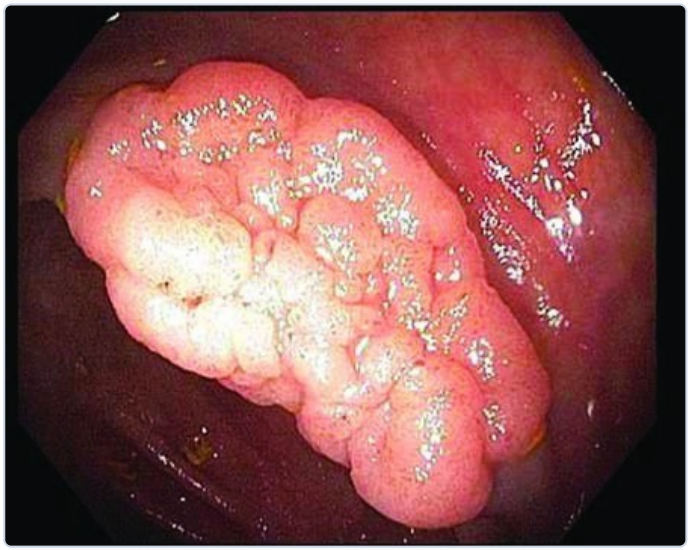
LA DIFERENCIA Basta una característica de Crohn (íleon, fístula, parches, perianal) para diagnosticarlo.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Pólipo pediculado vs sésil



VS



A Pólipo pediculado

- Cabeza sobre un tallo
- Fácil de resecar

Ficha n.º 39 · p. 23

B Pólipo sésil

- Base ancha
- Más riesgo de degenerar

Ficha n.º 40 · p. 23

LA DIFERENCIA Ambos se resecan: resecar adenomas es prevenir cáncer.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Hemorroide trombosado vs absceso perianal



VS



A Hemorroide externo trombosado

- Nódulo violáceo
- Dolor súbito

Ficha n.° 47 · p. 27

B Absceso perianal

- Tumefacción roja fluctuante
- Dolor que aumenta día a día

Ficha n.° 49 · p. 28

LA DIFERENCIA El absceso se drena en pabellón; el hemorroide se trata con baños de asiento.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Cálculo vs pólipo vesicular



VS



A Colelitiasis

- Sombra acústica
- Móvil

Ficha n.° 69 · p. 38

B Pólipo vesicular

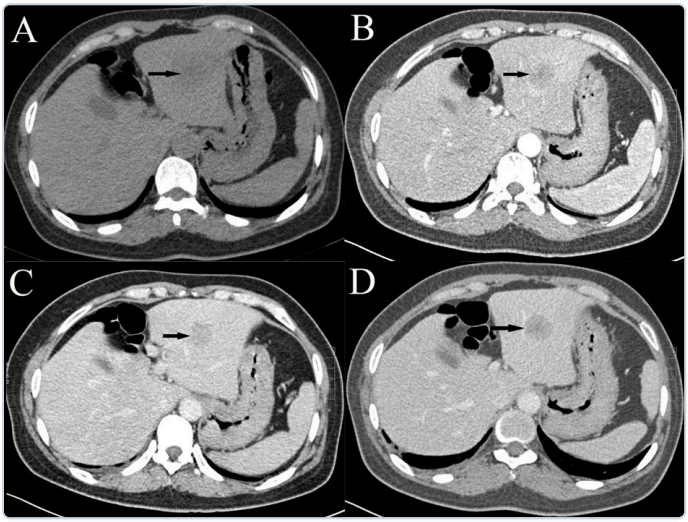
- Sin sombra
- Fijo a la pared

Ficha n.° 67 · p. 37

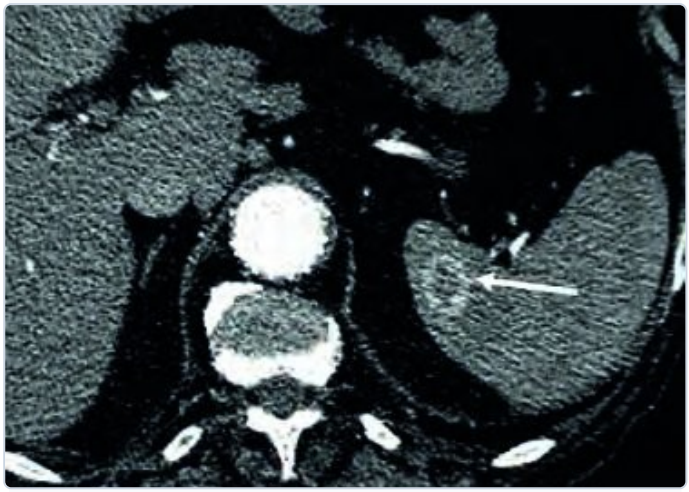
LA DIFERENCIA La sombra acústica es del cálculo.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Hepatocarcinoma vs hemangioma



VS



A Hepatocarcinoma en TAC trifásico

- Realce arterial y lavado
- Hígado cirrótico, AFP alta

Ficha n.º 63 · p. 35

B Hemangioma hepático

- Realce periférico en glóbulos
- Se llena hacia el centro

Ficha n.º 62 · p. 34

LA DIFERENCIA El lavado en fase portal es del hepatocarcinoma.

Signos con nombre propio

Lo que el examen nombra con un epónimo o una imagen: qué es, en qué enfermedad aparece y dónde está en el tomo.

PICO DE PÁJARO

sin foto en el atlas

Esófago dilatado que termina en una punta fina en el esofagograma.
Se ve en: Acalasia.

Tomo p. 14

SIGNO DE GREY TURNER



Equimosis en los flancos.
Se ve en: Pancreatitis hemorrágica.

Tomo p. 80 · Atlas: ficha n.° 75, p. 41

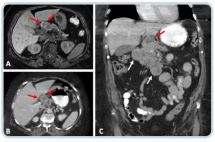
CABEZA DE MEDUSA



Venas dilatadas periumbilicales.
Se ve en: Hipertensión portal.

Tomo p. 66 · Atlas: ficha n.° 59, p. 33

SIGNO DE COURVOISIER-TERRIER



Vesícula palpable no dolorosa con ictericia.
Se ve en: Cáncer de páncreas o periampular.

Tomo p. 61 · Atlas: ficha n.° 54, p. 30

TRÍADA DE CHARCOT

sin foto en el atlas

Dolor, fiebre e ictericia.
Se ve en: Colangitis aguda.

Tomo p. 77

SIGNO DE MURPHY



Detención de la inspiración al palpar el hipocondrio derecho.
Se ve en: Colecistitis aguda.

Tomo p. 77 · Atlas: ficha n.° 71, p. 39

PUNTO DE MCBURNEY



Dolor en la unión del tercio externo con los dos tercios internos de la línea ombligo-EIAS.
Se ve en: Apendicitis aguda.

Tomo p. 87 · Atlas: ficha n.° 76, p. 41

SIGNO DE ROVSING



Presionar la fosa ilíaca izquierda duele en la derecha.
Se ve en: Apendicitis aguda.

Tomo p. 87 · Atlas: ficha n.° 76, p. 41

SIGNO DE BLUMBERG

sin foto en el atlas

Dolor al descomprimir bruscamente.
Se ve en: Irritación peritoneal.

Tomo p. 88

DOBLE BURBUJA

sin foto en el atlas

Aire en el estómago y el duodeno sin aire distal.
Se ve en: Atresia duodenal.

Tomo p. 111

Signos con nombre propio · continuación



SIGNO DE LA DONA

Imagen en diana en la ecografía.

Se ve en: Invaginación intestinal.

Tomo p. 111 · Atlas: ficha n.° 94, p. 50

SIGNO DE RIGLER

sin foto en el atlas

Se ven ambos bordes de la pared intestinal.

Se ve en: Neumoperitoneo.

Tomo p. 110

MERMELADA DE GROSELLA

sin foto en el atlas

Deposición con sangre y mucosidad.

Se ve en: Invaginación intestinal.

Tomo p. 111

Índice por tipo de imagen

17	5	7	37	1	12
FOTO CLÍNICA	HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA	ESQUEMA	IMAGEN RADIOLÓGICA	TRAZADO (ECG / REGISTRO)	ECOGRAFÍA

21	2
ENDOSCOPÍA	PIEZA ANATÓMICA

Foto clínica · 17

30 Dermatitis herpetiforme (2.3) 18
35 Eritema nodoso (2.4) 21
36 Pioderma gangrenoso (2.4) 21
37 Eritema nodoso en la EII (2.4) 22
38 Pioderma gangrenoso (2.4) 22
44 Fisura anal (2.6) 25
45 Prolapso hemorroidal grado IV (2.6) 26
46 Hemorroide externo trombosado (2.6) 26
47 Hemorroide externo trombosado (2.6) 27
48 Absceso perianal (2.6) 27
49 Absceso perianal (2.6) 28
50 Ictericia escleral (3.1) 28
53 Ictericia escleral (3.1) 30
59 Cabeza de medusa (3.3) 33
75 Signo de Grey Turner (4.2) 41
87 Signo del pliegue (6.1) 47
88 Signo del pliegue persistente (6.1) 47

Histología / citología · 5

27 Trofozoítos de Giardia (2.2) 17
28 Huevo de Ascaris (2.2) 17
29 Huevo de tricocéfalo (2.2) 18
31 Atrofia vellositaria (enfermedad celíaca) (2.3) 19
89 Huevos de oxiuros (6.1) 48

Esquema · 7

17 Esquema de Borrmann (1.5) 12
21 Compartimentos del mediastino (1.6) 14
55 Hepatitis B aguda: marcadores en el tiempo (3.2) 31
70 Vesícula con cálculos (4.1) 38
76 Apendicitis: puntos y signos del examen (5.1) 41
90 Estenosis hipertrófica del píloro (6.2) 48
95 Invaginación: el intestino como un telescopio (6.3) 51

Imagen radiológica · 37

07 Megaesófago chagásico (1.3) 7
09 Divertículo de Zenker (1.3) 8
10 Divertículo de Zenker en el esofagograma (1.3) 8
11 Neumoperitoneo (1.4) 9
14 Síndrome de Boerhaave (1.4) 10
15 Neumoperitoneo bajo el diafragma (1.4) 11
18 Tumor de músculo liso gástrico (estudio baritado) (1.5) 12
20 Hernia hiatal paraesofágica (1.6) 13
22 Masa del mediastino anterior (1.6) 14
23 Hernia diafragmática traumática (1.6) 15
24 Masa mediastínica anterior en la TAC (1.6) 15
25 Masa mediastínica en el PET-CT (1.6) 16
34 Crohn: íleon terminal engrosado (2.4) 20
52 Coledocolitiasis en colangiorresonancia (3.1) 29
54 Cáncer de la cabeza del páncreas (3.1) 30
58 Portografía: colaterales (3.3) 32
62 Hemangioma hepático (3.4) 34
63 Hepatocarcinoma en TAC trifásico (3.4) 35
64 Absceso hepático (3.4) 35
65 Hiperplasia nodular focal (3.4) 36
66 Metástasis hepáticas (3.4) 36
68 Colangiocarcinoma hiliar (Klatskin) (3.4) 37
72 Vesícula en porcelana (4.1) 39
73 Pancreatitis edematosa en la TAC (4.2) 40
74 Pancreatitis aguda edematosa (4.2) 40
77 Apendicitis aguda en TAC (5.1) 42
79 Trombosis venosa mesentérica (5.2) 43
80 Colitis isquémica: «huellas digitales» (5.2) 43
81 Embolia de la arteria mesentérica superior (5.2) 44
84 Moneda en el esófago (5.4) 45
85 Pila de botón ingerida (5.4) 46
92 Fecaloma en un niño (6.2) 49
93 Neumatosis intestinal (enterocolitis necrotizante) (6.3) 50
96 Atresia esofágica (6.3) 51
97 Enfermedad de Hirschsprung: zona de transición (6.3) 52
99 Rotura esplénica (6.4) 53
100 Contusión pulmonar en la TAC de tórax (6.4) 53

Trazado (ECG / registro) · 1

08 Manometría de alta resolución: acalasia (1.3) 7

Ecografía · 12

51 Colédoco dilatado por coledocolitiasis (3.1) 29
56 Esteatosis hepática (3.2) 31
57 Cirrosis en la ecografía (3.3) 32
61 Quiste hidatídico hepático (3.4) 34
67 Pólipo vesicular (3.4) 37
69 Colelitiasis (4.1) 38
71 Colecistitis aguda (4.1) 39
91 Ecografía: oliva pilórica (6.2) 49
94 Invaginación intestinal: signo de la dona (6.3) 50
98 Eco FAST positiva (6.4) 52
101 Taponamiento cardíaco en trauma (6.4) 54
102 Derrame pericárdico en la ecografía (6.4) 54

Endoscopía · 21

01 Esofagitis erosiva por reflujo (1.1) 4
02 Esofagitis erosiva (1.1) 4
03 Esófago de Barrett (1.1) 5
04 Úlcera duodenal con mancha pigmentada (1.2) 5
05 Úlcera gástrica (Forrest IIc) (1.2) 6
06 Cáncer de esófago distal (1.3) 6
12 Síndrome de Mallory-Weiss (1.4) 9
13 Esofagitis cáustica (1.4) 10
16 Cáncer gástrico avanzado: Borrmann I a IV (1.5) 11
19 Cáncer gástrico incipiente (1.5) 13
26 Colitis pseudomembranosa (C. difficile) (2.2) 16
32 Colitis ulcerosa (2.4) 19
33 Enfermedad de Crohn (2.4) 20
39 Pólipo pediculado (2.5) 23
40 Pólipo sésil (2.5) 23
41 Pólipo pediculado en la colonoscopía (2.5) 24
42 Cáncer colorrectal en la colonoscopía (2.5) 24
60 Várice esofágica con ligadura (3.3) 33
82 Úlcera con vaso visible (Forrest IIa) (5.3) 44
83 Úlcera con sangrado activo (Forrest Ia) (5.3) 45
86 Bolo de carne impactado (5.4) 46

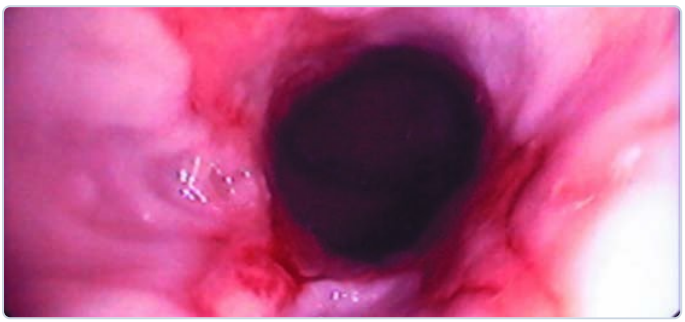
Pieza anatómica · 2

43 Poliposis adenomatosa familiar (pieza) (2.5) 25
78 Apendicitis flemonosa (pieza) (5.1) 42

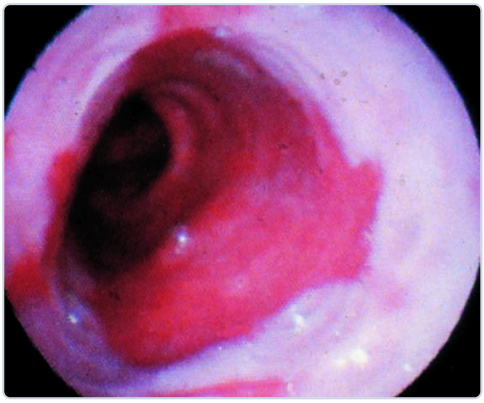
Autoevaluación

33 fotos de las fichas, sin marcadores ni rótulos. Escribe el diagnóstico y el hallazgo que lo confirma; las soluciones están al final.

1 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



2 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



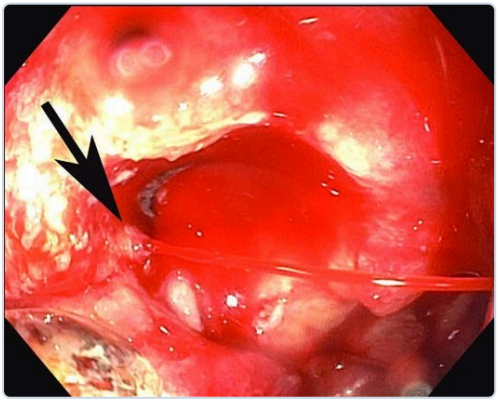
3 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



4 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



5 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



6 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



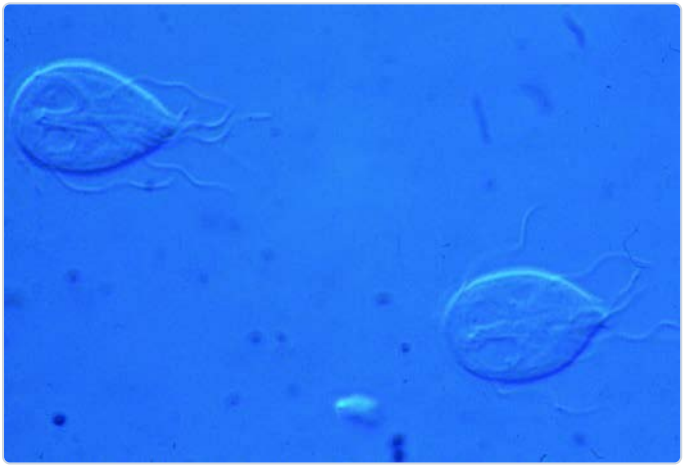
7 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



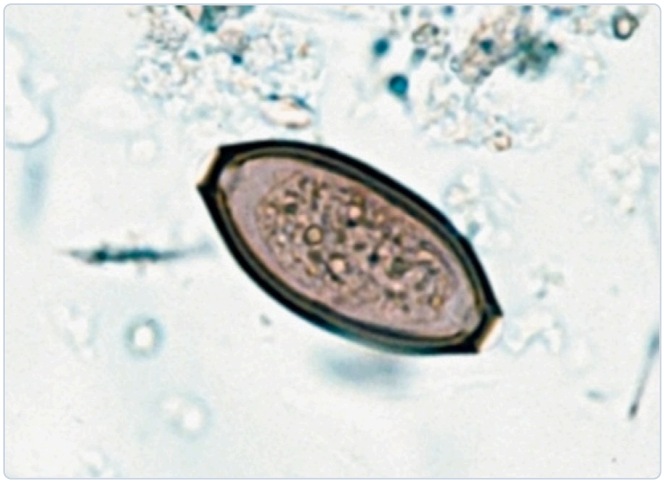
8 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



9 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



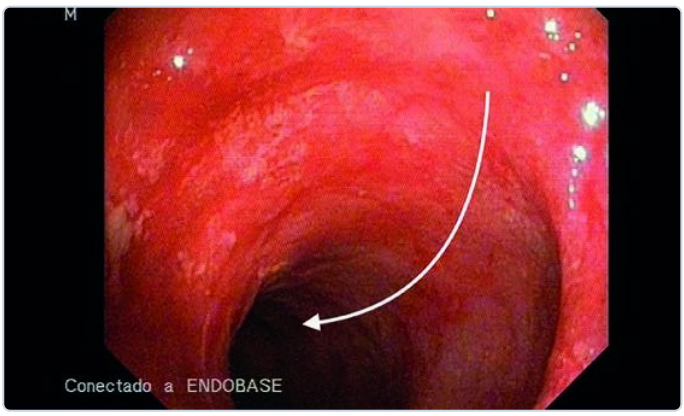
10 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



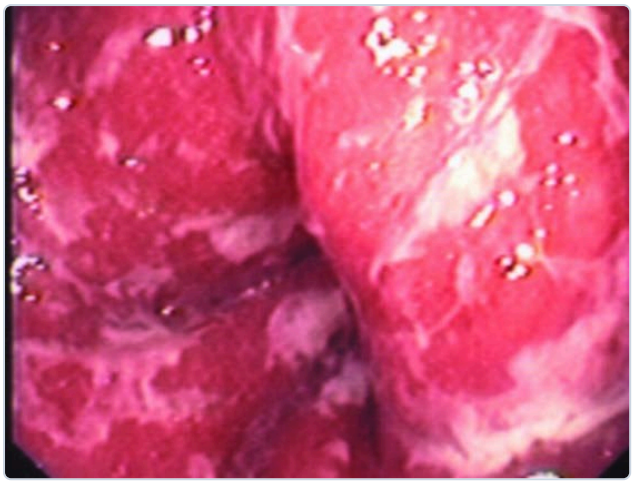
11 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



12 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



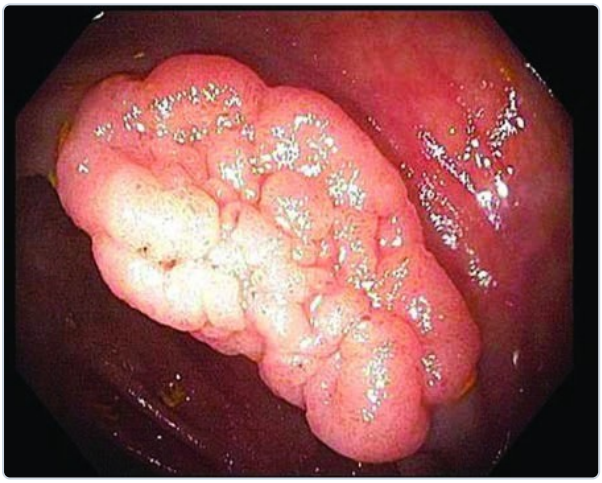
13 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



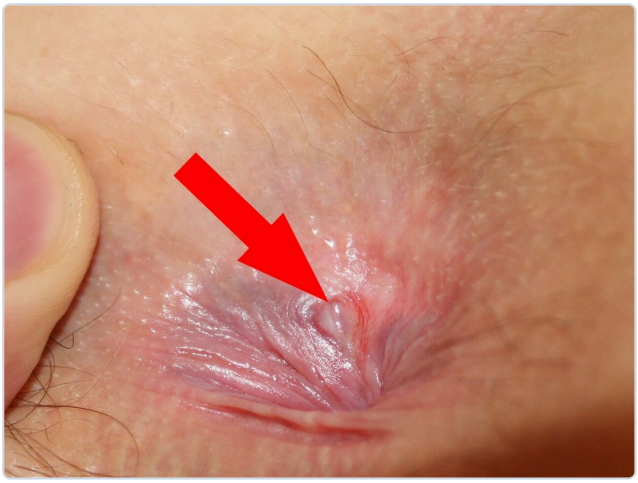
14 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



15 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



16 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



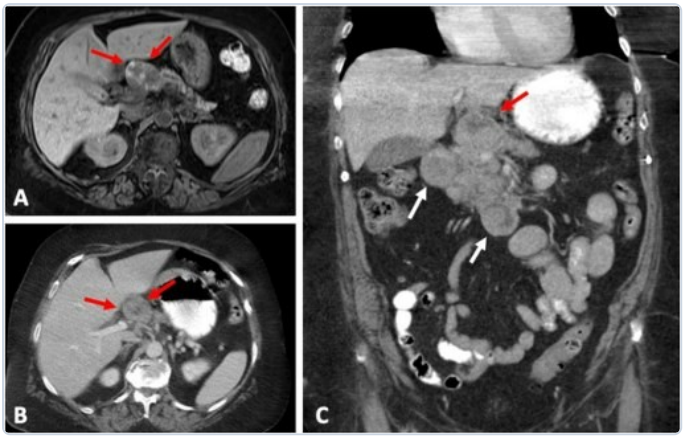
17 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



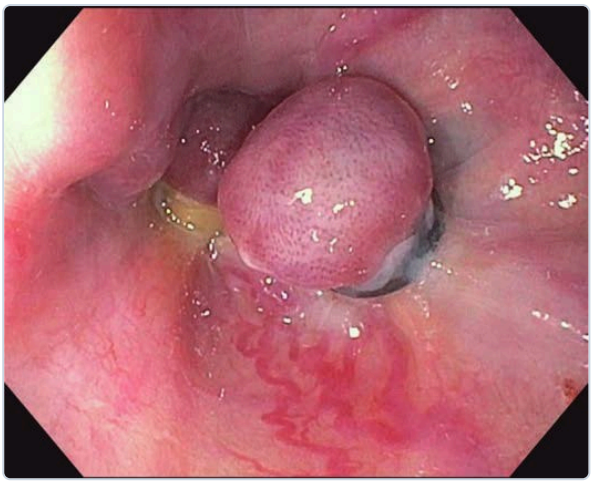
18 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



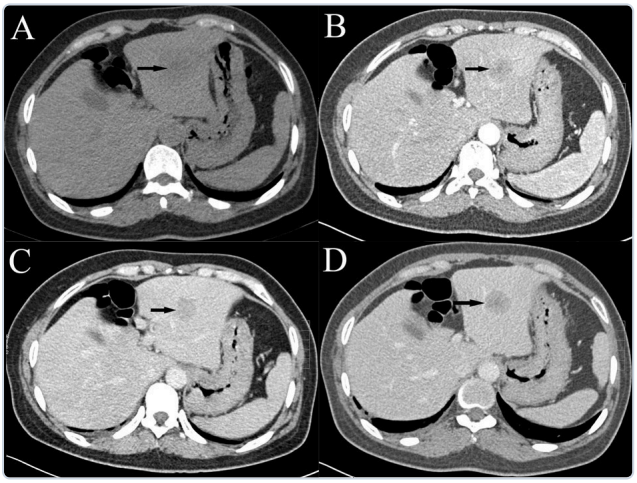
19 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



20 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



21 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



22 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



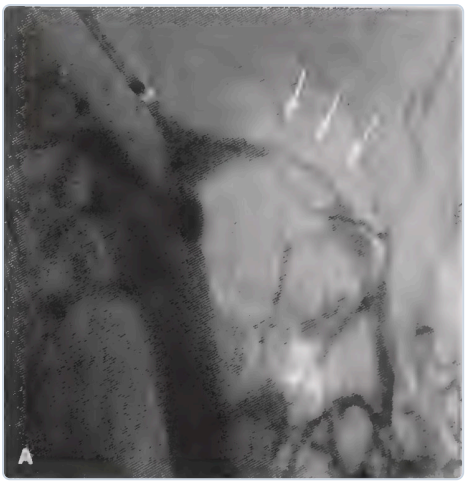
23 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



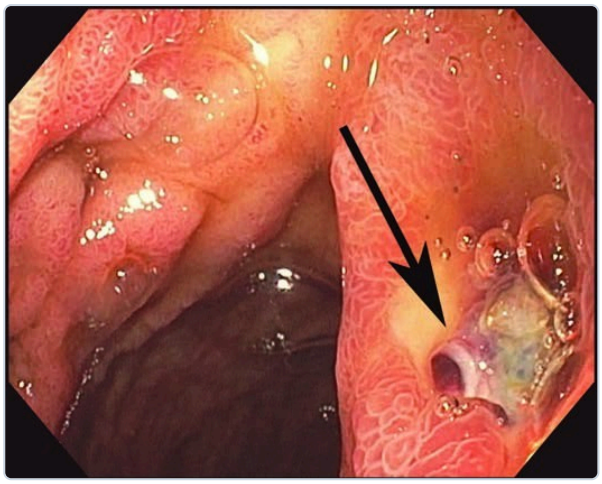
24 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



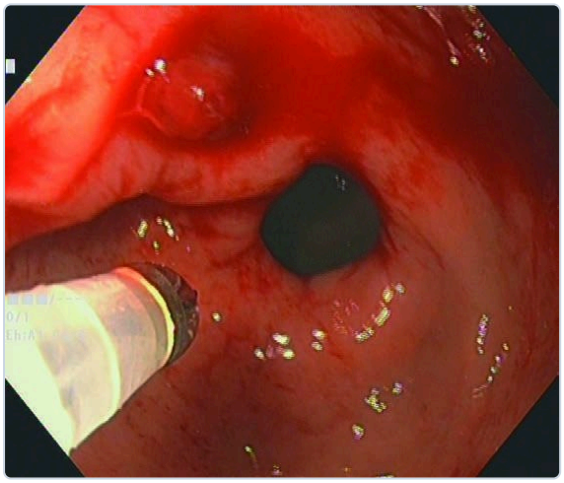
25 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



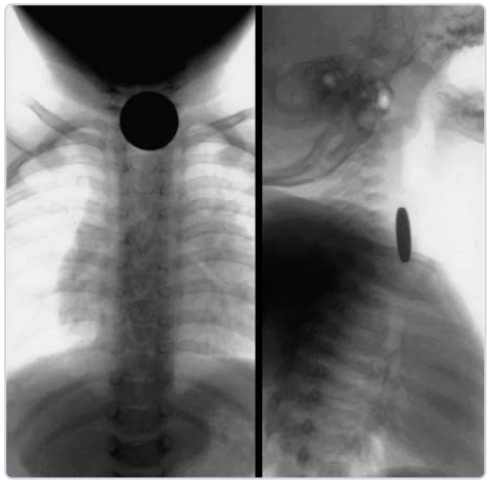
26 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



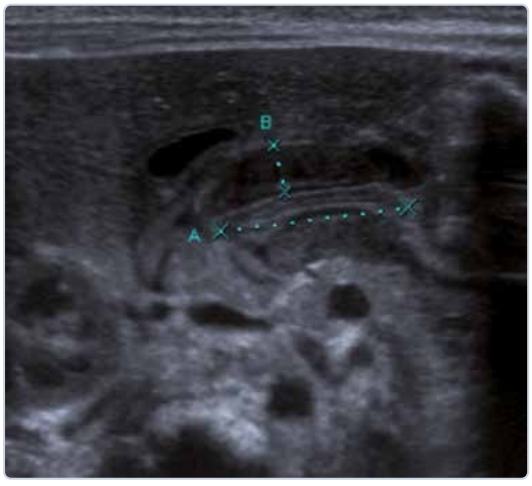
27 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



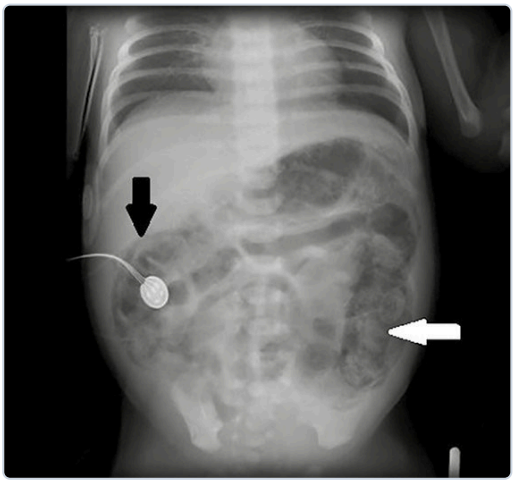
28 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



29 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



30 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



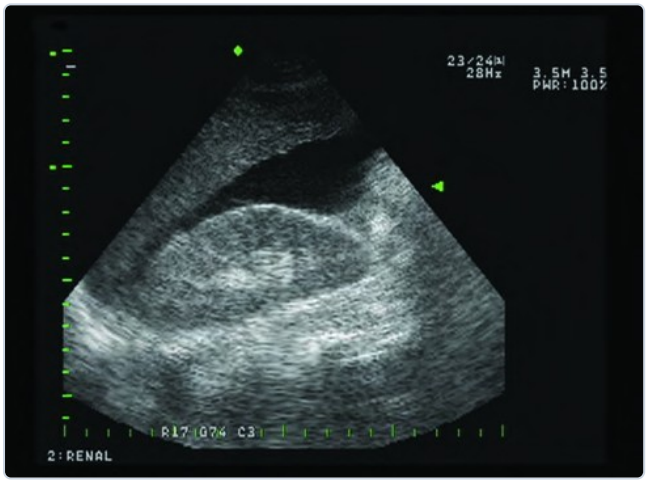
31 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



32 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



33 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



Soluciones de la autoevaluación

N.º	DIAGNÓSTICO	LO QUE LO CONFIRMA	FICHA
1	**Esofagitis erosiva por reflujo**	Erosiones lineales en el esófago distal	01 · p. 4
2	**Esófago de Barrett**	Lengüeta salmón	03 · p. 5
3	**Cáncer de esófago distal**	Masa ulcerada que estrecha la luz	06 · p. 6
4	**Divertículo de Zenker**	Saco del divertículo con bario	09 · p. 8
5	**Síndrome de Mallory-Weiss**	Desgarro mucoso (flecha)	12 · p. 9
6	**Neumoperitoneo bajo el diafragma**	Aire bajo el hemidiafragma derecho	15 · p. 11
7	**Masa del mediastino anterior**	Masa anterior a los grandes vasos	22 · p. 14
8	**Colitis pseudomembranosa (C. difficile)**	Pseudomembranas amarillentas	26 · p. 16
9	**Trofozoítos de Giardia**	Trofozoíto piriforme con flagelos	27 · p. 17
10	**Huevo de tricocéfalo**	Tapones polares	29 · p. 18
11	**Dermatitis herpetiforme**	Lesiones agrupadas en el codo	30 · p. 18
12	**Colitis ulcerosa**	Mucosa roja, granular y continua	32 · p. 19
13	**Enfermedad de Crohn**	Úlceras con fibrina	33 · p. 20
14	**Pioderma gangrenoso**	Borde violáceo socavado	36 · p. 21
15	**Pólipo sésil**	Pólipo de base ancha	40 · p. 23
16	**Fisura anal**	Desgarro lineal (flecha)	44 · p. 25
17	**Hemorroide externo trombosado**	Nódulo violáceo trombosado	47 · p. 27
18	**Ictericia escleral**	Escleras amarillas	53 · p. 30
19	**Cáncer de la cabeza del páncreas**	Masa en la cabeza pancreática	54 · p. 30
20	**Várice esofágica con ligadura**	Várice ligada	60 · p. 33
21	**Hepatocarcinoma en TAC trifásico**	Lesión que capta en arterial (A)	63 · p. 35
22	**Metástasis hepáticas**	Lesiones hipodensas múltiples	66 · p. 36
23	**Colelitiasis**	Cálculo hiperecogénico	69 · p. 38
24	**Signo de Grey Turner**	Equimosis en el flanco	75 · p. 41
25	**Embolia de la arteria mesentérica superior**	Defecto de llene en la AMS	81 · p. 44
26	**Úlcera con vaso visible (Forrest IIa)**	Vaso visible (flecha)	82 · p. 44
27	**Úlcera con sangrado activo (Forrest Ia)**	Sangrado activo	83 · p. 45
28	**Moneda en el esófago**	Disco de frente	84 · p. 45
29	**Ecografía: oliva pilórica**	Músculo pilórico engrosado (marcas)	91 · p. 49
30	**Neumatosis intestinal (enterocolitis necrotizante)**	Neumatosis (flechas)	93 · p. 50
31	**Invaginación intestinal: signo de la dona**	Imagen en diana	94 · p. 50
32	**Enfermedad de Hirschsprung: zona de transición**	Zona de transición	97 · p. 52
33	**Eco FAST positiva**	Líquido en el espacio de Morison	98 · p. 52